

Maladies infectieuses

L'infection est :

- A. une maladie infectieuse humaine fébrile, causée par un parasite
- B. Ensemble des manifestations biologiques résultant de la pénétration du micro-organisme pathogène vivant dans l'organisme humain.
- C. ensemble des méthodes qui préserve contre la souillure des microbes tout ce qui est en contact avec la plaie opératoire
- D. Ensemble des manifestations cliniques résultant de la pénétration du micro-organisme pathogène vivant dans l'organisme humain.

Le processus de l'infection s'explique par : Choisir la ou les bonnes réponses

- A. présente des manifestations cliniques
- B. présence des manifestations immuno-allergiques
- C. présence de manifestations biologiques
- D. découverte de germes pathogènes au cours d'un examen biologique.

Les agents responsables des maladies infectieuses sont :

- A. Bactéries,
- B. virus,
- C. parasites,
- D. champignons

Cochez les associations suivantes entre les maladies et l'agent responsable:

1-Fièvre typhoïde

2-Hépatite B

3-SIDA

4-Fièvre jaune

5-choléra

a-Bactéries

b-Virus

c-parasites,

d-champignons

- A. (1, a) B. (5, d) C. (3, b) D. (4, b) E. (2, c).

Le pouvoir pathogène d'un germe est :

- A. La capacité d'un germe à provoquer une maladie
- B. La propriété qu'ont les germes à se multiplier et à résister à la phagocytose
- C. La fabrication anticorps lorsqu'une substance étrangère est introduit dans le corps.
- D. L'attitude de certains germes à fabriquer des toxines

Le ou les facteurs qui soutiennent le pouvoir pathogène d'un germe sont :

- A. Virulence B. Toxicité C. Sécrétion d'enzyme
- B. Pouvoir antigénique E. Pouvoir pathogène

Les réservoirs de germe des maladies infectieuses sont constitués de :

- A. L'homme malade
- B. Le porteur sain
- C. Les animaux
- D. Le milieu naturel

La branche de la médecine qui étudie les conditions de transmission des maladies est :

- A. La Physiologie
- B. La Démographie
- C. L'Anthropologie
- D. L'Epidémiologie
- E. L'Anatomie

Les modes de transmission des maladies infectieuses sont :

- A. Transmission directe
- B. Transmission indirecte

La transmission directe peut être de l'homme sain à l'homme malade :

- A. Vrai
- B. faux

La transmission directe peut être de l'animale à l'homme :

- A. Vrai
- B. Faux

La transmission indirecte se fait par l'intermédiaire :

- A. De l'eau
- B. De la Voie respiratoire
- C. Des aliments
- D. Des objets contaminés.

La porte d'entrée d'un germe est :

- A. la voie de pénétration d'un germe dans l'organisme.
- B. la période où se manifestent les premiers signes de la maladie
- C. la période de la maladie entièrement constituée

Les différentes périodes ou phases cliniques dans l'évolution d'une maladie infectieuse est constituées de :

- A. Incubation
- B. écouvillonnage
- C. invasion
- D. évasion
- E. Période d'état

L'incubation est :

- A. La période de l'apparition des premiers signes. Période tout à fait anonyme, elle est de courte durée et est marquée par la fièvre et des courbatures. On parle de syndrome pseudo-grippal
- B. La période qui s'étend du jour de la pénétration du germe dans l'organisme au jour où se manifestent les premiers signes de la maladie.
- C. Au moment où tous les signes sont présents, la maladie est entièrement constituée.

L'invasion est :

- A. La période de l'apparition des premiers signes. Période tout à fait anonyme, elle est de courte durée et est marquée par la fièvre et des courbatures. On parle de syndrome pseudo-grippal
- B. La période qui s'étend du jour de la pénétration du germe dans l'organisme au jour où se manifestent les premiers signes de la maladie.
- C. Au moment où tous les signes sont présents, la maladie est entièrement constituée.

La période d'état correspond :

- A. La période qui s'étend du jour de la pénétration du germe dans l'organisme au jour où se manifestent les premiers signes de la maladie
- B. Au moment où tous les signes sont présents, la maladie est entièrement constituée.
- C. La période de l'apparition des premiers signes. Période tout à fait anonyme, elle est de courte durée et est marquée par la fièvre et des courbatures. On parle de syndrome pseudo-grippal

Fièvre typhoïde

Concernant la fièvre typhoïde, une ou plusieurs de ces affirmations sont vraies. Laquelle ou lesquelles ?

- A. Maladie infectieuse due à la salmonella typhi ou bacille d'Ebert et salmonella paratyphi A B et C
- B. maladie contagieuse liée au péril fécal, due au *Salmonella typhi* et *Salmonella paratyphi* A, B et C.
- C. maladie fréquente, grave par ses complications.
- D. maladie dont la prévention et la prise en charge a été améliorée avec l'avènement de nouveaux vaccins et antibiotiques
- E. maladie favorisée ou aggravée par pauvreté promiscuité, manque d'hygiène, Terrain
- F. Une hyperleucocytose avec polynucléaire neutrophile doit faire rechercher une perforation digestive
- G. Les anticorps anti O peuvent ne pas apparaître si le malade est traité
- H. Au premier septénaire, le diagnostic peut être affirmé sur l'existence d'anticorps anti-H
- I. L'amoxicilline seule, per os, constitue un traitement correct de la fièvre typhoïde
- J. La diarrhée est régulièrement présente au deuxième septénaire
- K. la typhoïde est une bactériémie à gram négatif
- L. dans beaucoup de pays en développement, elle est en fréquence la bactériémie n°1
- M. elle touche surtout les sujets âgés
- N. elle se présente comme une fièvre isolée avec très peu d'autres symptômes
- O. les complications principales, sont : choc septique, méningite, abcès profonds, CIVD
- P. la mortalité est aujourd'hui de l'ordre de 1%
- Q. on peut la traiter efficacement de façon brève en 3-5 jours avec des quinolones.

L'Agent pathogène de la fièvre typhoïde :

- A. SALMONELLA TYPHI ou bacille D'EBERT
- B. SALMONELLA paratyphi A
- C. SALMONELLA paratyphi B
- D. SALMONELLA paratyphi C.

Le réservoir de virus de la fièvre typhoïde est :

- A. L'Homme malade
- B. Le porteur sain
- C. Les animaux
- D. Le milieu naturel

Le mode de Transmission de la fièvre typhoïde est :

- A. Transmission directe
- B. la transmission indirecte
- C. Transmission libre

Le mode de transmission indirect se fait par :

- A. les eaux souillées
- B. les aliments souillés
- C. les mouches

Le temps d'incubation de la fièvre typhoïde varie :

- A. entre 7 et 15 jours
- B. entre 2 et 7 jours
- C. entre 15 et 25 jours
- D. selon la constitution du malade

Une personne présente des céphalées ; une insomnie, des vertiges avec épistaxis avec une température intense et constante. A quelle affection pensez-vous ?

- A. Paludisme
- B. Fièvre typhoïde
- C. Dengue
- D. Fièvre lassa

Indiquer le stade de la maladie à laquelle ces signes suivants de la fièvre typhoïde : des céphalées ; une insomnie, des vertiges avec épistaxis avec une température intense et constante apparaissent :

- A. Période d'invasion
- B. Période d'état
- C. Période d'incubation.

Indiquer la forme de la maladie ayant les signes suivants des céphalées ; une insomnie, des vertiges avec épistaxis avec une température intense et constante :

- A. Forme classique
- B. Forme atypique
- C. Pseudo grippal.

Devant la forme classique de la fièvre typhoïde, le médecin décide de faire un examen clinique approfondi. Les signes retrouvés sont :

- A. une langue saburrale
- B. Un météorisme abdominal
- C. une splénomégalie
- D. l'obnubilation

Parmi ces éléments indiquer les formes atypiques de la fièvre typhoïde ? Cochez la ou les bonnes réponses :

- a. Syndrome méningé
- b. Signes pseudo-grippal
- c. Lombalgie
- d. Infection urinaire

Un traitement efficace des fièvres typhoïdes peut être réalisé par :

- A- Pénicilline G
- B- Ampicilline
- C- Chloramphénicol
- D- Sulfaméthoxazole-triméthoprime
- E- Gentamicine

L'examen complémentaire pour confirmer la fièvre typhoïde est :

- A. test de Widal et Felix
- B. coproculture
- C. hémogramme
- D. recherche d'antigènes solubles circulants
- E. hémoculture

Un prélèvement sanguin stérile dont la culture va permettre la mise en évidence de la présence de germes aérobies et ou anaérobies :

- A. Vrai
- B. Faux

Les germes aérobies sont des germes ayant besoin d'oxygène pour se développer : A. Vrai B. Faux

Les germes anaérobies sont des germes n'ayant pas besoin d'oxygène pour se développer :

- A. Vrai
- B. Faux

Les anomalies observées habituellement à la numération formule sanguine au cours de la fièvre typhoïde se situent au niveau de :

- A. Neutropénie
- B. Lymphopénie
- C. Neutrophilie
- D. Thrombopénie
- E. Hyperéosinophilie
- F. Lymphocytose
- G. NFS subnormale

La ou les maladie(s) suivante(s) est (sont) la cause de fièvre avec leucopénie :

- A - Fièvre typhoïde
- B- Hépatite virale
- C - Leishmaniose viscérale
- D - Brucellose aiguë
- E – Erysipèle

Donner la signification du sigle CIVET :

- A. Céphalées
- B. Cyphose
- C. Insomnie
- D. Vertiges
- E. Vomissement
- F. Toux
- G. Epistaxis
- H. Inconscient
- I. Température intense et constante.

En dehors de la forme classique de la fièvre typhoïde, indiquez les autres formes de la fièvre typhoïde :

- A. Pseudo grippal
- B. Syndrome méningé
- C. Syndrome pulmonaire
- D. Une complication

Parmi les données qui suivent, indiquez celui ou ceux qui correspondent aux éléments épidémiologiques de la fièvre typhoïde :

- A. Agent vecteur

- B. Homme malade
- C. Facteurs favorisants
- D. porteur sain
- E. Mode de contamination

Indiquer les différents examens biologiques qu'un agent de santé peut demander en cas de fièvre typhoïde :

- A. examens de certitude
- B. examen de contrôle
- C. Examens d'orientation
- D. examen complémentaire

Parmi les examens suivants cocher celui qui permet la confirmation de la fièvre typhoïde :

- A. Examen clinique
- B. Examen radiologique
- C. Examens biologiques.
- D. Evolution de la maladie.

Les examens biologiques de certitude de la fièvre typhoïde sont :

- A. Examen de sang : hémoculture
- B. Examen de selles : coproculture
- C. Biologie moléculaire

Les examens biologiques d'orientation au cours du diagnostic de la fièvre typhoïde sont :

- A. Hémogramme
- B. Sérodiagnostic de Widal et Félix
- C. Hémoculture
- D. Coproculture

Les signes cliniques à la phase d'état de la fièvre typhoïde se présentent comme suit :

- A. la fièvre en plateau
- B. La diarrhée
- C. Le tufos
- D. Une splénomégalie
- E. Les signes cutanés

Les signes cliniques de la fièvre typhoïde à la phase d'état se constituent de :

- A. la fièvre en plateau dont la caractéristique est la dissociation du pouls de la température
- B. La diarrhée faite de selles liquide, fétides d'aspect jus de papaye
Le tufos qui est une prostration, une indifférence, un état d'hébétéude qui peut se traduire parfois par un délire
- C. Une splénomégalie avec rate molle
- D. Les signes cutanés qui sont des taches rosées lenticulaires et l'angine de Dugès

Les caractéristiques de la fièvre au cours de la fièvre typhoïde :

- A. la fièvre en plateau
- B. la dissociation du pouls de la température
- C. la fièvre rend le malade différent

Les caractéristiques de la diarrhée :

- A. selles liquide,

- B. selles fétides
- C. selles à aspect jus de papaye

Le typhos se caractérise par :

- A. une prostration,
- B. une indifférence,
- C. un état d'hébétéude
- D. parfois par un délire

Les caractéristiques de la rate au cours de la fièvre typhoïde sont :

- A. A augmenté de volume (splénomégalie)
- B. est molle
- C. est dure

L'atteinte cutanée au cours de la fièvre typhoïde se caractérise par :

- A. des taches rosées lenticulaires
- B. une angine de Dugl
- C. une localisation au niveau du ventre
- D. une localisation au niveau du buste,
- E. une localisation au niveau du dos

Les éléments ou thèmes d'éducation d'un patient sous antibiotique :

- A. Respect des doses horaires et modalités de prise des médicaments
- B. Respect du nombre de jours
- C. Prévenir le médecin en cas d'effets indésirables
- D. Ne pas interrompre le traitement même si les signes infectieux ont disparu, sauf en cas d'intolérance
- E. Ne pas utiliser les antibiotiques restant d'une prescription antérieure
- F. Expliquer au patient que l'antibiotique ne fatigue pas, c'est la lutte contre l'infection qui fatigue.
- G. conseille au patient le repos, une alimentation équilibrée, des boissons (eau) en quantité suffisant.

Les complications digestives de la fièvre typhoïde sont :

- A. Hémorragies digestives : méléna, rectorragie, hématomèse
- B. Perforation intestinale
- C. Hépatite
- D. Abscès du foie
- E. Cholécystite
- F. Appendicite

Les complications de la fièvre typhoïde selon les différents systèmes Cardiovasculaires :

- A. Myocardite,
- B. phlébite,
- C. collapsus cardio-vasculaire

Les complications de la fièvre typhoïde selon les différents systèmes Neuro-méningés :

- A. Méningite,
- B. Encéphalite
- C. Hémiplégie

Les complications de la fièvre typhoïde selon les différents systèmes :

- A. Ostéo-articulaires

- B. Arthrite
- C. Spondylodiscite

Choisir parmi les propositions suivantes trois thèmes de CCC dont vous discuterez avec la population au cours de la fièvre typhoïde?

- A. Hygiène individuelle
- B. hygiène collective
- C. Vaccination

En ce qui concerne la méningite purulente, l'on peut affirmer que :

- A. C'est la pénétration et la multiplication des germes au niveau des espaces sous-arachnoïdiens
- B. C'est une infection des méninges et du liquide céphalo-rachidien (LCR) par des bactéries pyogènes
- C. C'est une infection fréquente qui pose un problème de santé public dans le Nord de la Côte d'Ivoire, où sévissent des épidémies périodiques.
- D. C'est une maladie grave avec une létalité pouvant atteindre 30%.

La phase d'incubation :

- A. est silencieuse
- B. dure 3 à 4 jours

La phase d'invasion est caractérisée par :

- A. Une apparition brutale,
- B. un malaise,
- C. de vives céphalées,
- D. des frissons répétés,
- E. des vomissements
- F. une fièvre de 39 à 40°C

Les signes fonctionnels de la méningite purulente à la phase d'état se caractérisent par :

- A. le syndrome méningé
- B. le syndrome infectieux
- C. les troubles neurologiques 3 à 4 jours plus tard.

Les signes fonctionnels du syndrome méningé de la méningite purulente à la phase d'état :

- A. Ils sont représentés par le trépied méningitique
- B. Les vomissements qui se font par jets
- C. Des céphalées en casques
- D. La constipation (inconstante)

Les Signes physiques du syndrome méningé de la méningite purulente à la phase d'état :

- A. raideur méningée
- B. l'hyperesthésie cutanée (exagération de la sensibilité de la peau).

La raideur méningée du syndrome méningé de la méningite purulente à la phase d'état se caractérise par :

- A. une raideur de la nuque
- B. un signe de brudzinski positif croissant
- C. un signe de kerning positif

Les signes infectieux du syndrome méningé de la méningite purulente à la phase d'état sont :

- A. une fièvre de 39 à 40°C
- B. un pouls rapide
- C. une langue saburrale

- D. une oligurie
- E. un herpès péribuccal (bouton de fièvre autour de la bouche)

Indiquez les troubles neurologiques du syndrome méningé de la méningite purulente à la phase d'état :

- A. Convulsions
- B. Coma

Les complications des méningites purulentes :

- A. Persistance de l'infection,
- B. récurrence tardive,
- C. déficit moteur,
- D. pyocéphale...

Pour diagnostiquer la méningite, l'on a recours à :

- A. Une ponction lombaire
- B. Une numération formule sanguine
- C. Une radiographie des méninges

La position correcte du malade est la condition absolue ou le principe d'une bonne ponction : Vrai faux

Indiquer parmi les positions suivantes, ceux ou celle qui permet de rechercher le signe de kerning :

- A. plier les cuisses sur le bassin, jambes étendues : une douleur s'oppose à cette extension et oblige le patient à fléchir les cuisses et les jambes.
- B. faire asseoir le patient sur son lit ; on observe une flexion des jambes et cuisses sur le bassin.
- C. Mettre en position debout les bras élevés sur la tête

Le signe de KERNING se voit dans Les maladies suivantes : cochez la ou les bonnes réponses.

- a. Méningite purulente
- b. Fièvre typhoïde
- c. Tuberculose pulmonaire
- d. Hémorragie méningée.

Les agents pathogènes des méningites purulentes sont

- A. Pneumocoque,
- B. Hémophilus influenzae,
- C. méningocoque,
- D. staphylocoque

Les signes fonctionnels du syndrome méningé sont :

- A. Vomissement en jet
- B. Céphalées intenses en casque
- C. Constipation

Un client est reçu pour trépied méningé. Après l'examen physique, le médecin demande une série d'exams dont une ponction lombaire. Les résultats confirment le diagnostic de présomption. Un traitement est donc institué et le client est hospitalisé. Au bout de trois jours de traitement, il s'en suit une évolution favorable avec régression des signes. Une seconde ponction est faite après trois jours de traitement et au bout de 10 jours de traitement.

Les signes qui déterminent le trépied méningé parmi les signes suivants :

- A. Vomissement en jet
- B. Céphalées intenses en casque
- C. Constipation
- D. Courbature
- E. Vertiges

Le But de la ponction lombaire face à un trépied méningé est de confirmer le diagnostic de méningite et d'isoler le germe : A. Vrai B. Faux

Le but de la ponction lombaire au cours du traitement est de Vérifier l'efficacité du traitement et suivre l'évolution de la maladie : A. Vrai B. Faux

Pour Confirmer la guérison d'une malade atteint de méningite se pratique au cours du traitement : A. Vrai B. Faux

Les précautions à prendre avant la réalisation d'une ponction lombaire sont :

- A. Faire un fond d'œil pour rechercher une hypertension intracrânienne
- B. Faire la préparation psychologique du client
- C. Recommander au client d'être à jeûne
- D. Préparer le matériel.

Les précautions à prendre pendant une ponction lombaire sont :

- A. Installer le patient dans une position adéquate
- B. Aider le médecin en maintenant le patient
- C. Surveiller le patient au cours de la ponction : faciès, réactions

Les précautions à prendre avant, pendant et après une ponction lombaire sont :

- A. Faire un pansement aseptique au point de ponction
- B. Mettre le patient au repos absolu au lit en décubitus ventral
- C. Recommander au client de ne pas
- D. Lui conseiller fortement de se réhydrater, en revanche,
- E. attendre environ 3 heures après la ponction pour le réalimenter
- F. Etiqueter et envoyer le flacon de liquide prélevé au laboratoire.

Une hémorragie méningée spontanée :

- A - Est souvent due chez l'adulte jeune à la rupture d'un anévrysme artériel intracrânien.
- B - De première intention, une ponction lombaire doit être effectuée pour le diagnostic.
- C - Peut se compliquer d'une hydrocéphalie.
- D - Peut se compliquer d'un vasospasme cérébral
- E - Nécessite la mise au repos strict pendant la première semaine avant d'envisager des explorations à visée étiologique.

Melle D est adressée par son médecin traitant, dans le service des urgences où vous travaillez, pour suspicion de méningite. Elle présente à son arrivée des céphalées violentes généralisées, des vomissements et une raideur de la nuque. Le médecin l'examine et prescrit : NFS, Plaquettes, hémocultures, ionogramme sanguin, créatinémie, glycémie, CRP, pro calcitonine, TP, TCA, fibrinogène, scanner cérébral et radio de poumons.

La méningite est une infection des méninges et du liquide céphalo-rachidien (LCR) par des bactéries pyogènes : Vrai faux

Les principaux agents pathogènes des méningites purulentes :

- A. Neisseriameningitidis (A, B, C, X, Y, W135)
- B. Streptococcus pneumoniae
- C. Escherichia coli
- D. Listeria monocytogenes
- E. Hemophilus influenzae

Les différentes étapes physiopathologiques des méningites purulentes se présentent dans l'un des ordres suivants, lequel ? :

- A. Infection et colonisation, Invasion sanguine, Invasion méningée, Inflammation des méninges et du cerveau, Œdème cérébral et HTIC
- B. Invasion sanguine, Invasion méningée, Infection et colonisation ; Œdème cérébral et HTIC, Infection et colonisation
- C. Invasion méningée, Infection et colonisation ; Œdème cérébral et HTIC, Infection et colonisation
- D. Inflammation des méninges et du cerveau, Œdème cérébral et HTIC, Invasion méningée
- E. Œdème cérébral et HTIC, Invasion méningée, Invasion sanguine, Invasion méningée, Infection et colonisation

Cas clinique Tétanos

Une mère vous amène son fils de 15 ans présentant une contracture généralisée avec spasme musculaires internes intenses. Sa température évaluée à 39°5 à l'arrivée avec un pouls supérieur à 120 battements par minutes. A l'interrogatoire, il ressort qu'il a été blessé sur le dessus du pied il y a 20 jours au cours des travaux champêtres. Il travaille sans porter des chaussures.

Choisir parmi les affections suivantes, celle qui correspond aux signes cliniques :

- A. Méningite
- B. Tétanos
- C. Fièvre typhoïde
- D. Septicémie
- E. plaie

Relever les éléments dans le texte qui justifient votre choix :

- A. Contracture généralisée avec spasme musculaire internes intenses
- B. Sa température évaluée à 39°5 à l'arrivée
- C. On pouls supérieur à 120 battement par minutes
- D. Blessée sur le dessus du pied il a 20 jours
- E. Travaille sans porter des chaussures

Au plan pathogénie, indique à partir du texte les trois conditions réunies pour que le tétanos survienne chez le malade :

- A. existence d'une porte d'entrée
- B. absence de vaccination efficace
- C. contamination de la porte d'entrée par les spores de Clostridium tétani.

Le nom de l'agent pathogène du tétanos est :

- A. Clostridium tétanique
- B. bacille D'EBERT

- C. bacille de Nicolaïer
- D. bacille cholérique

Le signe capital à la phase d'invasion du tétanos est :

- A. Trismus
- B. Raideur de la nuque
- C. Signe de brudzinski
- D. Signe de kerning

Le trismus est une contracture des muscles masticateurs bloquant l'ouverture de la mâchoire :

- A. Vrai
- B. faux

Devant un trismus, on peut penser à :

- A. L'apparition de la dent de sagesse
- B. Une angine
- C. un AVC bulbo protubérantiel
- D. Une prise de neuroleptique

Le trismus se caractérise par une contracture des muscles masticateurs. Indiquer le muscle qui a pour fonction d'élever la mandibule :

- A. Le muscle temporal
- B. Le muscle stylo-huïdien
- C. Le muscle masséter
- D. Le muscle ptérygoidien médial
- E. Le muscle buccinateur

Le but du traitement curatif du tétanos par l'administration d'immunoglobuline à un client :

- A. combattre une infection existant
- B. prévenir une surinfection bactérienne
- C. vise à neutraliser la toxine encore circulante
- D. éviter la survenue de multiplication des bactéries

Le but du traitement du tétanos est de

- A. Détruire le germe
- B. Neutraliser la toxine circulante
- C. Réduire la contracture
- D. Prévenir toutes les complications
- E. Chimio prophylaxie et vaccination

Un vacancier de 50 ans, qui n'a aucun souvenir de ses vaccinations antérieures contre le tétanos, s'est blessé le pied avec une fourche, indiqué parmi les propositions de prophylaxie spécifique, celle pour laquelle vous aller opter :

- A. Vaccination seule
- B. Séroprophylaxie seule
- C. Chimio prophylaxie seule
- D. Séroprophylaxie et vaccination

Le diagnostic positif du tétanos se fait le diagnostic positif du tétanos se fait :

- A. par les cliniques signes chez une personne au statut vaccinal défectueux
- B. dans les suites d'une blessure même minime, ancienne, passée inaperçue
- C. les examens bactériologiques chez une personne au statut vaccinal défectueux

Le rôle de l'infirmier face à la porte d'entrée du bacille de Nicolaïer ou clostridium tétani consiste :

- A. à la désinfection de la plaie
- B. au nettoyage de la plaie
- C. trachéotomie et intubation trachéale
- D. au parage de la plaie
- E. au débridement chirurgical de la plaie
- F. à la décision d'isolement sensoriel du malade

VIH/Sida

1Le SIDA est (indiquer les deux réponses exactes) :

- A. un sigle qui signifie Symptôme d'Immuno Déficit Avéré.
- B. un sigle qui signifie Syndrome d'Immuno Déficience Acquis
- C. une maladie contagieuse, d'origine bactérienne.
- D. une maladie contagieuse, d'origine virale.

Réponse (B D)

Le sida est une: Cochez la ou les bonne (s) réponse (s):

- A. Pandémie
- B. Épidémie
- C. Épidémie
- D. Endémie

(Réponse A)

A propos du SIDA, il est juste d'affirmer que ;

- A. SIDA est le sigle du syndrome d'immunodéficience acquise
- B. Syndrome est un ensemble de signes
- C. Immunodéficience est l'affaiblissement du système immunitaire
- D. Acquis est la déficience ni innée, ni héréditaire
- E. C'est une Infection causée par un virus de la famille des rétrovirus appelé Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH)

(Réponse ABCDE)

Choisir parmi les propositions suivantes l'agent pathogène du SIDA :

- A. VIH
- B. ARN
- C. ADN

(Réponse A)

Le sida est provoqué par deux espèces d'agent pathogène

- A. Vrai
- B. Faux
- C. (Réponse A)

Le VIH :

- A. est un sigle qui signifie Virus de l'Immunodéficience Humaine.
- B. est un virus, c'est à dire un organisme procaryote de très petite taille.
- C. est un rétrovirus car il possède de l'ADN transcript en ARN.
- D. est un rétrovirus car il possède de l'ARN retranscript en ADN

(Réponse A B D)

La multiplication du virus VIH dans la cellule hôte nécessite :

- A. une transcription inverse de l'ARN viral en ADN.
- B. une traduction de l'ADN viral en ARN messager.
- C. l'intervention d'une transcriptase inverse d'origine virale sur l'ARN du VIH, pour le traduire en protéines.
- D. l'intervention d'une transcriptase inverse d'origine humaine sur l'ARN viral, pour le convertir en ADN.

(Réponse A)

Dans les propositions suivantes, cocher uniquement la phrase juste.

- A. Un sujet séropositif est atteint du SIDA.
- B. Le VIH se transmet uniquement au cours de rapports sexuels non protégés.
- C. La période asymptomatique correspond à une disparition temporaire (de 1 à 10 ans) du VIH dans l'organisme.
- D. Un sujet séropositif n'est pas malade mais il est contagieux.

(Réponse D)

Le virus du VIH est constitué :

- A. Uniquement d'une enveloppe et d'un filament d'ARN libre dans le cytoplasme.
- B. d'une enveloppe, de deux molécules d'ARN et d'une protéine, la transcriptase inverse.
- C. d'une enveloppe formée d'une bicouche de lipides dans laquelle sont intégrées des protéines pouvant être reconnues comme antigènes.
- D. d'une coque ou capside, entourée d'une enveloppe, abritant le génome viral et les protéines enzymatiques

(Réponse B C D)

Le virus du sida est : Cochez la ou les bonne (s) réponse (s):

- A- un rétrovirus car à ARN
- B- un parasite des hématies
- C- l'élément pathogène des maladies opportunistes
- D- un parasite des lymphocytes T4 et des macrophages

(Réponse A)

Parmi les propositions suivantes, indiquez la particularité du VIH 1 :

- A. Le plus commun en Afrique subsaharienne et à travers le monde;
- B. Prédominance du groupe M;
- C. Transmissibilité plus grande;
- D. Augmentation du risque de TME;
- E. Progression plus rapide vers la phase Sida sans prise en charge.

(Réponse A B C D E)

Parmi les propositions suivantes, indiquez la particularité du VIH 2 :

- A. Le plus souvent retrouvé en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, dans certaines parties de l'Europe et en Inde;
- B. Se transmet moins facilement;
- C. Se transmet rarement de la mère à l'enfant;
- D. Est moins virulent et évolue plus lentement vers la maladie.

(Réponse A B C D)

Les voies de transmission du VIH sont :

- A. Relations sexuelles non protégées
- B. Grossesse
- C. Contact direct avec le sang ou les liquides corporels
- D. Allaitement maternel
- E. Accouchement

(Réponse A B C D E)

Parmi les regroupements des modes de transmission du VIH, celle qui est exacte ou ceux qui sont exactes :

- A. contact avec du sang et dérivées contaminés
- B. contact sexuelle non protégé;
- C. mère enfant ; grossesse, accouchement, allaitement

(Réponse A B C)

Le mode de transmission le plus fréquent du VIH :

- A. Transmission par le sang et dérivées 3% ;
- B. transmission sexuelle 90% ;
- C. transmission materno-fœtale (mère enfant) 7%
- D. (Réponse B)

La voie de contamination prédominante du sida est : Cochez la ou les bonne (s) réponse (s):

- A. L'allaitement maternel
- B. La voie sanguine
- C. La voie transplacentaire
- D. La voie sexuelle

(Réponse B D)

Les facteurs de risque de la transmission par voie sexuelle sont :

- A. Les microtraumatismes lors des rapports sexuels
- B. Les rapports sexuels non protégés pendant les menstrues
- C. Les rapports sexuels non protégés avec partenaires multiples
- D. Le premier rapport sexuel chez la jeune fille
- E. Les viols et violences sexuelles
- F. La prostitution
- G. Le stade avancé de la maladie
- H. Les infections sexuellement transmissibles (IST) ulcéraives ou non

(Réponse ABCDEFGH)

Les facteurs de risque de la transmission par Transmission par le sang et dérivées (voie sanguine) sont :

- A. Transfusion sanguine avec du sang non testé
- B. Toxicomanie avec échange de seringue
- C. Accident d'exposition au sang (AES)
- D. Certaines pratiques : excision, circoncision, percées d'oreilles, tatouages avec le même matériel souillé

(Réponse ABCD)

Parmi les propositions suivantes, indiquer les facteurs de risque prouvés de la transmission (mère enfant)

- A. Charge virale élevée
- B. Sida avéré
- C. Certains génotypes et phénotypes viraux
- D. IST
- E. Déficit immunitaire (CD4 bas)
- F. Accouchement par voie basse
- G. Allaitement prolongé
- H. Allaitement mixte
- I. Plaies buccales

(Réponse A B E F G)

Les déterminants du non transmission du VIH sont :

- A. Salutation et baisers simples
- B. Utilisation de même ustensile de cuisine
- C. Utilisation de même couvert
- D. Utilisation de même toilettes, douches, bureau et couchette
- E. Sueur, respiration, toux
- F. Piqûres d'insectes, mouches, moustiques
- G. Natation dans la même piscine
- H. Utilisation des mêmes moyens de transport

(Réponse A B C D E F G H)

L'infection par le VIH :

- A. commence par l'entrée du VIH dans l'organisme, provoquant une intense réaction du système immunitaire (séroconversion).
- B. nécessite la reconnaissance de la cellule-cible (LT4) grâce à une liaison des protéines de l'enveloppe avec le récepteur CD4.
- C. commence par une internalisation du virus dans toutes les cellules du corps.
- D. se caractérise par la libération de l'ARN viral et de la transcriptase inverse dans le cytoplasme de la cellule hôte.

(Réponse A B C D E)

Les déterminants de la propagation et les situations à risques favorisant l'expansion de l'infection à VIH chez la femme sont :

- A. Pauvreté,
- B. analphabétisme,
- C. lévirat,
- D. sororat,
- E. incapacité à négocier le préservatif,
- F. anatomie de la femme,
- G. subordination

(Réponse A B C D E F G)

Les déterminants de la propagation et les situations à risques favorisant l'expansion de l'infection à VIH chez les jeunes sont :

- A. Ignorance,
- B. inconscience,
- C. mimétisme,
- D. esprit de groupe

(Réponse ABCD)

Les déterminants de la propagation et les situations à risques favorisant l'expansion de l'infection à VIH chez les corps habillés sont :

- A. Mythe de l'uniforme ;
- B. le port de l'uniforme donne le sentiment d'invulnérabilité,
- C. mission loin des foyers conjugaux,
- D. esprit de groupe

(Réponse ABCD)

Les déterminants de la propagation et les situations à risques favorisant l'expansion de l'infection à VIH chez les migrants sont :

- A. Déplacement fréquents hors des foyers
- B. non-respect des mesures de prévention
- C. le port de l'uniforme
- D. l'esprit de groupe

(Réponse AB)

Les différentes étapes de la réplication virale sont :

- A. Reconnaissance des cellules cibles pour se fixer sur les récepteurs CD4
- B. Pénétration du virus par fusion de la membrane cellulaire et de l'enveloppe virale permettant la pénétration du VIH dans le cytoplasme de la cellule cible
- C. Rétrotranscription (transformation de L'ARN viral en ADN proviral)
- D. Intégration dans le matériel génétique de la cellule
- E. Production de particules virales
- F. Libération de virions

(Réponse ABCDEF)

Indiquer l'étape de la réplication virale au cours de l'infection à VIH :

- 1-Reconnaissance des cellules cibles
2. Pénétration du virus
3. Rétrotranscription
4. Intégration
5. Production de particules virales
6. Libération de virions

Choisir la réponse exacte

A- (1, 2, 3, 4, 5,6) B-(4, 2, 3, 1, 5,6) C-(, 3, 4, 5,6, 2,1)

(Réponse A)

La Physiopathologie de l'infection à VIH :

Ayant pénétré dans l'organisme d'un sujet sain, le virus se développe à l'intérieur de certains leucocytes, les leucocytes T4. Il s'y multiplie et détruit ces cellules. La disparition des lymphocytes est responsable du déficit immunitaire qui s'installe peu à peu chez les porteurs de virus.....

Les stades d'évolution du VIH sont

1. Phase asymptomatique
2. Contamination
3. Sida déclaré
4. Primo-infection

Parmi les propositions *Retrouvez celle qui correspond à un ordre logique :*

Cochez la ou les bonne (s) réponse(s):

- A. 1-2-3-4
- B. 2-4-3-1
- C. 2-3-4-1
- D. 2-4-1-3

(Réponse D)

La primo-infection à VIH :

- A. se traduit par l'apparition de maladies opportunistes.
- B. se traduit par des symptômes voisins de ceux de la grippe.
- C. correspond à une intense augmentation de la charge virale.
- D. est caractérisée par une augmentation de l'activité des lymphocytes T cytotoxiques.

(Réponse BCD)

Les signes cliniques pouvant faire suspecter une primo infection ou phase aigüe du VIH sont :

- A. Syndrome pseudo-grippal : malaise général, fièvre, algies diffuses
- B. Eruptions cutanées morbiliformes, adénopathies, splénomégalie
- C. Tableau de méningo-encéphalite
- D. Qui disparaissent en quelques jours (8-15 jours)

(Réponse ABCD)

La phase symptomatique du SIDA correspond à :

- A. la diminution de la charge virale du VIH dans le sang.
- B. une augmentation lente et progressive de la quantité de lymphocytes T4.
- C. une augmentation de la sécrétion d'anticorps anti VIH.
- D. l'effondrement des acteurs de la défense immunitaire.
- E. l'apparition de maladies opportunistes.

(Réponse DE)

Examen biologique à demander au stade primo infection ou phase aigüe du VIH :

- A. Hémogramme,

- B. sérologie VIH,
- C. charge virale,
- D. antigène p21,
- E. culture virale

(Réponse ABCDE)

Les signes cliniques pouvant faire suspecter une Phase de latence et/ou pauci-symptomatique du SIDA sont :

- A. Candidose buccale,
- B. zona,
- C. folliculite,
- D. fièvre,
- E. condylomes,
- F. lymphadonopathie généralisée persistante symétrique indolore évoluant plus de 3 mois

(Réponse A)

Examen à demander au cours de la Phase de latence et/ou pauci-symptomatique du SIDA sont :

- A. Sérologie VIH,
- B. taux de CD4,
- C. charge virale

(Réponse A B C)

Les signes cliniques pouvant faire suspecter le stade sida sont :

- A. Amaigrissement : perte de poids $\geq 10\%$
- B. Fièvre modérée persistante continue ou intermittente > 1 mois
- C. Diarrhée chronique continue, intermittente > 1 mois
- D. Infection opportunistes (IOs)
- E. Prolifération malignes

(Réponse A B C D E)

Définition de thèmes suivants : muguet, sarcome de kaposi

Le muguet est une mycose liée à la prolifération d'une levure présente à l'état naturel dans la cavité oro-pharyngée.

(Réponse A)

Le sarcome de Kaposi est un cancer qui provoque l'apparition de tumeurs violacées ou brunâtres qui ressemblent à des plaies sur la peau.

(Réponse A)

Une affection opportuniste se définit comme :

Des maladies qui se développent en dehors de leur cadre local habituel parce que l'organisme présente une telle baisse de l'immunité qu'il est incapable de les enrayer.

(Réponse A)

Une mycose liée à la prolifération d'une levure présente à l'état naturel dans la cavité oro-pharyngée est le sarcome de Kaposi :

A. Vrai B. Faux

(Réponse B)

Les différentes méthodes de diagnostic biologique de l'infection à VIH sont :

- A. Méthodes directes
- B. Méthodes fluorescences
- C. Biologie moléculaire
- D. Méthodes indirectes

(Réponse A D)

Les différentes méthodes de diagnostic direct sont constituées de :

- A. La culture virale
- B. La recherche de l'antigène p24
- C. Le dosage de la transcriptase inverse
- D. La recherche du matériel génétique (biologie moléculaire)

(Réponse A B C D)

Les différentes méthodes de diagnostic indirect sont :

- A. Les tests de dépistage : test rapide, tests ELISA
- B. Les tests de confirmation : Western blot, tests immuno-analyse en ligne ou line immuno-assay
- C. (Réponse B)

Le principe des tests de diagnostic indirect est de :

- A. Mise en évidence des anticorps anti-VIH
- B. Dosage de la reverse transcriptase

(Réponse A)

Indiquer parmi les tests suivants ceux qui permettent la confirmation du SIDA :

- A. test rapide,
- B. Western blot,
- C. tests immuno-analyse en ligne (line immuno-assay)
- D. tests ELISA

(Réponse B C)

Le test ELISA utilisé dans le dépistage du SIDA : (Indiquer celles qui sont justes) :

- A. permet la détection du virus dans le sérum des patients.
- B. permet la détection des anticorps anti-VIH dans le sérum du patient.
- C. ne devient positif qu'après une période de latence, au moment de la séroconversion du malade.
- D. doit être confirmé par un second test : le Western Blot.

(Réponse B C D)

Le test ELISA (Cochez la ou les bonne (s) réponse (s)) :

- A- est utilisé uniquement dans le cadre du dépistage de la séropositivité pour le VIH
- B- ne peut être pratiqué qu'après un délai d'une vingtaine de jours environ après une primo-infection par le VIH
- C- vise à détecter la présence dans le sérum d'antigènes X en retenant ces derniers par des anticorps anti-X fixés sur un support
- D- est praticable durant la phase asymptomatique de l'infection par le VIH.

On peut savoir si on est séropositif au VIH après un rapport non ou mal protégé: Cochez la ou les bonne (s) réponse (s):

- A. Dès le rapport
- B. Dans la semaine qui suit
- C. Après un délai de séroconversion de plusieurs semaines
- D. Dans les 72 heures qui suivent le rapport

(Réponse C)

Selon la voie de transmission sanguine et ses dérivées, indiquer les éléments sur lesquels vous allez insister :

- A. Manipulation du sang et dérivés ;
- B. Utilisation des instruments à usage unique
- C. Pratique coutumières et traditionnelles (scarification...) ;
- D. Asepsie strict lors des soins.

(Réponse A B C D)

Selon la voie de transmission de la transmission sexuelle indiquer les éléments sur lesquels vous allez insister au cours de la prévention :

- A. Utilisation des préservatifs
- B. Abstinence sexuelle
- C. Fidélité.

(Réponse ABC)

Indiquer les éléments sur lesquels un agent de santé doit insister au cours de la prévention de la transmission materno-fœtale du VIH sont :

- A. Promotion de l'allaitement artificiel chez la femme séropositive
- B. Suivi du traitement

C. Promotion de l'allaitement maternel chez la femme séropositive

(Réponse A B C)

Une personne naïve est :

- A. Une personne détectée positif au VIH et qui n'a jamais entendu parler des antirétroviraux
- B. Une personne détectée positif au VIH et qui n'a jamais été en contact avec les antirétroviraux
- C. Une personne détectée positif au VIH et qui ne sait pas prendre les antirétroviraux

(Réponse B)

Au cours de sa prise en charge, vous remarquez que le médecin prescrit un médicament au fur et à mesure de l'apparition des signes. Ce type de traitement s'appelle :

- A- Traitement préventif
- B- Traitement symptomatique
- C- Traitement curatif

(Réponse B)

La mise au point d'un vaccin contre le sida s'avère difficile car: Cochez la ou les bonne (s) réponse (s):

- A. Le VIH est un rétrovirus
- B. Le VIH s'attaque au système immunitaire de l'individu
- C. Le VIH effectue des mutations fréquentes
- D. Le VIH est différent d'un individu à l'autre.

(Réponse ABCD)

Les précautions à prendre lors de l'administration des soins d'un client atteint d'infection VIH sont :

- A. Port de gants
- B. Utilisation de matériel à usage unique
- C. Respect des mesures d'hygiène :
- D. Lavage des mains avant les soins et après
- E. Eliminer le matériel souillé dans un emballage étanche
- F. Tous les prélèvements de sang et autres doivent porter un diffèrent indicatif.

(Réponse ABCDEF)

Après votre prise de service au centre de santé de Bodo, vous constatez que dans ce village les comportements individuels à risque face au VIH. Vous vous proposez de faire la promotion de comportements à moindre risque. Donner les mesures de prévention primaire :

- A. Abstinence sexuelle
- B. Fidélité mutuelle mono partenaire

C. Rapport protégé
(Réponse A B C)

Cas clinique

Mme EHOUBA a 3mois de grossesse et vient à sa première consultation. Après lui avoir donné des conseils sur la nécessité de faire des examens sanguins, elle accepte de les faire. Le résultat de la femme enceinte est positif au VIH. Le nombre de CPN recommandé à toute femme enceinte en Côte d'Ivoire est de :

- A. au moins 4 CPN
- B. 4 CPN
- C. 3 CPN

(Réponse A)

Le nombre de contact de CPN nécessaire pour mettre à une femme enceinte dont l'examen de sang est positif au VIH sur traitement ARV est de :

- A. CPN2
- B. CPN3
- C. CPN1 ou dès ce premier contact après avoir éliminé une tuberculose active ou autres infections opportunistes quel que soit l'âge de la grossesse.

(Réponse C)

La durée du traitement d'une femme enceinte dont l'examen de sang est positif au VIH mis sous traitement ARV est :

- A. à vie
- B. équivalent à la durée de la grossesse
- C. de cinq ans

(Réponse A)

La femme accouche 6 mois plus tard par vos soins ; Indiquer les éléments de votre conduite à tenir en salle de travail et d'accouchement pour la parturiente :

- A. Passer en revue les antécédents cliniques de la parturiente
- B. vérifier son statut sérologique VIH dans le carnet de santé mère-enfant
- C. vérifier le protocole ARV et les autres médicaments prescrits
- D. vérifier la prise de la dose journalière d'ARV
- E. Lui remettre son traitement du jour en cas d'oubli
- F. donner un rendez-vous pour la prochaine visite dans 6 semaines

(Réponse ABCDEF)

La femme accouche 6 mois plus tard dans votre maternité. Indiquer les éléments de votre conduite à tenir en salle de travail et d'accouchement pour le nouveau-né :

- A. administrer la première dose de prophylaxie ARV

(Si le résultat précise VIH1, donner Névirapine à la dose de 0,6mg en prise unique par jour pendant 4 semaines

Si le résultat est sans précision=VIH=VIH2, donner AZT à la dose de 1,2 ml deux fois par jour pendant 4 semaines)

B. établir (ouvrir) un dossier pour le nouveau-né

C. remettre un flacon d'ARV pour la prophylaxie.

(Réponse ABC)

Éliminez l'intrus concernant le statut sérologique au VIH d'un enfant :

A. À la naissance, un enfant peut être séropositif sans avoir été contaminé par le VIH

B. À la naissance, un enfant séropositif est forcément porteur du VIH

C. Un enfant non porteur du VIH peut être contaminé par l'allaitement maternel

D. Un enfant né de mère séropositive n'est pas forcément porteur du VIH.

L'infection à VIH s'accompagne habituellement de :

A. hypergammaglobulinémie

B. diminution du nombre des lymphocytes CD4

C. déficit de l'immunité humorale de l'organisme

D. hyperlymphocytose globale

E. déficit de l'immunité cellulaire de l'organisme

F. IDR tuberculine négative

(Réponse ABEF)

Le traitement antirétroviral hautement actif (en anglais HAART) est un traitement qui utilise une association efficace de trois médicaments ou plus appartenant en général à au moins deux classes différentes pour obtenir une diminution optimale et durable de la charge virale :

A-VRAI

B- FAUX

(Réponse A)

Les buts du traitement antirétroviral (TARV)

A. La réduction forte et prolongée de la réplication virale

B. La restauration et/ou la préservation de la fonction immunitaire

C. L'amélioration de la qualité de vie

D. La réduction du nombre de maladies et de décès liés au VIH

E. La réduction du nombre de nouvelles contaminations

(Réponse ABCDE)

Les principes de bases du TARV

A. Préparer le patient au traitement

B. Associer les médicaments antirétroviraux

C. Aider le patient à l'observance du TARV

D. repousser la résistance dans le temps

E. (Réponse ABCD)

Vous voulez prescrire des ARV à une personne vivant avec le VIH dans votre centre. Cocher parmi les propositions suivantes les conditions à remplir pour la prescription des ARV :

A. Disponibilités des médicaments nécessaires

- B. régularité de l'approvisionnement en médicaments
- C. Condition techniques de laboratoires sont réunies
- D. Disponibilité des mesures de base cliniques et de laboratoire pour évaluer la toxicité
- E. formation à l'utilisation du traitement ARV des prestataires.

(Réponse ABCDE)

Le traitement antirétroviraux hautement actif est un traitement antirétroviral qui utilise une association efficacité de trois médicaments ou plus : Vrai Faux

L'efficace des soins et de la prévention du VIH/Sida est conditionnée par le soutien moral :
Vrai faux

Les médicaments existant actuellement en CI appartiennent à quatre classes différentes : Vrai
Faux

La combivir est une forme combinée d'antirétrovirale associant trois antirétroviraux :*
Vrai Faux

Une personne vivant avec le VIH sous antipaludique (quinine) peut être mis sous antiprotéas :
Vrai Faux

L'activité majeure que doit mener un agent de santé face à un patient prenant concomitamment des traitements ARV et des médications traditionnelles est les soins au malade : Vrai Faux

Face aux effets secondaires et toxiques (indésirables) d'un traitement ARV ressentis par un patient, l'infirmier ou la sage-femme doit mener un interrogatoire approfondi : Vrai
Faux

Pour être éligible pour débiter le traitement ARV en Côte d'Ivoire, l'agent de santé ne se base que sur le taux de CD4 : Vrai Faux

Le régime thérapeutique préférentiel de première ligne à un patient VIH1 naïf associe quatre molécules : Vrai Faux

On appelle observance thérapeutique la capacité d'une personne à prendre un traitement selon la prescription indiquée sur l'ordonnance Vrai Faux

La stigmatisation est l'une des causes de la mauvaise observance du TARV :
Vrai Faux

Pour améliorer l'observance du TARV, la stratégie est d'adhérer à une association communautaire dePEC. Vrai Faux

Le suivi clinique pour tout patient sous traitement ARV recommandé est d'une visite par quinzaine : Vrai Faux

Le TARV est un traitement antirétroviral qui :

- A- utilise plusieurs médicaments agissant sur le virus de diverses manières
- B- utilise une association efficace de trois médicament ou plus
- C- empêche le développement des souches virales résistantes
- D- permet de passer d'une maladie évolutive et toujours mortelle à une maladie chronique.

Pour que les soins et la prévention du VIH/Sida soient vraiment efficaces, il faut que :

- A- les services aillent à la rencontre des patients et de leur communauté
- B- le soutien de l'entourage soit effectif

- C- l'adhésion du patient au traitement soit totale
- D- la prescription d'ARV soit une décision informée et partagée entre le client et le prescripteur.

Les médicaments existant actuellement en CI appartiennent à :

- A- Trois classes différentes
- B- Trois molécules différentes
- C- Quatre classes différentes
- D- Des associations fixes.

Le combivir est une forme d'ARV associant :*

- A- ZDV/3TC/ABC
- B- TDF/FTC/EFV
- C- AZT/3TC/NVP
- D- Aucune réponse n'est juste

L'association d'antiprotéas avec certains antipaludiques tels que la quinine et l'halofantrine

- A- diminue la quantité d'hormone présente dans le sang
- B- nécessite une surveillance biologique et clinique
- C- est à l'origine d'une baisse leur concentration
- D- toutes les réponses sont fausses.

Un patient prenant concomitamment des traitements ARV et des médicaments traditionnelles fait l'objet de :

- A- surveillance clinique et biologique
- B- Surveillance électro radiographique
- C- Soins et prévention
- D- Toutes les réponses sont justes

L'attitude de l'infirmier ou la sage-femme face aux effets indésirables d'un traitement ARV ressentie par un patient est de :

- A- Les reconnaître et savoir le prévenu
- B- Savoir les prévenir et les gérer
- C- Référer le patient vers un médecin
- D- Améliorer la qualité de vie de celui-ci

Les patients adultes et adolescents infectés par le VIH éligibles pour débiter le traitement antirétroviral en CI doivent être soit :

- A- Au stade clinique OMS 1, 2, 3 avec CDU <500 cellules/ml
- B- Co-infection/co-morbidité
- C- Populations clés
- D- Toutes les réponses sont justes

Concernant les antirétroviraux, quelles sont les réponses fausses ?

- a) Les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse du VIH sont actifs sur le VIH1 et le VIH2.
- b) Les inhibiteurs de la protéase du VIH ont une barrière génétique faible.
- c) Le maraviroc (CELSENTRI®) est prescrit si le virus a un tropisme sélectif pour le co-récepteur CXCR4.
- d) Le raltégravir (ISENTRESS®) est un inhibiteur de fusion du VIH.
- e) L'abacavir est CI chez les patients HLA-B5701 positif.

Le régime thérapeutique préférentiel de première ligne à un patient VIH1 naïf associe :

- A- ZDV+3TC
- B- ZDV+3TC+ EFV
- C- TDF+3TC+LPV
- D- TDF+3TC+ATV

L'observance thérapeutique au cours du VIH se définit comme

- A- Une décision consensuelle entre le client et le prescripteur
- B- La capacité d'une personne à prendre un traitement selon une prescription donnée
- C- Le degré d'accord du patient au traitement
- D- Le respect du rythme des prises médicamenteuses

Parmi les éléments suivants, lequel sont une cause d'une mauvaise observance

- A- La stigmatisation
- B- L'altération de la relation soignant/malade
- C- La résistance aux médicaments ARV
- D- L'aggravation de la maladie

Les stratégies pour améliorer l'observance d'un traitement ARV par un client est de

- A- Développer les soins communautaires
- B- Expliquer le calendrier thérapeutique au patient
- C- Former les religieux, les féticheurs sur le Sida, les ARV et son observance
- D- Je ne sais pas

Le programme national recommande pour tout patient sous traitement ARV

- A- Un suivi trimestriel
- B- Un suivi mensuel
- C- Toutes les quinzaines
- D- Chaque semaine

Parmi les propositions suivantes, cocher le moment recommandé pour débiter le traitement par les antirétroviraux au cours de l'infection par le VIH asymptomatique

- A - Dès que la charge virale plasmatique excède 1 000 copies d'ARN VIH/ml
- B - Dès que la charge virale plasmatique excède 10 000 copies d'ARN VIH/ml
- C - Dès que le taux des lymphocytes T CD4 sanguins est inférieur à 500/mm³
- D - Dès que le taux des lymphocytes T CD4 sanguins est inférieur à 1000/mm³
- E - Dès que le diagnostic d'infection par le VIH est confirmé, quels que soient les résultats biologiques

L'infection à VIH s'accompagne habituellement de :

- A. hypergammaglobulinémie
- B. diminution du nombre des lymphocytes CD4
- C. déficit de l'immunité humorale de l'organisme
- D. hyperlymphocytose globale
- E. déficit de l'immunité cellulaire de l'organisme
- F. IDR tuberculine négative

Le traitement antirétroviral hautement actif (en anglais HAART)est un traitement qui utilise une association efficace de trois médicaments ou plus appartenant en général à au moins deux classes différentes pour obtenir une diminution optimale et durable de la charge virale :

VRAI FAUX

Les buts du traitement antirétroviral (TARV)

- F. La réduction forte et prolongée de la réplication virale
- G. La restauration et/ou la préservation de la fonction immunitaire
- H. L'amélioration de la qualité de vie
- I. La réduction du nombre de maladies et de décès liés au VIH
- J. La réduction du nombre de nouvelles contaminations

Les principes de bases du TARV

- F. Préparer le patient au traitement
- G. Associer les médicaments antirétroviraux
- H. Aider le patient à l'observance du TARV
- I. repousser la résistance dans le temps

Vous voulez prescrire des ARV à une personne vivant avec le VIH dans votre centre. Cocher parmi les propositions suivantes les conditions à remplir pour la prescription des ARV :

- F. Disponibilités des médicaments nécessaires
- G. régularité de l'approvisionnement en médicaments
- H. Condition techniques de laboratoires sont réunies
- I. Disponibilité des mesures de base cliniques et de laboratoire pour évaluer la toxicité
- J. formation à l'utilisation du traitement ARV des prestataires.

Le choléra

A propos du choléra, on peut affirmer que :

- A. C'est une toxi-infection intestinale, contagieuse, endémique, à déclaration obligatoire due à un bacille appelé vibron cholérique.
- B. L'agent pathogène est un Vibron cholérique qui est un bacille Gram positif
- C. il se diffuse de manière épidémique,
- D. il est endémique dans un certain nombre de pays où le système d'assainissement des eaux est insuffisant*
- E. La maladie se développe principalement dans des conditions de vie défavorables.

Que doit faire en priorité un agent de santé devant un premier patient suspect de choléra :

- A- le transférer immédiatement vers un hôpital
- B- lui donner un anti diarrhéique
- C- le faire boire abondamment de (SRO, eau salée, jus de coco, eau de riz)
- D- lui donner un antibiotique
- E- l'isoler
- F- alerter les autorités de santé

Le choléra se transmet par :

- A. Contact manuel direct avec un porteur sain,
- B. un cadavre
- C. un malade
- D. Par l'intermédiaire des aliments souillés.

Les facteurs favorisant le choléra

- A. Manque d'hygiène corporelle,
- B. Manque d'hygiène alimentaire
- C. Manque d'hygiène fécale
- D. fortes concentrations humaines,
- E. hygiène et assainissement de l'eau insuffisants,
- F. catastrophes naturelles,
- G. conflits armés,
- H. déplacements de réfugiés

Le traitement de base du choléra

- A. Réhydratation
- B. Déshydratation
- C. Association de sels de sels de quinine
- D. vitaminiques

La rougeole

En ce qui concerne la rougeole, cocher les éléments qui sont justes :

- A. La rougeole est une infection virale, éruptive aiguë.
- B. La rougeole est très contagieuse et définitivement immunisante.

Parmi les propositions suivantes concernant l'étiopatogénie, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?

- A. L'agent pathogène est le morbillivirus
Le réservoir de virus est L'homme
- B. Le réservoir de virus est les insectes
La transmission est directe
- C. La transmission ne se fait qu'au contact avec les sécrétions nasales

La rougeole apparait après combien de temps d'incubation du morbillivirus

- A. environ 14 jours après la contagion
- B. environ 10 jours après la contagion
- C. environ 04 jours après la contagion
- D. environ 20 jours après la contagion

Les manifestations cliniques au stade d'invasion de la rougeole peuvent se révéler sous forme :

- A. Une fièvre (39 et 40°C)
- B. Un catarrhe oculo-respiratoire
- C. des yeux bouffis
- D. des signes digestifs
- E. le signe de köplick
- F. des pleurs incessants de l'enfant

Les manifestations cliniques à la phase d'état de la rougeole peuvent se révéler :

- A. Au bout de 4 à 5 jours en moyenne.
- B. sous forme d'éruption typique
- C. sous forme De signe de koplick
- D. sous forme de petites plaques rouges plus ou moins en relief
- E. sous forme d'une desquamation fine visible

Citer au moins deux diagnostics différentiels de la rougeole

- A. la rubéole
- B. l'exanthème
- C. la scarlatine
- D. l'angine
- E. la rhinopharyngite
- F. la mononucléose infectieuse
- G. une allergie médicamenteuse (ampicilline, gardéнал....)

Reliez les complications au groupe de complications

Complications générales	Convulsions fébriles
Complications ORL	Encéphalites aiguë
Complications broncho-pulmonaires	Déshydratation
Complications oculaires	Bronchites
Complications neurologiques	Laryngites
	Broncho-pneumopathie
	Kératite (rougeur de l'œil perte de l'acuité visuelle)

Les différents produits pharmaceutiques utilisés au cours du traitement curatif de la rougeole sont :

- A. Les corticoïdes
- B. Les antipyrétiques
- C. La désinfection des muqueuses
- D. Les fluidifiants bronchiques
- E. Les antibiotiques
- F. Des compléments vitaminiques A

La dernière campagne de vaccination contre la rougeole et la varicelle s'est déroulée en Côte d'Ivoire en

- G. Février 2018
- H. Décembre 2017
- I. Avril 2018
- J. Janvier 2018

Indiquer les affirmations justes concernant la varicelle

- A. est une maladie virale,
- B. est une maladie peu contagieuse de l'enfant.
- C. est une fièvre éruptive.

Le virus en cause dans la varicelle est le VaricellaZoster Virus (VZV)

A-Vrai B- faux

La durée moyenne de l'incubation de la varicelle est de :

- A. 10 jours
- B. 21 jours
- C. 14 jours
- D. 05 jours

L'apparition des premiers signes de la varicelle est marquée par :

- A. Une fièvre à 38°C
- B. Un érythème scarlatiniforme fugace des céphalées légères et fatigue,
- C. Des douleurs musculaires ou articulaires
- D. Des nausées et vomissements

Au niveau cutané la varicelle a pour complication :

- A. Infection des lésions cutanées
- B. surinfection des lésions cutanées.

C. Cicatrices des lésions de varicelle.

L'ataxie cérébelleuse au cours de la varicelle se conçoit comme un trouble de la marche et de la coordination des mouvements. Vrai Faux

Les principales complications de la varicelle :

- A. Les surinfections cutanées par le staphylocoque et le pneumocoque.
- B. L'ataxie cérébelleuse
- C. Le purpura thrombopénique
- D. La pneumonie interstitielle
- E. Les complications rares

Citer au moins trois éléments du diagnostic différentiel de la varicelle :

- A. La variole
- B. Le zona généralisé
- C. Le prurigo

Le traitement curatif de la forme commune de la varicelle est constitué principalement par :

- A. Antipyrétique
- B. Antiseptique
- C. Antibiotique
- D. Savon antiseptique
- E. Antihistaminique

Le traitement préventif de la varicelle est basée sur :

- A. la vaccination: Varivax II
- B. l'antibiothérapie
- C. la corticothérapie
- D. les antipyrétiques

TABLEAU COMPARATIF DE LA ROUGEOLE ET DE LA VARICELLE

AFFECTIONS PARTICU- LARITES	ROUGEOLE	VARICELLE
INCUBATION	Silencieuse et dure environ 10 à 14jrs	Silencieuse et dure en moyenne 14 jrs
INVASION	catarrhe oculo-respiratoire fièvre à 39° à 40° C aspect bouffi et grognon signes digestifs signes nerveux signe de Köplick	fièvre à 38° C érythème scarlatiniforme fugace malaise général
PHASE D'ETAT (CARACTERISTI- QUE DE L'ERUPTION)	Eruption maculo-papuleuse tâches rouges ou érythémateuses à peine surélevées éruption descendante, de la tête aux pieds	macules rosées devenant papuleuses et très prurigineuses vésicules transparentes, en goutte de rosée l'éruption apparaît au visage, puis au thorax présence d'éléments jeunes et vieux sur le même espace cutané

	desquamation, en lambeau ou en fine couche	
--	--	--

A propos des oreillons, il est vrai de dire que c'est :

- A. Une maladie immunisante,
- B. Une maladie très contagieuse
- C. Une maladie due à un paramyxovirus
- D. Le virus ourlien qui en est responsable
- E. Un virus qui a un tropisme glandulaire et nerveux.

Les oreillons sont une maladie dont:

- A. L'agent pathogène est un virus (virus ourlien)
- B. L'agent pathogène est un parasite ourlien)
- C. le réservoir germe est l'homme malade.
- D. le mode de contamination est la voie aérienne à travers les gouttelettes salivaires de pflugge

Les oreillons sont favorisés par :

- A. La vie en collectivités d'enfants et l'adulte jeune
- B. les écoles
- C. les camps militaires
- D. le transport en commun.

L'incubation des oreillons dure :

- A- 18 à 21 jours.
- B- 1 à 2 jours
- C- 8 à 21 jours
- D- 21 à 31 jours

La période d'invasion des oreillons :

- A. Dure 36 h
- B. est marquée par une fièvre modérée,
- C. est associée à des otalgies,
- D. dure à 24 à 48 h.

La parotidite ourlienne se reconnaît par :

- A. Une tuméfaction parotidienne unilatérale
- B. Une évolution bilatérale
- C. Le comblement du sillon retromaxillaire
- D. Fièvre modérée associée à des otalgies

Identifier en le cochant sur votre feuille les organes qui peuvent être atteints par le virus des oreillons :

- A- glandes salivaires
- B- rein
- C- pancréas
- D- ovaires
- E- testicule

L'interrogatoire d'un malade atteint de la parotidite ourlienne révèle :

- A. une douleur provoquée temporo-maxillaire
- B. des adénopathies sous- angulo-maxillaires

- C. une rougeur de l'orifice du canal.
- D. une atteinte des glandes sous-maxillaires
- E. des céphalées fréquentes.

La parotidite ourlienne évolue favorablement sans séquelle

- A. Vrai
- B. Faux

Les localisations glandulaires extra parotidiennes sont

- A. Scrotale
- B. encéphale
- C. Pancréatite ourlienne
- D. Ovarite

Comment se fait le diagnostic positif de de la parotidite ourlienne (oreillons)

- A. isoler le virus ourlien dans la salive
- B. isoler le virus ourlien dans le LCR (liquide céphalo-rachidien)
- C. isoler le virus ourlien dans les urines
- D. isoler le virus ourlien dans le sang

Citer les éléments de prévention des oreillons

- A. Isolement
- B. éviction scolaire pendant 10 jours.
- C. vaccination par un vaccin vivant atténué (Imovax)

Le vaccin ROR est administré en une dose en s/c vers l'âge de 12 – 18 mois contre :

- A. rougeole,
- B. poliomyélite
- C. oreillon,
- D. rubéole
- E. tuberculose

A partir du besoin de manger et boire, indiquer les activités de soins infirmiers que vous allez mener auprès d'un enfant atteint d'oreillons

- A. Prendre les constantes
- B. Faire les soins de la bouche
- C. Appliquer les soins prescrits
- D. Informer le malade et son entourage de la possibilité de propagation de la maladie par contagion.
- E. Informer (transmission d'information) l'équipe de soin de toute complication éventuelle.

Vous êtes chargé des soins de bouches de votre malade. Décrire votre démarche et la technique.

- A. Installer le malade (position assise ou en décubitus)
- B. Protéger le malade avec une serviette
- C. Se laver les mains
- D. Faire un tampon sur une pince
- E. Imbiber le tampon de la solution
- F. Nettoyer successivement : les gencives, des dents, les faces internes des joues et terminer par la langue en changeant de tampon au tant de fois que possible
- G. Faire rincer la bouche
- H. Etendre le collutoire sur la surface de la muqueuse buccale

- I. Réinstaller le malade
- J. Faire la transmission dans le cahier de charge
- K. Laver, essuyer et ranger le matériel.

L'herpès, la varicelle et le zona sont provoqués par le même virus : A Vrai B. Faux
Les angines

Les angines sont des inflammations douloureuses et fébriles des formations lymphoïdes de l'oropharynx et essentiellement des amygdales palatines.

Vrai Faux

En ce qui concerne les angines, quelle est ou quelles sont le ou les affirmations vraies :

- A. une incidence élevée pendant les saisons froides.
- B. plus fréquentes pendant les 5 premières années de la vie
- C. sont dues à la promiscuité
- D. une incidence élevée pendant les saisons sèches

Parmi les signes suivants, quels sont ceux qui sont des signes généraux

- A. fièvre élevée ou discrète.
- B. malaise général
- C. céphalées
- D. dysphagie
- E. courbatures
- F. une tachycardie

Une dysphagie au cours des angines est une douleur spontanée ou provoquée par la déglutition

- A. Vrai
- B. Faux

Le ou les buts de l'examen local de la gorge sont

- A. préciser l'aspect de l'angine,
- B. déterminer le siège de l'angine
- C. rechercher une hépato-splénomégalie
- D. évaluer son extension
- E. rechercher des adénopathies cervicales

Les étiologies des angines sont

- A. Le streptocoque bêta hémolytique du groupe A.
- B. Le paramyxovirus
- C. l'haemophilus influenzae
- D. le gonocoque
- E. le VaricellaZoster Virus
- F. le chlamydiae

Les différents types d'angines

- A. érythémateuses
- B. érythémato-pultacées
- C. maculo-papuleuse
- D. membraneuses

Au cours de la visite dans une crèche en tant qu'infirmier de médico-scolaire, vous constatez une épidémie d'angines. Les éducatrices n'ont aucune réaction face à cette situation. Le besoin d'apprendre a été identifié comme prioritaire.

Formulez un diagnostic infirmier pour le besoin d'apprendre identifié.

Manque de connaissance des mesures curatives et préventives de l'angine relié à l'inaction des éducatrices face à cette situation.

Elaborer un objectif de soins pour répondre au diagnostic infirmier

Adopter des mesures curatives et préventives face à l'angine existante dans leur structure au terme de trois rencontres éducatives d'ici 24 heures

La démarche éducative au cours d'une angine

- A. prise de rendez-vous avec les éducatrices
- B. arrêt des thèmes, heures et lieu de discussion
- C. rencontre et discussion avec les éducatrices
- D. évaluation des mesures curatives et préventives
- E. adoption par les éducatrices des mesures curatives et préventives
- F. évaluation des activités menées par les éducatrices
- G. évaluation de la situation

La CAT de l'infirmier ou infirmière devant une angine

- A. Prise de constantes
- B. Examen de la gorge à l'aide d'une abaisse langue
- C. Soins de la bouche
- D. Application des soins prescrits (antibiothérapie, AINS etc...)
- E. Eduquer le malade et son entourage sur les notions d'hygiène afin d'éviter des complications,
- F. Conseiller au client de suivre correctement le traitement
- G. Informer l'équipe de soins de toute complication éventuelle.

Le zona ou herpès zoster est une maladie infectieuse, due à une manifestation de récurrence du virus de la varicelle (varicellazoster virus= VZV).

Vrai Faux

Le zona est fréquent chez les sujets immunodéprimés, mais peut se voir chez les immunocompétents.

Vrai Faux

Un homme de 30 ans récent des brûlures siégeant dans le thorax. Deux jours plus tard va apparaître une éruption et une fièvre modérée (38°). L'examen constate une adénopathie axillaire et une éruption unilatérale en hémi-ceinture.

Parmi les propositions suivantes, choisir la bonne affirmation

- A. Varicelle
- B. Zonathoracique
- C. Dermatose

Les éléments de l'éruption du zona évoluent en 3 stades

Vrai Faux

Le zona démarre par des vésicules de couleurs rose vif

Vrai Faux

Des érythèmes de couleurs rose vif, arrondis ou ovalaires groupés en bouquets se mettent en place au bout de 12 à 24 h

- A. Vrai
- B. Faux

La croûte des érythèmes du zona tombe vers le 10^{ème} jour : Vrai Faux

Le syndrome d'anesthésie douloureux au cours du zona thoracique est constitué des signes suivants sauf un. Choisir la mauvaise réponse :

- A. une sensation de chaleur
- B. des céphalées inconstantes traduisant une atteinte méningée
- C. des courbatures

Parmi complications suivantes indiquez celles qui sont les principales complications du zona

- A. Le zona céphalique
- B. Le zona ophtalmique
- C. le zona du ganglion géniculé
- D. une paralysie faciale périphérique
- E. des troubles cochléo-vestibulaires.

Les douleurs du zona inter costal

- A - Sont bilatérales et symétriques
- B - Ont une topographie radiculaire
- C - Précèdent l'éruption
- D - Cèdent spontanément à la fin de l'éruption
- E - Sont à type de brûlure

Les éléments diagnostics du zona reposent sur :

- A. la clinique
- B. l'isolement du virus par culture cellulaire

Le traitement du zona quel que soit sa localisation utilise de l'acyclovir (Zovirax) A.
Vrai B.Faux

La CAT infirmière en cas de zona

- A. Prise des constantes (TA, pouls, fréquence respiratoire)
- B. Application des soins prescrits
- C. Faire la CCC par rapport à l'isolement du malade
- D. Rassurer le client et son entourage
- E. Veiller à l'hygiène du malade et à son confort
- F. Signaler toute complication à l'équipe de soin.

Parmi les vaccins suivants, quels sont ceux qui utilisent des germes vivants :

- A - Anti-variolique
- B - Anti-diphtérique
- C - BCG
- D - Anti-grippal
- E - Anti-poliomyélitique oral

Chez une femme enceinte, au troisième trimestre de la grossesse, qui est atteinte de fièvre apparemment isolée à 40°C avec frissons, quels sont les deux diagnostics à évoquer par priorité

- A. Listériose septicémique
- B. Pneumopathie atypique
- C. Grippe
- D. Infection des voies urinaires
- E. Infection par le Cytomégalovirus

Le paludisme

Vous êtes au service de médecine B2 au CHU de Treichville, vous constatez le matin de votre prise de service que le lit 35 de la salle 7 est occupé par M. Gilbert. Il est très affaibli, a une langue pâteuse ; il se plaint de douleurs diverses, de céphalées avec une température de 40° et refuse de s'alimenter. Sa femme restée au village souffrirait d'une hépatite virale, il n'a pas encore pris de douche depuis son arrivée et est toujours couché en décubitus dorsal ; il ajoute à la fin de l'entretien que vous avez eu avec lui qu'il a pris beaucoup d'autres médicaments chinois avant son hospitalisation. Le traitement institué par l'interne avant son hospitalisation :

Quinimax 0,40 2 ampoules x 2 par jour

HPV 2ml 2 ampoules x 2 par jour

HEPT-a-Myl 7cc x 2 par jour

Transfusion de sang iso groupe, iso rhésus 500cc en cas de nécessité.

Le paludisme est une endémie parasitaire, le paludisme est une érythropathie due au plasmodium transmis par la piqure de l'anophèle femelle Vrai Faux

Le paludisme est transmis par (Cochez la ou les bonne (s) réponse (s):)

- A- la mouche tsé-tsé
- B- l'aédès
- C- l'anophèle

Le vecteur du paludisme :

- A. est un moustique, mâle, du genre Anophèles
- B. est un moustique, femelle, du genre Aèdes
- C. pique à partir du coucher du soleil
- D. pique à partir du lever du soleil
- E. ne rentre pas dans les habitations.

Le paludisme peut être contracté par :

- A. Transfusion de dérivés sanguins
- B. Transmission sexuelle
- C. Transmission placentaire
- D. Utilisation de seringues souillées
- E. Ingestion d'aliments parasités

Quel mot correspond à la définition suivante ? « Maladie particulière qui se fixe dans un pays et qui y existe de façon quasi permanente. » Cochez la ou les bonne (s) réponse (s):

- A- L'endémie
- B- La pandémie
- C- L'épidémie
- D- L'éradication

Parmi les espèces de plasmodium suivantes, quelles sont celle qui sont pathogènes pour l'homme :

- A. Plasmodium vivax
- B. Plasmodium berghei.
- C. Plasmodium falciparum
- D. Plasmodium ovale

E. *Plasmodium coatneyi*

Indiquer la proposition exacte concernant le paludisme à Plasmodium falciparum

- a) Il n'est présent qu'en Afrique sub-saharienne
- b) Les rechutes sont provoquées par les hypnozoïtes
- c) Il peut être mortel
- d) Il se déclare habituellement 3 ans après le retour de zone d'endémie
- e) Il se traite par le fluconazole

Le cycle évolutif des Plasmodium comporte plusieurs phases, indiquez les assertions qui sont exactes:

- A. La schizogonie est la phase de multiplication asexuée.
- B. La schizogonie se déroule chez l'hôte définitif.
- C. La sporogonie se déroule chez l'anophèle.
- D. La sporogonie tissulaire se déroule dans le foie.

Parmi les propositions suivantes concernant le cycle exo-erythrocytaire des Plasmodium, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?

- A. Le cycle exo-erythrocytaire se déroule dans le foie.
- B. Le cycle exo-erythrocytaire détermine les cycles cliniques.
- C. Les schizontes hépatiques sont libérés dans la circulation sanguine lors de la lyse hépatocytaire.
- D. Les hypnozoïtes sont des formes intra-hépatiques quiescentes.
- E. Les sporozoïtes se multiplient dans les hépatocytes.

Parmi les propositions suivantes concernant le cycle évolutif des Plasmodium chez l'homme, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?

- A. Les mérozoïtes peuvent persister plusieurs jours dans le plasma.
- B. Les trophozoïtes parasitent les histiocytes et les monocytes circulants.
- C. Les mérozoïtes se transforment en trophozoïtes à l'intérieur des hématies.
- D. L'éclatement des corps en rosace permet l'hémolyse.
- E. Les mérozoïtes peuvent donner des gamétocytes après plusieurs cycles sanguins.

Parmi les propositions suivantes concernant le cycle des plasmodiums chez l'anophèle, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?

- A. Sa durée moyenne est 15 jours.
- B. Il correspond à la phase sexuée du cycle parasitaire.
- C. Les gamétocytes se différencient en gamètes dans la paroi intestinale de moustique.
- D. Les sporozoïtes sont stockées dans les glandes salivaires de l'anophèle.
- E. Les gamétocytes mâles se différencient en gamètes par scissiparité.
- F. Les hypnozoïtes :
- G. A-sont responsables des accès de reviviscence
- H. B-se rencontrent dans les infections à plasmodium vivax et à plasmodium ovale.
- I. C-n'existent pas dans les infections à plasmodium falciparum et plasmodium malariae.
- J. D-Provoquent des accès plusieurs mois voire année après l'infection

Parmi les 4 espèces plasmodiales humaines, laquelle (lesquelles) est (sont) susceptible(s) d'être responsable d'accès pernicieux?

- A. Plasmodium vivax.
- B. Plasmodium malariae.
- C. Plasmodium ovale.

D. Plasmodium falciparum.

Quelle espèce plasmodiale n'est observée dans le sang que sous forme d'anneaux intra-érythrocytaire et de gamétocytes en forme de bananes :

- a. P. falcifarorme
- b. P. malariae
- c. P. vivax

Quelles sont les conditions nécessaires au développement des anophèles ?

- A. Température de 30°C
- B. Canicule à 45°C
- C. Humidité importante

Quelle est la période d'incubation de Plasmodium falciparum ?

- A. 1 jour
- B. 6 jours
- C. 12 jours
- D. 21 jours
- E. 30jours

Quels peuvent être les signes cliniques d'une infection à Plasmodium falciparum ?

- A. fièvre seule
- B. Splénomégalie
- C. Thrombopénie
- D. Encéphalite
- E. Convulsions

Les manifestations cliniques du paludisme peuvent se révéler sous forme :

- A. D'une fièvre tierce
- B. D'une fièvre quarte
- C. D'un accès pernicieux
- D. De fièvre rémittente

Parmi les propositions suivantes concernant Plasmodium falciparum, toutes sont exactes sauf une, laquelle?

- A. Il peut être responsable d'accès pernicieux.
- B. Le cycle exo-érythrocytaire se déroule dans le foie des sujets impaludés.
- C. L'infection à P. falciparum entraîne habituellement une parasitémie élevée.
- D. La schizogonie érythrocytaire se déroule dans les capillaires profonds des organes.
- E. Les gamétocytes matures ont un aspect caractéristique en forme de faux.

Les signes cliniques du paludisme simple

- A. Fièvre : t° sup à 37°5
- B. Frissons ou sensation de froid
- C. Céphalées
- D. Myalgies
- E. Troubles digestifs
- F. Douleurs abdominales
- G. asthénie vertiges

L'accès palustre simple

- A- Est caractérisé par des pics fébriles périodiques
- B- S'accompagne souvent d'une splénomégalie.

- C- S'accompagne d'une hémolyse.
- D- N'est jamais dû à *Plasmodium falciparum*.

Au cours du paludisme de primo-invasion, les manifestations cliniques peuvent évoquer les diagnostics suivants :

- A. Embarras gastrique fébrile.
- B. Hépatite virale débutante.
- C. Leptospirose.
- D. Méningite.
- E. Salmonellose.

Parmi les signes cliniques suivants indiquer ceux compatibles avec un accès palustre de primo-invasion non compliqué :

- A. Fièvre
- B. Céphalées
- C. Raideur méningée
- D. Photophobie
- E. Vomissements

Chez un patient suspect de paludisme, les signes cliniques qui doivent faire craindre une évolution vers un accès grave sont les suivants

- A. Fièvre en plateau à 39,5°
- B. Somnolence
- C. Abolition d'un réflexe ostéo-tendineux
- D. Vomissements
- E. Dyspnée

Au cours d'un accès palustre simple, la fièvre :

- A. Est liée à l'éclatement des hématies parasitées.
- B. Est liée à l'action pyrogène du pigment malarique.
- C. Est liée la libération de toxine par le parasite.
- D. Possède un rythme intermittent caractéristique lié à la périodicité du cycle érythrocytaire.
- E. Possède un rythme intermittent caractéristique dès le début de l'accès.

L'accès pernicieux palustre :

- A. Est lié à une anoxie tissulaire.
- B. Est une urgence médicale.
- C. N'est pas observé en cas de paludisme d'importation.
- D. Est une complication habituelle du paludisme post-transfusionnel.
- E. Est caractérisé par une atteinte multiviscérale.

L'accès pernicieux palustre

- A. Est lié à une anoxie tissulaire.
- B. Est lié à des troubles de la micro-circulation
- C. Est lié à des phénomènes de cytotoxicité.
- D. Est toujours dû à *Plasmodium falciparum*.
- E. Se contracte exclusivement en Afrique.

L'accès pernicieux palustre (paludisme grave) :

- A. Peut se compliquer d'insuffisance respiratoire aiguë.
- B. Se caractérise par une fièvre intermittente de type tierce.
- C. Peut se compliquer de CIVD.
- D. Peut se compliquer d'insuffisance rénale aiguë organique.
- E. S'accompagne d'une élévation des IgM sériques.

L'accès pernicieux de paludisme :

- A - est synonyme de neuropaludisme
- B - est synonyme d'accès compliqué
- C - peut survenir à tout âge de façon très brutale
- D - peut se voir avec toutes les espèces plasmodiales
- F – est une urgence thérapeutique
- G – s'accompagne souvent d'un frottis négatif

Le diagnostic d'urgence du paludisme repose sur les techniques suivantes :

- A. Goutte épaisse
- B. Frottis sanguin
- C. Sérologie.
- D. PCR (Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaîne)
- E. QBC Malaria®

Les facteurs favorisant un accès de paludisme compliqué sont :

- A - parasitemie forte à *P. falciparum*
- B - grossesse (2ème et 3ème trimestre)
- C - sujet non immun
- D - accès à *P. vivax*
- E - jeune enfant (plus de 12 mois)
- F – prise préalable de chloroquine

*Parmi les molécules suivantes, cocher celles qui peuvent être utilisées en première intention pour le traitement d'un accès non compliqué à *P. falciparum**

- A. Chloroquine (Nivaquine®)
- B. Quinine (Quinimax®) per os
- C. Halofantrine (Halfan®)
- D. L'association Chloroquine + Proguanil (Savarine®)
- E. Méfloquine (Lariam®)

Parmi les médicaments suivants, cocher celui qui ne peut pas être utilisé pour la prophylaxie individuelle en raison de sa demi-vie trop courte

- A - Sulfadoxine-pyriméthamine (Fansidar)
- B - Quinine
- C - Méfloquine
- D - Doxycycline
- E - Chloroquine
- F - Proguanil

Le ou les examen(s) de laboratoire peut ou peuvent permettre à l'interne de poser le diagnostic de paludisme :

- A. Goutte épaisse
- B. frottis mince

- C. QBC Malaria
- D. test de diagnostic rapide (TDR)

Quel (s) examen(s) de laboratoire peut ou peuvent permettre à l'interne de poser le diagnostic de la fièvre typhoïde :

- A. Hémogramme
- B. Sérodiagnostic de Widal et Félix
- C. Coproculture

L'examen de laboratoire indispensable à demander pour apprécier le degré de l'anémie dont souffre M. Gilbert est :

- A. Taux d'hémoglobine
- B. Taux de globule rouge
- C. Taux d'hématocrite

Parmi les propositions suivantes, cochez celle (s) qui correspondent aux complications du paludisme :

- A. Atteinte neurologique à type de convulsion
- B. Anémie
- C. Ictère
- D. Insuffisance rénale
- E. Coma
- F. Diarrhée

Dans le cycle évolutif du, plasmodium la schizonie tissulaire:

- A. est un cycle asexué
- B. Est un cycle érythrocytaire
- C. Se déroule chez l'homme

Les formes dormantes du plasmodium sont :

- A. Les ookinètes
- B. Hypnozoïtes
- C. Schizontes
- D. Sporozoïtes

Dans le paludisme grave on note une parasitémie positive à plasmodium falciparum avec :

- A. Nausée
- B. Une acidose métabolique
- C. Un œdème pulmonaire
- D. Un prurit.

Selon les directives de prise en charge du paludisme grave en vigueur en côte d'ivoire, un enfant de 10 kg doit recevoir au premier jour du traitement une dose d'artésunate injectable à raison de :

- A. 24 mg à H0 H6 et H24
- B. 2, 4 mg à H0, H12 et H 24
- C. 24 mg à H0 H 18 et H24
- D. 24 mg à H0 H12 et H24

L'association artesunate (10 mg / kg / jour + amodiaquine 4 mg/ kg/jour) est utilisé dans le traitement de paludisme simple selon les directives nationales : V / F

Parmi les propositions suivantes, cochez celle (s) qui correspondent aux complications de la fièvre typhoïde

- A. Encéphalite
- B. Hémorragie digestive
- C. Perforation digestive
- D. Occlusion
- E. Troubles convulsives
- F. Coma

La grippe est une maladie infectieuse, contagieuse, due à un virus appelé myxovirus influenzae.

Vrai

Faux

Les éléments épidémiologiques de la grippe :

- A. L'agent pathogène est le myxovirus influenzae existant sous 3 types : A, B et C.
- B. Le réservoir de virus est l'homme malade.
- C. Le Mode de contamination est interhumain par voie aérienne

La forme commune de la grippe se manifestent par :

- A. Frissons intenses brutale
- B. Fièvre à 39°-40°
- C. algies diffuses (myalgies, arthralgies)
- D. céphalées vives frontales retro-orbitaires
- E. Rougeur diffuse du pharynx

L'incubation de la forme commune de la grippe :

- A. Est Brève
- B. Est Silencieuse
- C. Dure 2 à 3 jours
- D. Provoque une algie diffuse

La phase d'invasion de la grippe se manifeste par

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| A. Apparition brutale des signes | B. Malaise général, |
| C. frissons intenses, | D. rougeur pharyngée |
| E. fièvre, | D. céphalées |

Au cours de la phase d'état de la grippe, les signes suivants : algies diffuses (myalgies, arthralgies), céphalées vives frontales retro-orbitaires, un catarrhe des voies aériennes supérieures, Fièvre à 39°-40°C, Frissons, Asthénie, Anorexie, Tachycardie sont classés en :

signes généraux

Fièvre à 39°-40°C, Frissons, Asthénie, Anorexie, Tachycardie

signes fonctionnels

Algies diffuses (myalgies, arthralgies), céphalées vives frontales retro-orbitaires, un catarrhe des voies aériennes supérieures

Un catarrhe des voies aériennes supérieures se caractérise par :

- A. injection conjonctival,
- B. rhinorrhée,
- C. des douleurs pharyngées avec odynophagie,

- D. brûlures retro-sternales,
- E. toux sèche douloureuse.

Les signes caractéristiques de la forme compliquée d'une grippe sont :

- A. une fièvre persistante
- B. une expectoration purulente
- C. une aggravation respiratoire
- D. une hyperpolynucléose neutrophile à l'examen biologique
- E. une otite,
- F. une sinusite,
- G. une laryngite,
- H. une pleurésie

Les complications extra pulmonaires de la grippe :

- A. la péricardite
- B. la myocardite
- C. la méningite
- D. les troubles digestifs (vomissements)

Les Formes graves et malignes de la grippe se rencontrent chez :

- A. les sujets ayant une insuffisance cardiaque
- B. les sujets ayant respiratoire
- C. les nourrissons
- D. le vieillard
- E. la femme enceinte.

Comment se fait le diagnostic de la grippe se fait en période d'épidémie par ?

- A. nombre de cas
- B. isolement du virus sur cultures cellulaires,
- C. hémogramme (du sang)
- D. apparition des signes de gravités

Au cours de la grippe commune, le traitement consiste à :

- A. Mettre le malade au repos au lit
- B. Prescrire un antipyrétique : aspirine 500 : 1 cp/10kg/24h
- C. Faire antibiothérapie en fonction du germe isolé
- D. Donner de la vitamine C : laroscorbinecpeff.
- E. Effectuer des soins locaux : instillation nasale : vibrocil goutte – otrivine goutte

Au cours de la grippe commune, le traitement consiste à :

- A. Antipyrétique+ antibiothérapie+ vitamine C+ soins locaux
- B. repos au lit+ Antipyrétique+ vitamine C+ soins locaux
- C. Antipyrétique+ vitamine B+ soins locaux+ antibiothérapie
- D. Antipyrétique+ vitamine C+ soins locaux+ antibiothérapie.

Le traitement préventif de la grippe est basé sur.

- A. Une antibiothérapie en fonction du germe isolé.
- B. La vaccination
- C. L'aérosolthérapie
- D. La prise de cigarettes

CAT infirmière devant une grippe

- A. Accueil et installation du malade
- B. Prise régulière des constantes,

- C. Informer le client et son entourage sur la maladie et ses conséquences
- D. Veiller à l'isolement du client
- E. Examiner la gorge du client.
- F. Préparer le nécessaire pour les examens de la gorge
- G. Le syndrome dysentérique.

PARASITOSE

Les parasites:

- A – sont par définition toujours pathogènes
- B - ont toujours besoin d'un vecteur pour assurer leur multiplication.
- C - peuvent être uni ou pluricellulaires
- D – se reproduisent de façon sexuée ou asexuée.
- E – évoluent généralement en plusieurs stades successifs
- F - ont toujours besoin d'un hôte ou de plusieurs hôtes successifs pour assurer la survie de leur espèce

La relation entre deux êtres vivants qui vivent ensemble sans se détruire et avec bénéfice mutuel, s'appelle le...

- A. mutualisme
- B. parasitisme
- C. saprophytisme
- D. commensalisme
- E. symbiose
- F. communisme biologique

Les différentes modes de transmission des parasitoses intestinales :

- A. En ingérant par l'intermédiaire d'eau de boisson ou d'aliments souillés d'œufs de parasites
- B. Voie transcutanée

L'examen direct des selles peut permettre le diagnostic des parasitoses suivantes sauf un, laquelle

- a. Ankylostomiasis
- b. Ascariidose
- c. Trichocéphalose
- d. Loase (filariose)

Parmi les parasitoses suivantes, laquelle ou lesquelles pénètre-t-il dans l'organisme humain par voie transcutanée

- a. Amibiase b. Ascariidose c. Bilharziose
- d. Anguillulose e. Ankylostomose

Parasitoses secondaires à une transmission transcutanée

- A. Distomatose
- B. Nécatorose
- C. Ankylostomiase
- D. Anguillulose
- E. Bilharziose

Parasite qui s'introduit chez l'homme par voie digestive :

- a. La dracunculose b. La bilharziose c. La distomatose
- d. L'ankylostomose e. L'oxyurose

Les parasitoses qui ont besoin d'un hôte inter-médiaire sont :

- a. Amibiase b. Paludisme c. Taeniasis
- d. Gale sarcoptique e. Pédiculose

La cuisson suffisante de la viande est une des mesures préventives vis-à-vis des parasitoses suivantes:

- a La fasciolose
- b La toxoplasmose
- c La taeniasis à *Taenia saginata*
- d La cryptococcose
- e L'oxyurose

Dans la liste suivante indiquez le (les) parasites donnant habituellement une anémie:

- A. *Entamoebahistolytica*
- B. *Plasmodium vivax*
- C. *Ankylostomaduodenale*
- D. *Taenia saginata*
- E. *Giardia intestinalis*

Parmi lesquelles des situations infectieuses suivantes observe-t-on une hyperéosinophilie sanguine?

- A. Aspergillose
- B. Amibiase hépatique
- C. Bilharziose urinaire
- D. Anguillulose
- E. Ascaridiose
- F. Paludisme
- G. Anguillulose
- H. Toxoplasmose

Parmi les parasitoses suivantes, une seule fait appel à un vecteur pour sa transmission :

- A – Amibiase
- B – Toxoplasmose
- C – Leishmanioses
- D – Giardiase
- E – Pneumocystose

Une transmission directe de personne à personne est possible pour :

- A - Ascaridiose
- B - Cryptosporidiose
- C - Oxyurose
- D - Giardiase
- E - Anguillulose
- F – Amibiase.

*La bilharziose à *schistosoma haematobium* :*

- A. Se manifeste par une hématurie
- B. Se manifeste par une hématurie macroscopique
- C. Est évitable par la vaccination
- D. Se traite avec le praziquantel

La localisation préférentielle de la dracunculose est :

- A. Les membres inférieurs
- B. Les oreilles
- C. La main

Les trématodes

- A. sont des vers plats segmentés en forme de feuille
- B. sont très commun chez l'homme et plus encore chez l'animal
- C. ont obligatoirement un cycle à 2 hôtes intermédiaires dont le premier est un mollusque
- D. sont transmis à l'homme par voie alimentaire
- E. on classe dans ce groupe : Taenia.
- F. en phase d'invasion, ils donnent une éosinophilie
- G. ils sont tous sensibles au praziquantel ou au triclabendazole

L'oxyurose :

- A. Est une nématodose des régions intertropicales.
- B. Se transmet par la viande non cuite.
- C. Récidive facilement.
- D. S'accompagne habituellement d'une éosinophilie importante.
- E. Les œufs doivent être recherchés sur la marge anale.

L'oxyurose :

- A. est due à un trématode appelé Enterobiusvermicularis
- B. le mâle mesure de 3 à 5 cm
- C. les œufs sont directement infestant
- D. peuvent conduire à des manifestations génitales
- E. le diagnostic est apporté par le test de Graham

L'oxyurose :

- A. on peut avoir une hyperéosinophilie à 20% dans certains cas
- B. un des traitements proposés est le Fluconazole TRIFLUCAN
- C. un des traitements proposé est le Flubendazole (FLUVERMAL)
- D. un des traitements proposé est l'Albendazole (ZENTEL)
- E. il faut recommencer le traitement 3 jours après

Les examens aident au diagnostic d'une oxyurose

- A. NFS
- B. Test de Graham
- C. ECBU
- D. Sérologie
- E. Examen parasitologique des selles

Le signe clinique majeur de l'oxyurose est :

- A. La diarrhée avec déshydratation
- B. Pincement des ailes du nez
- C. Prurit anal vespéral
- D. Des troubles intestinaux.

L'ascaridiose

Enterobius vermicularis

- (a) est responsable de la bilharziose intestinale
- (b) le chien est le réservoir de parasites
- (c) l'ingestion des œufs est suivie d'une phase de migration larvaire avec passage pulmonaire
- (d) l'helminthe adulte est visible à l'œil nu sous l'aspect d'une « rognure d'ongle »
- (e) les œufs sont à rechercher sur la marge anale par le scotch test

Enterobius vermicularis

- A. La larve migre à travers le poumon avant de regagner l'intestin.
- B. Les adultes mâles et femelles sont présents dans le caecum.
- C. Les adultes mesurent environ un centimètre de long.
- D. Les femelles migrent sous la peau le jour.
- E. Les œufs migrent vers le rectum.

L'ascaridiose

- A. est transmise par ingestion d'œufs présents dans des aliments souillés
- B. des complications chirurgicales sont possibles liées aux ascaris qui remontent les voies bilio-pancréatiques
- C. à la phase d'invasion, le tableau clinique peut se caractériser par le syndrome de Loeffler
- D. la contamination peut se faire par les mains sales.
- E. l'examen de selles ne montre jamais des œufs pendant l'épisode de migration larvaire.
- F. Il arrive qu'un enfant vomisse un ascaris ou le rejette par le nez

L'ascaridiose

- A. n'est pas un parasite exclusif de l'homme
- B. l'adulte mesure une vingtaine de centimètres
- C. les œufs se caractérisent par leur double coque, la plus externe étant mamelonnée
- D. il peut exister des œufs non fécondés
- E. les œufs sont embryonnés à la ponte

L'ascaridiose est une parasitose intestinale due à (mettre une croix en face de la ou (des) bonne réponse)

- | | |
|----------------|---|
| A- un nématode | B- une filaire |
| C- un cestode | D- un ver présentant une tête piriforme |

Cliniquement, l'ascaridiose peut conduire à :

- A. une occlusion intestinale
- B. des perforations intestinales avec péritonites
- C. des migrations aberrantes
- D. des pancréatites
- E. des méningo-encéphalites

Indiquer les affirmations concernant le cycle biologique de l'ankylostomiase

- A. La larve strongyloïde enkystée, forme infestante, infeste l'homme par voie transcutané.
- B. Après avoir traversé la peau, la larve strongyloïde gagne le cœur droit par voie sanguine,
- C. passe dans les alvéoles pulmonaires,
- D. remonte les bronches puis la trachée et arrive au carrefour aéro-digestif,
- E. au bout de 04 jours, bascule dans l'œsophage lors d'un mouvement de déglutition et de secousse de toux,
- F. arrive dans le duodénum où elle deviendra adulte après 40 jours de mue.

L'anguillulose :

- A. l'adulte parasite est une femelle parthogénétique non hématophage
- B. possède 2 cycles de développement différents selon les conditions extérieures
- C. possède un cycle endogène sans larve L2
- D. peut être mise en évidence par une coproculture dite de Baerman
- E. peut conduire à un syndrome de larvacurens.

les différents stades du cycle de l'anguillule sont :

œufs éliminés dans les selles

- A. larve rhabditoïde dans les selles
- B. larve strongyloïde dans les selles
- C. Contamination par ingestion de la larve strongyloïde infestante
- D. Contamination par passage transcutané de la larve strongyloïde infestante

Le Tænia

Vous recevez M. accompagné de sa mère qui a présenté un syndrome dysentérique une semaine au paravent pour des douleurs abdominales à type d'épigastralgie ; des nausées ; une boulimie une diarrhée avec quelquefois une irritation sans cause et des céphalées et des difficultés respiratoires.

De quoi souffre M. ?

Tænia

Le teniase latum est un ver qui est uniquement inféodé à L'homme :

Vrai Faux

L'ingestion de viande saignante peut transmettre :

- a. La trichinose b. L'hydatidose
- c. La bothriocéphalose d. La toxoplasmose.
- e. La Taeniasis à T. saginata

La viande de porc consommée crue peut transmettre

- A - Toxoplasmose B - Trichinose C – Paragonimose
- D – Taeniasis E – Toxocarose

L'ingestion de viande insuffisamment cuite de porc infesté peut être à l'origine de certaines parasitoses humaines :

- a. Ascaridiose b. Téniasis c. Trichinose
- d. Bothriocéphalose e. Anguillulose

La forme parasitaire éliminée par l'homme au cours d'un taeniasis :

- a. La cercaire
- b. Le kyste à 4 noyaux
- c. La larve
- d. Anaux contenant des embryophores

La téniose à Tænia saginata

- (a) est le plus souvent asymptomatique
- (b) peut entraîner une angiocholite par migration aberrante
- (c) est plus souvent diagnostiquée en France que celle à T solium
- (d) se traite classiquement par la prise de niclosamide (Trédémine)
- (e) peut entraîner une spoliation sanguine chez l'enfant

Téniasis:

- A - la prévention repose sur l'utilisation de l'eau potable.
- B - le traitement fait appel au niclosamide ou au praziquantel.
- C - on ne trouve pas ce type de parasite dans les pays industrialisés.
- D - l'homme s'infeste en mangeant de la viande du porc (*T. solium*) ou du boeuf (*T. saginata*) crue ou insuffisamment cuite.
- E – les taenias sont des helminthes appartenant au groupe des Cestodes.
- F – les taenias sont souvent asymptomatiques.

Le diagnostic de Taenia saginata se fait le plus souvent par :

- a. La présence d'œufs du parasite dans les selles
- b. La présence d'œufs du parasite sur un scotch test
- c. La présence d'anneaux trouvés dans les selles
- d. La présence d'anneaux éliminés par le malade en dehors des selles
- e. La vue du scolex du taenia

Le mode d'infestation du Taenia saginata est :

- a. Ingestion d'œufs embryonnés
- b. Ingestion de larves cysticerques
- c. Pénétration transcutanée de la forme larvaire
- d. Contact avec un sujet parasite

La téniose à Taenia saginata

- A. est le plus souvent asymptomatique
- B. peut entraîner une angiocholite par migration aberrante
- C. est plus souvent diagnostiquée en France que celle à *T. solium*
- D. se traite classiquement par la prise de niclosamide (Trédémine)
- E. peut entraîner une spoliation sanguine chez l'enfant

La forme parasitaire éliminée par l'homme au cours d'un taeniasis est :

- A - La cercaire
- B - Le kyste à 4 noyaux
- C - La larve
- D - Le kyste à 8 noyaux
- E - Aucune des réponses précédentes

le traitement d'un taeniasis est :

- A. Flagyl
- B. Fluvermal
- C. Trédémine
- D. Biltricide

Les anneaux murs finissent par se dessécher et se désintègrent libérant des milliers d'œufs qui se répandent sur le sol Vrai Faux

L'œuf du parasite du ténia est dissous chez l'hôte intermédiaire par :

- A. Les sucs digestifs
- B. Les sucs pancréatiques
- C. La bile

L'embryon du parasite du ténia se transforme en larves cysticerques au niveau du tube digestif : Vrai Faux

Pour se transformer en larves cysticerques, l'embryon à 06 crochets du parasite du ténia suit le chemin suivant :

- A. tissus adipeux, paroi abdominale, voie lymphatique ou sanguine, muscles
- B. paroi abdominale, voie lymphatique ou sanguine, tissus adipeux, muscles
- C. paroi abdominale, muscles, voie sanguine, tissus adipeux,

L'homme s'infecte du parasite du ténia saginata en mangeant de la viande de bœuf cuite à point : A. Vrai B. Faux

Dans l'intestin, le cysticerque devient adulte en 3 à 4 mois A. Vrai B. Faux

Indiquez les signes neurovégétatifs du ténia

- A. Dyspnée,
- B. palpitations cardiaques,
- C. insomnie,
- D. convulsions.

Pour le diagnostic de Tænia saginata, quel sont les éléments le plus contributif :

- A- La présence d'œufs du parasite dans les selles
- B - La présence d'œufs du parasite sur un scotch test
- C - La présence d'anneaux trouvés dans les selles
- D - La présence d'anneaux éliminés par le malade en dehors des selles
- E - La vue du scolex du tænia.

Les pathologies suivantes sont des nématodoses

- A. La trichinose
- B. La dracunculose
- C. L'anisakidose
- D. Le taenia saginata

De quoi se caractérise le syndrome dysentérique

- A. des troubles abdominales avec sensation de pesanteur
- B. des épreintes
- C. des ténesmes
- D. diarrhée faite de glaire muco-sanguinolente,
- E. diarrhée afécale

Le parasite responsable de l'amibiase est Entamoeba histolitica ou amibe A. vrai B. faux

Les formes sous lesquelles se présente l'Entamoeba histolitica ou amibe sont

- A. La forme végétative (forme végétative minuta ou entamoebahistolica minuta)
- B. la forme végétative histolica ou entamoeba histolitica histolytica)
- C. La forme kystique.

Le cycle pathogène de l'amibe :

Transformation des formes minuta en forme histolytica sous des influence diverses. Les amibes phagocytent des hématies, pénètrent dans la muqueuse colique en provoquant des abcès en « bouton, de chemise » qui vont provoquer une rupture des capillaires sanguins avec accélération du péristaltisme intestinal et sécrétion abondantes des cellules à mucus. Les amibes hématophages sont éliminés avec les selles diarrhéiques pour certains et d'autre gagnent d'autres organes soit par contigüité soit par la circulation sanguine.

L'anémie ankylostomienne se reconnaît par

- A. Une pâleur,
- B. une dyspnée d'effort,
- C. une tachycardie,
- D. une hypertension,
- E. des œdèmes sous cutanés,

F. des ongles souvent ramollis.

Les œdèmes au cours de l'anémie ankylostomienne se caractérisent par :

- A. Leur présence sous cutanés,
- B. Leurs aspects mous indolores prenant le godet.
- C. Leur localisation au niveau de la face,
- D. Leur localisation au niveau des paupières,
- E. Leur localisation au niveau des membres inférieurs
- F. Leur localisation au niveau des organes génitaux,

Vous envisagez d'entreprendre des actions dans la communauté pour endiguer l'amibiase.

Votre principal acte sera :

- A. Recueil des données
- B. Communication pour le Changement de Comportement
- C. Visite à domicile

Vous envisagez d'entreprendre des actions dans la communauté pour endiguer l'amibiase.

Énoncez les mesures sur lesquelles s'articulera votre action

- A. traitement de l'eau de boisson
- B. lavage des mains avant les repas et après le passage aux toilettes
- C. lavage des fruits et légumes
- D. dépister et traiter des porteurs d'amibes
- E. interdire l'utilisation d'engrais humains
- F. construit avec la population des latrines et les inciter à l'utilisation
- G. protéger les aliments contre les mouches et microbes

Dans la bilharziose à la phase d'état l'essentiel du pouvoir pathogène :

- A. L'action mécanique des parasites adultes
- B. L'action des toxines élaborées par les parasites adultes
- C. La présence d'œufs dans les tissus
- D. La migration sous cutanée des formes larvaires
- E. L'hématophagie des parasites adultes

Les examens permettant le diagnostic d'une bilharziose sont :

- A. Imagerie
- B. NFS
- C. Détection des antigènes par immunofluorescence indirecte
- D. Sérologie
- E. Biopsie rectale

La bilharziose à Schistosoma mansoni :

- A. l'hôte intermédiaire est une planorbe du nom de Biomphalaria
- B. est présente en Amérique et en Asie, mais pas en Afrique noire
- C. l'œuf possède un éperon terminal
- D. il y a un phénomène de polyembryonie
- E. peut se révéler par des manifestations au niveau du système nerveux

Le syndrome dysentérique résulte de l'invasion de l'intestin par une bactérie qui attaque la muqueuse intestinale.

- A. Vrai
- B. Faux

Le mode de transmission du syndrome dysentérique est :

- A. oro-fécal
- B. trans-cutanée
- C. consommation d'un aliment souillé par des selles.
- D. inter-humaine.
- E. Zoonose

Le syndrome dysentérique est

- A. responsable de véritables épidémies dans les pays où l'hygiène est précaire.
- B. responsable de véritables pandémies dans les pays où l'hygiène est précaire.
- C. A déclaration obligatoire
- D. Caractérisée par une diarrhée s'accompagne de fièvre
- E. traité avec des antibiotiques spéciaux.

L'ingestion et la multiplication des shigelles dans les intestins vont entraîner

- A- une sécrétion d'eau et d'électrolytes x
- B- Des douleurs abdominales importantes
- C- une réhydratation précoce
- D- Une hémorragie digestive

Les syndromes dysentériques sont composés de

- A- Shigellose B- la lèpre C- lamblase D- l'amibiase

Indiquer parmi les signes suivants celui ou ceux qui caractérise le syndrome dysentérique

- A. des douleurs abdominales intenses avec sensations de pesanteur
- B. des épreintes
- C. des ténésmes
- D. une diarrhée faite de glaire-muco-sanguinolente, afécale avec en moyenne plus de 10 selles par jour
- E. des vomissements suivis d'une déshydratation.

Le(s) agent(s) pathogène(s) suivant(s) peut (peuvent) provoquer un syndrome dysentérique.

Le (s) quel(s) :

- A- Vibron cholérique
- B- Salmonella typhimurium
- C- Shigella flexneri
- D- Entamoeba histolytica
- E- Staphylococcus aureus

Le syndrome dysentérique fait partie des diarrhées aiguës d'origine bactérienne

- A. Vrai B. Faux

Parmi les éléments suivants quel est ou quels sont ceux qui correspondent au traitement du syndrome dysentérique:

- A. une réhydratation par voie orale (solutés de réhydratation orale (SRO) ou par perfusion) ;
- B. une correction des troubles métaboliques et électrolytiques ;
- C. un régime sans sel, pauvre en glucides et en protéines
- D. la prescription de médicaments anti-sécrétoires (racécadotril) et antalgiques (paracétamol) ;
- E. un régime alimentaire sans résidus ;
- F. un isolement du malade pour éviter toute contamination de l'entourage

Faites correspondre le(s) agent(s) pathogène(s) suivant(s) au syndrome qu'il provoque.

Agents pathogène

1-Vibron cholérique	2-Salmonella typhimurium	3-Shigella flexneri	4-
Entamoeba histolytica	5-Staphylococcus aureus		

Syndrome

- A - Syndrome cholériforme.
 - B - Le syndrome dysentérique peut s'associer au syndrome toxique.
 - C - "Dysenterie bacillaire".
 - D - "Dysenterie amibienne".
 - E - L'entérite staphylococcique post-antibiothérapie peut se traduire par un syndrome dysentérique.
- A-(1-A) B-(2-B) C-(3-C) D-(4-D) E-(5-E)

Indiquez le ou les signes cliniques que l'on observe habituellement dans la dysenterie à shigella (dysenterie bacillaire)

- A- Fièvre
- B- Diarrhée glaireuse, sanglante
- C- Douleurs abdominales
- D- Eruption cutanée
- E- Ulcérations de la muqueuse colique en carte de géographie

La ou les maladies suivantes sont la cause de diarrhée fébrile :

- A - Choléra
- B - Toxi-infection alimentaire à Salmonella typhimurium
- C - Amibiase intestinale
- D - Toxi-infection alimentaire à Staphylococcus aureus
- E - Shigellose

Le syndrome dysentérique au cours de l'amibiase colique aiguë non compliqué comporte tous ces signes, sauf un, lequel :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Des selles glaireuses | b. Des selles sanglantes |
| c. Un ténesme rectal | d. Une fièvre élevée |

Vous recevez un homme qui présente une diarrhée intense d'apparition brutale, avec selles liquides, vite afécales, incessantes avec vomissements, hypothermie, myalgie, asthénie.

L'examen physique ne montre qu'une déshydratation globale avec collapsus et oligurie. Quel diagnostic retenir-vous ?

- | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
| A - Salmonellose majeure | B - Shigellose | C - Toxi-infection |
| D - Choléra | E - Amibiase colique | |

L'incubation du choléra est de :

- A - Inférieure ou égale à 4 j
- B - 8 à 9 j
- C - 10 à 14 j
- D - 15 à 19 j
- E - Supérieure ou égale à 20 j

Le syndrome cholériforme se caractérise par :

- A. une diarrhée aqueuse sans fièvre, due à des toxines bactériennes présentes dans l'alimentation ou les boissons ;

- B. une diarrhée glaireuse et sanglante, accompagnée de fièvre, due à l'infection de l'intestin par une bactérie ;
- C. la bactérie *Clostridium difficile*
- D. une encéphalite associée à une méningite

Parmi les types de syndromes suivants le ou les quels déterminent les diarrhées aiguës d'origine bactérienne :

- A. le syndrome cholériforme,
- B. syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter
- C. le syndrome dysentérique
- D. le syndrome mixte.
- E. Le syndrome de Guillain-Barré

Shigella est responsable de :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| A. <u>Dysenterie bacillaire</u> | B. <u>Fièvre typhoïde</u> |
| C. hypoglycémie | D. Insuffisance rénale aiguë |

Dans quel cas doit-on hospitaliser une personne atteinte de syndrome dysentérique :

- A- une déshydratation sévère ;
- B- une septicémie;
- C- une personne fragile : jeune enfant, personne âgée ;
- D- suite à un paludisme

Les Indications pour la demande de coprocultures chez un malade présentant une diarrhée aiguë sont :

- A. Signes de gravité
- B. Syndrome dysentérique
- C. Voyage récent au village
- D. Immunodépression
- E. Prise récente d'antibiotiques

Que doit faire en priorité un agent de santé devant un premier patient suspect de choléra

- A- Le transférer immédiatement vers un hôpital
- B - Lui donner un anti diarrhéique
- C - Le faire boire abondamment de (ORS, eau salée, jus de coco, eau de riz)
- D - Lui donner un antibiotique
- E – L'isoler
- F – Alerter les autorités de santé

L'amibe est un parasite interhumaine qui se contracte par :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| A- mains sales | B- eaux de boisson, |
| C- aliments crus, mouches | D- ingestion d'œufs |

*Les différentes formes d'amibiase à *Entamoeba histolytica**

- A- Intestinale B- Cardiaque C- Pulmonaire D- Rénale E- Hépatique

*Les organes dans lesquels s'effectue le cycle de *Schistosoma mansoni* ?*

- A-système porte B- Intestin C-Cœur D-Estomac E-Vessie

*Les signes évocateurs d'une infection à *Schistosoma mansoni**

- | | | |
|--------------|---|--------------|
| A. Hématurie | B. Asthénie | C. Diarrhées |
| D. Ascite | E. granulomes dans les tissus à la radiographie | |

L'hôte intermédiaire de *Schistosoma mansoni* est :

- A. la limnée
- B. la planorbe
- C. le bulin
- D. l'onchomelania
- E. le phlébotome

L'amibiase due à Entamoeba histolytica :

- A. la contamination se fait par des kystes
- B. on distingue une forme minuta et une forme histolytica
- C. la forme minuta est peu pathogène
- D. se caractérise par son noyau avec une fine couronne de chromatine et son caryosome
- E. le kyste peut contenir jusqu'à 2 noyaux et peut renfermer des corps sidérophiles

L'amibiase due à Entamoeba histolytica :

- A. l'amibiase hépatique peut survenir plusieurs semaines à plusieurs mois après la contamination
- B. on peut avoir des glaires sanglantes dans les selles
- C. le diagnostic d'amibiase hépatique repose essentiellement sur des examens d'imageries
- D. la sérologie se fait par IFI, agglutination et la confirmation par électrosynérèse
- E. le traitement des formes intestinales associe du métronidazole et INTETRIX pendant 3 jours

Les différents modes de contamination par Entamoeba histolytica

- A. les rapports sexuels
- B. les crudités
- C. les aliments souillés par des mouches
- D. la transfusion
- E. l'eau minérale en bouteille.

La forme pathogène de l'Entamoeba histolytica dans l'amibiase :

- A – Prékyste
- B – Entamoebahistolytica, forme végétative
- C - E.histolytica minuta
- D - Kyste à 4 noyaux
- E - Kyste à 2 noyaux

L'abcès amibien du foie:

- A. est toujours précédé par un syndrome dysentérique non fébrile.
- B. se rencontre avec prédilection chez les sujets immunodéprimés.
- C. est généralement peu douloureux.
- D. est presque toujours associé à une hyperleucocytose.
- E. est presque toujours associé à une forte cytolyse hépatique
- F. est presque toujours associé à une VS > 50mm.
- G. le tableau typique est celui d'une hépatomégalie douloureuse et fébrile

Le meilleur traitement de l'amibiase intestinal aujourd'hui est :

- A – Cotrimoxazole
- B – Métronidazole
- C - Praziquantel
- D – Tilbroquinol
- E – Ceftriaxone
- F - Dihydro-émétine

Les formes sous lesquelles se présente le parasite responsable de l'amibiase :

- A. La forme végétative
- B. La forme ovocyte
- C. la forme larvaire
- D. La forme kystique.

Le nom de la forme infestante de l'Amibe dysentérique est

- A - Entamoebahistolytica forme végétative
- B – Entamoebahistolytica kyste

C – Entamoebahistolytica forme
végétative minuta
E – Entameoba dispar

D – Entamoeba coli

La mouche qui dépose des kystes d'amibe sur les aliments non protégés est un...

- A - Ectoparasite B – Insecte vecteur mécanique
C - Hôte intermédiaire D - Réservoir de parasite

Parmi les propositions suivantes concernant le métronidazole (FLAGYL®), une seule est exacte. Laquelle?

- A. C'est un anti-amibien uniquement intestinal
B. Il est toujours inactif sur les germes anaérobies
C. Il est très peu résorbé après administration par voie orale
D. Il possède un effet antabuse
E. Il est très néphrotoxique

Expliquez le cycle pathogène de l'amibe.

Transformation des formes minuta en forme histolytica sous des influence diverses. Les amibes phagocytent des hématies, pénètrent dans la muqueuse colique en provoquant des abcès en « bouton, de chemise » qui vont provoquer une rupture des capillaires sanguins avec accélération du péristaltisme intestinal et sécrétion abondantes des cellules à mucus. Les amibes hématophages sont éliminés avec les selles diarrhéiques pour certains et d'autres gagnent d'autres organes soit par contiguïté soit par la circulation sanguine

Les signes cliniques de l'amibiase hépatique

- A. Début brusque
B. Fièvre à 39°-40°
C. douleurs spontanée à l'hypochondre droit,
D. irradiant dans l'épaule droite,
E. douleurs bloquant l'inspiration profonde lors de la recherche du signe de l'ébranlement
F. Hépatomégalie
G. Altération de l'état général.

Giardia intestinalis :

- A. est un flagellé du tube digestif
B. le trophozoïte possède 2 noyaux
C. le trophozoïte possède 8 flagelles partant du blépharoplaste
D. le trophozoïte possède un vrai axostyle et au centre un appareil parabasal
E. le kyste possède 2 à 4 noyaux

Giardia intestinalis :

- A. est un parasite qui évolue au niveau du duodénum
B. se multiplie par scissiparité
C. il suffit de 3 à 4 kystes pour développer une symptomatologie
D. le traitement repose sur des imidazolés
E. peut être responsable de retards de croissance

Par quels examens peut-on faire le diagnostic d'une giardiose

- A. Sérologie B. examen parasitologique des selles C. ECBU
D. tubage duodénal E. biopsie pulmonaire

Vous envisagez d'entreprendre des actions dans la communauté pour endiguer l'amibiase. Quel sera votre principal acte ?

- A. Etude du milieu
- B. Participation communautaire
- C. Communication pour le Changement de Comportement
- D. Vaccination de masse

Énoncez les mesures sur lesquelles s'articulera l'action de que l'agent de santé peut mener auprès de la population en cas de syndrome dysentérique.

- A. traitement de l'eau de boisson
- B. lavage des mains avant les repas et après le passage aux toilettes
- C. lavage des fruits et légumes
- D. dépister et traiter des porteurs d'amibes
- E. interdire l'utilisation d'engrais humains
- F. construit avec la population des latrines et les inciter à l'utilisation
- G. protéger les aliments contre les mouches et microbe

La cible de la bilharziose à schistosoma mansoni est :

- A. Le foie
- B. Le rectum
- C. La langue

Dans le traitement de première intention du pian, la ou laquelle(s) des molécules suivantes est (sont) utilisé(es) ?:

- A. Azithromycine
- B. Doxycycline 200 mg
- C. Metronidazole 500 mg

Dans le cycle évolutif du, plasmodium la schizonie tissulaire:

- D. est un cycle asexué
- E. Est un cycle érythrocytaire
- F. Se déroule chez l'homme

Les formes dormantes du plasmodium sont :

- E. Les ookinètes
- F. Hypnozoites
- G. Schizontes
- H. Sporozoites

Dans le paludisme grave on note une parasitémie positive à plasmodium falciparum avec :

- E. Nausée
- F. Une acidose métabolique
- G. Un œdème pulmonaire
- H. Un prurit.

Selon les directives de prise en charge du paludisme grave en vigueur en côte d'ivoire, un enfant de 10 kg doit recevoir au premier jour du traitement une dose d'artésunate injectable à raison de :

- E. 24 mg à H0 H6 et H24
- F. 2, 4 mg à H0, H12 et H 24
- G. 24 mg à H0 H 18 et H24
- H. 24 mg à H0 H12 et H24

L'agent pathogène de la fièvre jaune est:

- A. Aedes aegypti
- B. Virus amaril
- C. Bacille de Ebert

Le « vomito negro » est un signe qui survient au cours de la fièvre jaune à la phase :

- A. Phase congestive
- B. A la phase pré ictérique
- C. A la phase jaune hépato rénale

Les molécules recommandées par l'OMS dans le traitement de la lèpre sont :

- A. Rifampicine
- B. Azithromycine
- C. Dapsone
- D. Beta lactamine

L'agent pathogène de l'onchocercose est :

- A. Simulium damnosum
- B. Onchocerca volvulus
- C. La nymphe
- D. La mouche tsé-tsé

Le signe clinique majeur de l'oxyurose est :

- E. La diarrhée avec déshydratation
- F. Pincement des ailes du nez
- G. Prurit anal vespéral
- H. Des troubles intestinaux.

La transmission de l'ankylostomose se fait par :

- A. Voie transcutanée
- B. Voie digestive
- C. Voie Sexuelle

Dans la trypanosomiase humaine africaine, l'inversion du rythme nyctéméral (trouble du sommeil) survient :

- A. A la phase encéphalique
- B. A la phase méningo-encéphalitique
- C. A la phase lymphatico-sanguine

L'amibiase dans sa localisation extrahépatique peut atteindre par voie sanguine :

- A. Les reins
- B. Le cerveau
- C. Le pancréas
- D. La rate

La forme à l'origine de dissémination de l'amibiase est :

- A. La forme kystique
- B. La forme végétative
- C. La forme larvaire

Dans la forme majeure de la Trichochépalose, on note :

- A. Un syndrome dyspeptique
- B. Une appendicite
- C. Recto-colite

La prévention de la dengue repose sur :

- A. La vaccination

- B. La lutte anti vectorielle
- C. Assainissement du milieu

Bothriocephalose entraine une :

- A. Une anémie microcytaire
- B. Une anémie macrocytaire et mégaloblastique
- C. Prurit intense.

Bothriocephalose se traite avec la/le(s) molécule(s) suivantes :

- A. Niclosamide (tredepine)
- B. Metronidazole
- C. Praziquantel
- D. Rifampicine

La localisation pulmonaire de l'ascaris se traduit par :

- A. Le syndrome de Loëfller
- B. Une hémoptysie
- C. Le syndrome dyspeptique

Dans la giardiose la charge virale (dose minimale infectante) est comprise entre :

- A. 10 et 100 kystes
- B. 5 et 9 kystes
- C. 1 et 4 kystes

lésions typiques dans la lèpre lépromateuse sont appelées :

- A. Les lépromes
- B. Lésions hypochromiques
- C. Maux perforants.

Les conséquences de la Syphilis congénitale sur la grossesse :

- A. Avortements répétés
- B. Accouchement prématuré
- C. Enfant mort-né
- D. Vomissement gravidique

Le protocole de traitement de la syphilis tertiaire chez un adulte est :

- A. Extencilline 2,4 M. UI ; une injection de 2,4M/ semaine pendant 03 à 04 semaines
- B. Métronidazole comprimés 500 mg : 2 comprimés 2 fois par jour pendant 7 jours
- C. Praziquantel : 2 comprimés en prise unique

Dans l'atteinte osseuse par le pian la lésion dite goundou traduit:

- A. Atteinte du tibia
- B. Atteinte des doigts
- C. Hypertrophie de l'os propre du nez

La trichocéphalose sévit plus :

- A. Chez les adultes femmes
- B. Chez les nouveaux nés
- C. Chez les adultes hommes et femmes
- D. Chez les enfants de 2 à 7 ans

L'association artesunate+amodiaquine est efficace dans le traitement :

- A. La fièvre jaune
- B. De la dengue

C. Du paludisme simple

REPONDRE PAR VRAI OU FAUX

La transmission du pian est soit congénitale soit vénérienne : V / F

La prévention du pian se fait par la vaccination : V / F

Le chancre pianique est une ulcération prurigineuse, crouteuse, reposant sur une base indurée :
V / F

La lésion dite GANGOZA dans le pian survient à la phase tertiaire de la maladie : V / F

L'héparinothérapie est contre-indiquée en cas de morsure par la vipère : V / F

Il existe encore des cas de dracunculose en côte d'ivoire : V / F

Le vaccin contre la fièvre jaune est un vaccin vivant atténué : V / F

La syphilis congénitale se transmet de la mère à l'enfant à travers le placenta et se fait dans la
2^{ème} moitié de la grossesse : V / F

L'aspirine est formellement contre- indiquée chez un patient atteint de DENGUE : V /
F

Le réservoir du virus de la DENGUE est le moustique genre aedes encore appelé moustique
tigre: V / F

Il existe une immunité croisée entre les 4 type de virus de la DENGUE : V / F

L'amibiase est une maladie strictement humaine: V / F

La transmission de la giardiase est féco-orale V / F

La forme kystique de Entamoeba histolytica responsable de la contamination orale : V / F

Les formes végétatives d'entamoeba histolytica sont à l'origine de la localisation viscérale :
V / F

La rage : (cocher les bonnes réponses)

- A - est une maladie transmise par la salive d'un chien ou d'un autre animal enragé
- B – est mortelle en quelques jours après la morsure
- C – est toujours mortelle à partir de l'apparition des premiers signes cliniques.
- D – peut être prévenu par vaccination précoce après la morsure
- E – l'animal mordeur, s'il est enragé va mourir dans un délai de 10 jours

Dans la rage :

- A. La contamination est en règle directe, par morsure animale
- B. Le chien est le principal réservoir du virus en Côte d'Ivoire
- C. La rage humaine, un fois déclaré, peut-être traitée efficacement par des perfusions intraveineuses d'immunoglobulines antirabiques
- D. Toutes les espèces animales à sang chaud sont réceptives au virus rabique
- E. L'incubation de la rage humaine est longue, toujours supérieures à 15 jours.

Les propositions suivantes concernant la rage sont exactes à l'exception d'une seule : laquelle ?

- A. Le virus de la rage est neurotrope
- B. Le vaccin antirabique de la rage humain doit être appliqué à toute personne mordue par un chien non identifié
- C. Il n'y a pas de contre-indication au traitement vaccinal antirabique
- D. La sérothérapie est indiquée dans les morsures graves par un animal suspect

Le virus de la rage est neurotrope

- A. Vrai
- B. Faux

Toutes les affirmations concernant la rage sont exactes sauf une, laquelle ?

- A. La rage est encore à l'origine d'environ 55 000 décès par an.
- B. La phase d'état est caractérisée par une encéphalomyélite avec une forme paralytique et une forme spastique.
- C. Le virus peut être retrouvé dans la salive, en répétant les prélèvements.
- D. Il n'existe pas encore de test de diagnostic rapide de la rage.
- E. La recherche des antigènes rabiques dans les prélèvements cérébraux se fait par immunofluorescence.

L'hydrophobie survient à la phase prodromique de la rage : V / F

Dans le cadre de la trypanosomiase humaine africaine, quelle est la proposition inexacte ?

- A. La trypanosomose humaine africaine est transmise par la piqure de glossine.
- B. A la phase neurologique, se développe un syndrome méningo-encéphalitique.
- C. Dans cette affection, les plasmocytes stimulés, avec de nombreuses vacuoles, sont appelés cellules de Mott.

Les trypanosomes peuvent être

- A. retrouvés dans le sang, les ganglions ou le LCR.
- B. La meilleure méthode diagnostique est la recherche d'antigène circulant

La trypanosomiase humaine africaine est une maladie parasitaire, sévissant à l'état

- A. Endémique B. Epidémique C. Pandémique D. Communautaire

Dans la trypanosomiase africaine, le parasite exerce son action pathogène sur l'hôte par l'intermédiaire :

- a. De phénomènes d'auto-immunité
- b. De la présence de complexes immuns circulants
- c. D'une action destructrice directe sur les neurones du SNC
- d. De phénomènes d'hypersensibilité immédiate.
- e. D'activation de facteurs de la coagulation

Concernant la FIEVRE JAUNE, tous les caractères suivants sont exacts, sauf un, lequel ?

- A. Elle est transmise par une piqûre de moustiques du type Aedes.
- B. Elle se manifeste par une hépato-néphrite aiguë.
- C. Elle est présente dans toutes les zones intertropicales.
- D. La biopsie hépatique montre les corps de Councilman.
- E. Il existe un vaccin efficace, valable 10 ans.

Noter la (les) proposition(s) qui caractérise(nt) la chaîne épidémiologique de la fièvre jaune :

- A - Agent pathogène bactérien
- B - Transmission par un vecteur animal
- C - Réservoir animal d'agent pathogène
- D - Transmission manuportée
- E - Modification possible du terrain par un vaccin

La première réaction sérologique à se positiver au cours de la syphilis est :

- A- La réaction de Nelson
- B-Le Treponema Pallidum Hémagglutination
- C- L'immunofluorescence (FTA)
- D-La réaction de Kline
- E- La réaction du VDRL

Pour le diagnostic d'un chancre syphilitique, un seul de ces examens est inutile, lequel ?

- A - L'examen à l'ultra-microscope
- B - Le V.D.R.L.
- C - Le T.P.H.A.
- D - L'immunofluorescence
- E-Le test de Nelson (6 semaines après l'apparition du chancre).

Concernant Treponema pallidum, quelles sont les réponses justes ?

- a) C'est une bactérie spiralée et immobile.
- b) La bactérie se cultive sur gélose au sang.
- c) La sérologie TPHA utilise des antigènes tréponémiques spécifiques.
- d) La syphilis primaire se traite par la benzathine-benzylpénicilline (EXTENCILLINE®) en 1 prise orale unique.
- e) Le traitement d'une syphilis peut entraîner une réaction allergique d'Herxheimer

Les tréponèmes causent les maladies suivantes

- A -la syphilis vénérienne
- B-leschistosomaIntercalatum
- C-lebejel
- D-la pinta

La phase d'état de la Bilharziose à schistosoma Mansoni est dominée par

- A- des selles molles ou franchement liquides x
- B- Des selles glaireuses et sanguinolentes
- C- de l'ascite et des phénomènes d'hypersplénisme
- D- Hypotension avec vertige et une Tendance au collapsus

Lèpre

- A. est une mycobactériose humaine transmise comme la tuberculose
- B. est en voie de régression dans le monde
- C. il existe des gènes de susceptibilité à la lèpre expliquant que tout homme/femme/enfant n'est pas apte à développer la maladie
- D. c'est une infection mortelle sans traitement
- E. est une infection chronique, invalidante, défigurant, non mortelle
- F. les localisations primaires préférentielles sont la peau, les poumons, les os et articulations
- G. est extrêmement contagieuse
- H. le traitement est efficace mais dure en moyenne 2 ans

Le mode de transmission de la lèpre

- A. La transmission se fait au cours d'un contact étroit et durable d'une promiscuité de type familial
- B. La transmission se fait par inhalation de postillons d'un lépreux contagieux souvent à l'enfance
- C. La transmission se fait par des mucosités de lépreux mises au contact d'ulcérations ou plaies cutanées
- D. La transmission se fait par l'intermédiaire d'objets souillés : linge, natte, oreillers...

Physiopathologie de la lèpre

Après avoir franchi la barrière cutanée et/ou muqueuse, le bacille de Hansen se multiplie, envahit la peau avoisinante et s'introduit dans les axones au niveau des terminaisons des nerfs cutanés. Pour se répandre dans divers régions cutanées au cours de sa progression pour y produire des macules et des papules indolores à cause de la destruction des terminaisons nerveuses par le bacille.

Les complications de la lèpre sont :

- A. Nerveuses : névrites, paralysie
- B. Osseuses : ostéolyse, ostéites
- C. Cutanées : mal perforant plantaire
- D. Oculaire : glaucome ; opacification du cristallin

Le traitement de la lèpre est basé sur :

- A- la poly-chimiothérapie x
- B- le nettoyage local des plaies
- C- la Prévention des déformations x
- D- l'immunisation passive avec des immunoglobulines.

La lèpre lépromateuse est une forme multibacillaire : V / F

Les lésions cutanées quel que soit le type de lèpre sont prurigineuses : V / F

Le traitement de la lèpre lépromateuse dure 6 mois : V / F

L'onchocercose

L'onchocercose ou cécité des rivières est une filariose provoquée par l'infestation de la peau et des yeux par un ver nématode, onchocerca volvulus.

- A. Vrai
- B. Faux

L'appareil atteint par l'onchocercose est :

- A- Le cerveau B- La peau C- L'œil

A propos des signes cliniques de l'onchocercose on peut affirmer que :

- A. L'incubation est silencieuse
- B. dure entre 3-6 mois pour se manifester
- C. les manifestations cutanées se caractérisent par onchocercomes ou kystes onchocerquiens ;
- D. les manifestations cutanées se caractérisent les prurits onchocerquiens ou gales filariennes
- E. la gale filarienne ressemble à une peau de pachyderme.

L'onchocercose en tant que fléau

- A. atteint plusieurs personnes voire tout un village
- B. provoque des troubles oculaires
- C. est à la base de cécité massive
- D. Crée une nuisance par les simuliés
- E. Empêche les populations de travailler
- F. Fait fuir les zones endémiques
- G. Réduit le nombre de bras valides

L'onchocercose ou cécité des rivières est une filariose provoquée par

- A- l'infestation de la peau
- B- l'infestation de des yeux
- C- l'infestation de l'estomac
- D- l'infestation des organes génitaux

Le réservoir du parasite de l'onchocercose est constitué de :

- A- De l'homme malade x
- B- du porteur sain x
- C- du chien, chats x
- D- du porc

Morsure de serpent et envenimation

Selon l'OMS, les serpents provoquent chaque année environ 40.000 décès sur 500.000 morsures. A. Vrai B. Faux

Tous les serpents sont venimeux A. Vrai B. Faux

Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont des espèces de serpents :

- A. Aglyphes
- B. Opisthoglyphes
- C. Protéroglyphes
- D. Solénoglyphes

Le venin du serpent

A. Sert à la digestion de l'animal B. est une arme destinée à l'attaque

Indiquez les signes que peut présenter une personne mordue par un serpent

- A. Malaise.
- B. Sueurs froides,
- C. palpitations,
- D. pâleur.

- E. soif importante.
- F. Petites taches rouges très vif sous la peau.

La morsure par les élapidés est marqué localement par :

- A. douleurs au point de morsures
- B. tremblements musculaires à type de crampes
- C. traces de crochets
- D. une lassitude angoissante et invincible,
- E. des frissons,
- F. une soif intense avec sensation de gorge brûlante,
- G. une déglutition difficile,
- H. un ptôsis,
- I. des troubles sphinctériens,
- J. une paralysie des muscles respiratoires.

Les morsures par vipéridés sont marquées par les Signes généraux suivant

- A. des traces de crochets sous forme d'éraflures
- B. des douleurs intenses au point de morsure
- C. des œdèmes du membre mordu avec ecchymose.
- D. une angoisse
- E. une tachycardie
- F. une hypotension
- G. des vomissements
- H. des diarrhées
- I. une hyper sudation

Après une morsure de serpent ; tous les premiers gestes à faire sont :

- B. Mettre une vessie de glace sur la morsure et lui conseillé de ne pas bouger
- C. Immobilisation du membre et mise en place d'un bandage serré
- D. Administration d'une sérothérapie anti venimeuse
- E. Désinfection de la plaie
- F. faire un pansement compressif
- G. Injection du sérum anti tétanique
- H. la mettre en position antalgique lorsque des signes de collapsus apparaissent.

Les élapidés ont comme complications tardives

- A. une dysphonie due à la paralysie de la langue
- B. une suffocation due à la paralysie du pharynx
- C. une sialorrhée

La morsure par les vipéridés se complique :

- A. des surinfections
- B. des nécroses sous-cutanées et cutanées
- C. des hémorragies internes
- D. des épistaxis

Les principes du traitement au cours de la morsure de serpent est :

- A. éviter la diffusion du venin,
- B. neutraliser le venin,
- C. éviter les réactions généralisées,
- D. éviter les complications.

Rôle de l'infirmier devant une morsure de serpent

- A. Allonger le sujet mordu et le laisser au repos;

- B. Calmer le sujet;
- C. Désinfecter la morsure et faire un bandage au niveau de la lésion;
- D. Injecter 10 à 20 ml de gluconate de calcium en I.V lente;
- E. Instaurer une corticothérapie;
- F. Si le serpent a été identifié, injecter un sérum antivenimeux monovalent pour neutraliser le venin ;
- G. Si le serpent n'a pas été identifié, injecter en S/C un sérum antivenimeux polyvalent
- H. Cette injection se fait selon la technique de BESREDKA
- I. Prévenir les infections par une antibiothérapie;
- J. Si le sujet n'est pas vacciné, faire un S.A.T. pour prévenir un tétanos.
- K. faire marcher le sujet mordu.
- L. pose du garrot au-dessus et en dessous de la plaie

Le traitement de la projection du venin du serpent cracheur dans les yeux repose sur :

- A. Le lavage immédiat des yeux par du sérum salé isotonique,
- B. l'instillation de collyre mydriatique et pommade antibiotique,
- C. faire un pansement occlusif

En cas de morsure de vipère avec injection de venin, le malade présente :

- A. un œdème et une douleur intense irradiant dans tout le membre
- B. hypotension, répondant bien au remplissage vasculaire,
- C. l'œdème a une durée maximale de 3 à 5 jours.
- D. baisse du taux de prothrombine.
- E. troubles de la conscience

Un œdème et une douleur intense irradiant dans tout le membre témoigne :

- A. de l'absence d'envenimation
- B. de la gravité de l'envenimation.
- C. D'une Mineure
- D. D'une envenimation Modérée

Les signes généraux de l'envenimation sont :

- A. Troubles digestifs transitoires
- B. Atteinte neurologique avec des troubles de la conscience.
- C. Paralysie orbiculaire des lèvres,
- D. Troubles de la déglutition et de l'accommodation.
- E. Sur le plan biologique, hypoleucocytose

Une personne mordue par un serpent doit être hospitalisé à cause du risque d'aggravation.

- A. Vrai B. faux

L'objectif du traitement lors de la morsure de serpent est administrer une quantité suffisante d'anti venin pour neutraliser le volume de venin injecté par l'animal agresseur.

- A. Vrai B. faux

En cas de morsure de serpent il faut :

- A. Appliquer immédiatement un dispositif de type « garrot ».
- B. Alerter les sapeurs-pompiers.
- C. Nettoyer et désinfecter la plaie.
- D. Faire marcher la victime pour faire circuler le sang

Indiquer les Premiers soins à offrir à une personne qui est mordue par un serpent sur place :

- A. Calmer et rassurer la victime
- B. Désinfecter la morsure
- C. Pose de glace dans un linge à proximité de la morsure
- D. En l'absence d'un œdème extensif, pose d'un bandage avec une bande de crêpe, respectant les poulx distaux.
- E. Marquer la limite de l'œdème à intervalles de temps réguliers.
- F. Immobilisation et surélévation du membre mordu.
- G. Mise en place d'une voie veineuse périphérique
- H. Traitement antalgique (paracétamol, morphine) et sédatif (benzodiazépines)
- I. Mesures de réanimation non spécifiques
- J. Évacuation vers une structure hospitalière avertie et informée de l'évolution

Médecine générale

A partir des éléments de la topographie abdominale, indiquer l'emplacement du foie. Une réponse est juste, laquelle.

- A. Dans l'abdomen
- B. Dans le thorax
- C. Dans le pelvis

Le foie est un organe qui pèse environ 1.5 kg

- A. Vrai
- B-Faux

Le foie est situé sous la partie droite du diaphragme

- A. Vrai
- B-Faux

La région d'une douleur située sous les côtes droites (foie, vésicule) s'appelle :

- A. Epigastre
- B. Flanc
- C. Hypochondre
- D. Omilic

Le foie est organe très important, de ce fait il est très vascularisé et très innervé. Comment se nomme la région, située à l'arrière du foie, où se trouvent vaisseaux, nerfs et canaux hépatiques ?

- A. Le hile hépatique
- B. Le carrefour hépatique
- C. La convergence hépatique

Le système porte est un système veineux drainant tout le sang du tube digestif et de la rate vers le foie. Quel organe ne voit pas son sang drainé par le système porte ?

- A. L'œsophage
- B. L'estomac
- C. L'intestin grêle

Dans quelle veine le sang issu du foie se draine-t-il ?

- A. La veine sus-hépatique
- B. La veine cave inférieure
- C. La grande veine hépatique

Parmi les organes suivants, un seul n'a pas de rapport anatomique avec le foie. Cocher le :

- A. L'estomac
- B. La vésicule biliaire
- C. La rate

Les fonctions essentielles à la vie du foie sont :

- A. Fabrication de protéines indispensables, telles que les facteurs de coagulation,
- B. Épuration des toxines,
- C. Transformation des aliments, de l'alcool, des médicaments,
- D. Régulation de nombreux métabolismes (sucre, fer, cholestérol).

Le foie rempli de nombreuses fonctions, pour cela il est organisé en unités fonctionnelles. L'unité fonctionnelle est la plus petite structure du foie à même de remplir ses fonctions.

Comment se nomme l'unité fonctionnelle du foie ?

- A. Le lobule hépatique
- B. L'espace hépatique

C. L'unité hépatique

Cette unité fonctionnelle se compose d'une artériole et d'une veinule pour assurer la vascularisation, d'un canalicule pour assurer le rôle exogène et d'une cellule pour remplir les fonctions hépatiques. Comment ce nomme cette cellule ?

- A. La cellule de Langherans
- B. La cellule d'Hashimoto
- C. L'hépatocyte

Parmi les propositions suivantes, cocher celles qui ne sont pas des fonctions assurées par le foie :

Laquelle de ces propositions n'est pas une fonction assurée par le foie ?

- A. Synthétiser les facteurs de coagulation
- B. Participer à la régulation de la glycémie
- C. Eliminer les globules blancs
- D. Participer à la digestion
- E. Réguler la tension artérielle
- F. Permettre le transport des graisses

Le fait d'avoir un foie trop gros se nomme :

- A. L'hépto-gigantisme
- B. L'hyperhépatisme
- C. L'hépatomégalie

Les propositions suivantes sont des causes de l'hépatite sauf une. Laquelle?

- A. La bactérie staphylococcus epidermidis
- B. Consommation excessive de l'alcool
- C. Certains médicaments comme le paracétamol

L'hypertension portale est un blocage de la remontée du sang présent dans le système porte

Vrai

Faux

Laquelle de ces propositions n'est pas un signe évocateur d'une potentielle hypertension portale. Choisir la bonne affirmation :

- A. Une occlusion intestinale
- B. Une splénomégalie (rate trop grosse)
- C. Une crise hémorroïdaire

La principale complication à long terme de la cirrhose hépatique est :

- A. La pancréatite aigüe
- B. Le cancer du foie
- C. Le diabète insipide

La stéatose hépatique est une pathologie très fréquente lors des repas copieux, les facteurs expliquant la fréquence de la stéatose hépatique après un repas copieux sont :

- A. la saturation de l'activité hépatique donnant la crise de foie
- B. la transformation du foie qui se charge en graisses.
- C. le système porte qui n'arrive plus à drainer suffisamment le sang causant ainsi l'indigestion.

La palpation du foie se fait dans un examen digestif mais également dans un examen cardiologique pour permettre :

- A. d'estimer le pouls
- B. de repérer une insuffisance cardiaque
- C. de diagnostiquer un infarctus du myocarde

La cause la plus fréquente de cirrhose du foie

- A. Abus d'alcool
- B. Maladie cœliaque
- C. Chirurgie de la vésicule biliaire

Les maladies du foie sont aiguës ou chroniques selon la persistance ou non de l'agent agresseur.

Lorsqu'elles sont chroniques, elles peuvent évoluer vers une cirrhose, c'est-à-dire une destruction du foie, et/ou un cancer du foie. Vrai Faux

Les principales causes de maladies chroniques du foie sont :

- A. la consommation excessive d'alcool
- B. les hépatites virales B et C,
- C. les conséquences métaboliques liées à l'obésité et au diabète.
- D. des maladies génétiques, telle que l'hémochromatose,
- E. des maladies biliaires, telles que la cirrhose biliaire primitive
- F. la cholangite sclérosante primitive.

Les personnes les plus exposées aux maladies du foie sont

- A. Les usagers de drogues par voie intra-veineuse ou intra-nasale sont particulièrement exposés aux hépatites virales C et B.
- B. Les sujets ayant des conduites sexuelles à risque sont exposés au risque d'hépatite B.
- C. Bien que la consommation excessive d'alcool et l'obésité touchent toutes les classes sociales, elles sont plus fréquentes chez les personnes à faible revenu.

La cirrhose est un des risques d'évolution des maladies du foie : vrai faux

Les signes d'une maladie du foie sont :

- A. une fatigue,
- B. le prurit (envie de se gratter),
- C. le signe de cholestase, c'est-à-dire de mauvais écoulement de la bile
- D. l'ictère ou jaunisse
- E. l'ascite, présence de liquide dans l'abdomen
- F. l'hémorragie digestive.

Les maladies du foie se dépiste par :

- A. La prise de sang pour identifier le virus en cause, le dosage des enzymes du foie (transaminases, gamma GT, phosphatases alcalines) et de la bilirubine.
- B. le rapport poids/taille et le tour de taille permettent d'identifier les sujets à risque pour les maladies métaboliques,.

La cirrhose se définit comme :

- A. une affection irréversible et diffuse du foie caractérisée par une fibrose cicatricielle, qui désorganise l'architecture hépatique normale et entraîne la formation de nodules.
- B. la déformation étendue de la structure interne du foie qui survient quand une grande quantité de tissu hépatique normal est définitivement remplacée par du tissu cicatriciel non fonctionnel.

Les causes de la cirrhose sont

- A. l'alcool
- B. l'hépatite virale C.
- C. l'hépatite B.
- D. Les parasitoses intestinales.
- E. Le paludisme

On dit que la cirrhose est au stade compensé, c'est-à-dire que le foie a encore suffisamment de tissu sain pour fonctionner apparemment correctement.

Vrai faux

Une cirrhose est dite décompensée lorsque le foie ne peut plus remplir son rôle Vrai
Faux

Le tableau clinique d'une cirrhose décompensée est :

- A. l'ascite et les hémorragies digestives sont au premier plan.
- B. L'ascite donne un "gros ventre", plein de liquide
- C. La survenue d'une hémorragie digestive ayant pour origine une rupture de varices œophagiennes.
- D. le foie est totalement incapable de remplir ses fonctions.

Trois tests hépatiques pouvant être demandé par le médecin en cas de cirrhose :

- A. Bilirubine
- B. Phosphates alcalines
- C. Transaminases
- D. Prothrombine
- E. Albumine
- F. Taux de prothrombine
- G. Temps de céphaline kaolin
- H. Temps de saignement

Les étiologies des cirrhoses.

- A. Alcoolique
- B. Post hépatique : insuffisance hépatique, hépatite chronique
- C. Cirrhose biliaire
- D. Cirrhose métabolique
- E. Hypertension chronique

L'installation d'une cirrhose débute par la présence de cellules inflammatoire dans le tissu fibreux : A. Vrai B. Faux

La présence de cellules inflammatoire dans le tissu fibreux sera à l'origine de:

- A. une dégénérescence des cellules hépatiques avec surcharge en graisse
- B. Une gêne à la circulation du sang dans les sinusoides hépatiques
- C. Une régénération envahissante par du tissu conjonctif
- D. Une sclérose, encerclant les formations nodulaires normales.

La perte des fonctions hépatiques avec diminution de l'albumine dans le sang conduisent à un déséquilibre hydrique et de la pression oncotique :

Vrai Faux

La rétention d'eau dans les tissus responsable des œdèmes et de l'ascite est due :

- A. la perte des fonctions hépatiques
- B. une régénération envahissante par du tissu conjonctif
- C. la diminution de l'albumine dans le sang
- D. au déséquilibre hydrique et de la pression oncotique

Au cours d'une cirrhose, l'insuffisance hépatocellulaire se manifeste par :

- A - Baisse du facteur V
- B - Augmentation de l'activité rénine plasmatique
- C - Elévation du cholestérol total
- D - Elévation de la bilirubine
- E - Baisse du fer sérique

Une ascite riche en protéine évoque :

- a. Un cavernome porte
- b. Un syndrome néphrotique aigu
- c. Une tuberculose péritonéale
- d. Une carcinose péritonéale
- e. Une ascite de cirrhose

Un client ayant une cirrhose hépatique est mis sous lasilix 20mg à raison de 1 comprimé deux fois par jour. La classe thérapeutique du lasilix est :

- A. Antibiotique B. Diurétique C. Antinflammatoire

Les examens para-cliniques à pratiquer avant l'administration du lasilix ?

- A. ionogramme sanguin
- B. ionogramme urinaire
- C. épreuve de la PSP (phénosulfonéptaleïne)

Les signes d'efficacité recherchés dans l'administration du lasilix.

- A. augmentation de la diurèse
- B. baisse du poids et fonte des œdèmes
- C. baisse de la TA chez les hypertendus.

Le malade, malgré le lasilix, présente une ascite qui nécessite une ponction. Une ponction d'ascite est :

Un acte médical qui consiste à introduire un trocart dans la cavité péritonéale entre les deux feuillets pariétal et viscéral de celle-ci pour prélever ou évacuer un épanchement liquidien.

Les éléments de surveillance générale au cours de la ponction d'ascite sont :

- A. Température
- B. Pouls
- C. TA pour détecter une compensation
- D. Diurèse
- E. Poids: la perte de poids ne doit pas dépasser ½ kilo par jour
- F. périmètre abdominal
- G. Pli cutané,
- H. sécheresse des muqueuses
- I. Comportement
- J. Signe de malaise vagal (pâleur, sueurs, tachycardie, hypotension)
- K. Rythme de l'évacuation
- L. Evaluer régulièrement la douleur

Les éléments de Surveillance locale au cours de la ponction d'ascite sont :

- A. État de la peau au niveau de la ponction
- B. Aspect du pansement (sec)
- C. État de la paroi
- D. Douleurs abdominales

Les éléments de surveillance du dispositif de ponction au cours de la ponction d'ascite :

- A. Bon fonctionnement du système
- B. Evaluer et noter la quantité d'ascite évacuée

Le péritoine est constitué d'une membrane, appelée :

- A. Séreuse B. Sérieuse C. Saireuse

La séreuse est une membrane qui tapisse la cavité abdominale et l'extérieur des viscères contenus par cette cavité.

- A. Vrai B. Faux

La séreuse du péritoine est formé de :

- A. Deux feuillets B. Quatre feuillets C. Six feuillets

Le feuillet viscéral adhère aux organes :

- A. Vrai B. Faux (le feuillet viscéral est contre la paroi de la cavité abdominale)

L'espace virtuel entre les deux feuillets viscéral a pour rôle de :

- A. permettre la mobilité de l'un sur l'autre
- B. colleter le liquide abdominal en excès
- C. protéger les viscères

Le médecin a prescrit une ponction d'ascite évacuatrice : Donner les autres buts de la ponction d'ascite : Ponction exploratrice

Indiquez la région dans laquelle s'effectuer une ponction d'ascite :

La ponction, c'est un acte médical pratiqué dans la fosse iliaque gauche à mi-distance de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche et de l'ombilic les organes et portions des anses qui peuvent être traumatisés au cours de la ponction d'ascite :

- A. Colon gauche
- B. Sigmoides
- C. Rate

Le liquide ponctionné est jaune- clair semblable à la couleur de l'urine. Comment appelle-t-on un liquide de cette couleur jaune clair (couleur des urines) : ascite séro-fibrineuse. La cirrhose hépatique peut évoluer vers une insuffisance hépatique, ou syndrome de cirrhose décompensée quels sont les signes cliniques à dépister lors de la surveillance et qui signent cette évolution ?

- A. Syndrome œdémateux ascitique
- B. Hémorragie digestive
- C. Encéphalopathie hépatique
- D. Ictère
- E. Carcinome hépatocellulaire

Les gastrites

Au cours des gastrites aiguës érosives ou ulcéro-nécrotiques, les lésions :

- A. Sont le plus souvent multiples.
- B. Sont diffuses et peuvent toucher également le duodénum.
- C. Sont souvent de type et de stade différents.
- D. Peuvent cicatriser ou s'aggraver en quelques jours.
- E. Surviennent toujours sur une muqueuse antérieurement lésée.

Les gastrites aiguës :

- A. Ont toujours des manifestations bruyantes le plus souvent hémorragiques.
- B. Se compliquent exceptionnellement d'une perforation.
- C. Sont toujours liées au stress.
- D. Ne retrouvent pas toujours un facteur étiologique précis.
- E. Relèvent souvent de facteurs étiologiques multiples en milieu de réanimation.

Les gastrites aiguës médicamenteuses :

- A. Sont le plus souvent dues à l'aspirine.
- B. Sont parfois dues aux corticoïdes.
- C. Sont plus souvent observées chez la femme après 60 ans.
- D. Peuvent être favorisées par l'intoxication tabagique.
- E. Peuvent être traitées par anti-sécrétoire en maintenant un traitement AINS s'il est indispensable.

Le terme de gastrite chronique

- A. Définit des lésions inflammatoires et atrophiantes de la muqueuse gastrique.
- B. Définit une affection qui passe toujours par

Une phase aiguë avant de devenir chronique.

- C. A une définition essentiellement histologique.
- D. Correspond à une définition endoscopique.
- E. Définit une affection due essentiellement à des médicaments altérant la cytoprotection gastrique

La gastrite chronique érosive :

- A. A pour synonyme la gastrite lymphocytaire ainsi que la gastrite varioliforme diffuse.
- B. Est facilement reconnue à son aspect endoscopique qui peut être voisin d'une maladie de Ménétrier.
- C. Peut être responsable d'une symptomatologie faisant craindre une affection néoplasique.

- D. Est rapidement améliorée par la prescription de Cromoglycate.
- E. Reconnaît toujours une origine allergique.

Au cours des gastrites chroniques non érosives :

- A. Les douleurs à type de brûlures sont le principal symptôme.
- B. Le diagnostic est le plus souvent confondu avec un trouble moteur.
- C. Une anémie par défaut de sécrétion de facteur intrinsèque peut être observée.
- D. Les symptômes cliniques peuvent manquer.
- E. Les troubles du transit peuvent être observés.

Le diagnostic de gastrite chronique non érosive :

- A. Peut-être suggéré par un aspect radiologique.
- B. Est toujours évident endoscopiquement.
- C. Ne peut être correctement effectué que par des biopsies en muqueuse fundique.
- D. Est une affection comportant des altérations cellulaires épithéliales et évoluant vers une atrophie des glandes.
- E. Relève d'étiologies diverses en fonction de la localisation.

Au cours d'une gastrite chronique non érosive :

- A. Le tubage gastrique peut avoir des indications (anémie, diarrhée).
- B. Les tests immunologiques peuvent être utiles notamment la recherche de certains auto-anticorps.
- C. Une surveillance histo-endoscopique est indispensable lorsqu'une dysplasie sévère a été détectée.
- D. Le dosage de la gastrinémie peut avoir un intérêt.
- E. Une hyposidérémie peut être observée.

L'ulcère

L'ulcère gastroduodénal se définit comme :

- A- une lésion consécutive à une nécrose cutanée interne de la paroi du tube digestif
- B- Une douleur intense siégeant au niveau de la région ombilicale
- C- Une altération de la barrière de la muqueuse du tube digestif
- D- perte de substance creusant plus ou moins profondément la paroi de l'estomac ou du duodénum.
- E- Perte de substance pariétale du tube digestif ne dépassant pas la sous muqueuse

Le signe capital dans l'ulcère gastro-duodénal est :

- A. Perte de substance pariétale du tube digestif
- B. La douleur

En présence d'une personne consciente, avec un ventre douloureux et contracté, la meilleure position est : Choisir la bonne réponse

- A. Position latérale de sécurité
- B. Sur le ventre (décubitus ventral)
- C. Sur le dos (décubitus dorsal)
- D. 1/2 assis jambes pendantes
- E. 1/2 assis, jambes fléchies.

Les localisations au niveau du tube digestif de l'ulcère sont :

- A. Ulcère gastrique
- B. Ulcère duodénal
- C. Ulcère intestinal

Les examens complémentaires pour le diagnostic de l'ulcère gastro-duodénal :

- A. Transit baryté gastroduodénal
- B. Fibroscopie++++

Les complications de l'ulcère gastroduodénal

- A. hémorragie digestive
- B. perforation ulcéreuse
- C. sténose ulcéreuse
- D. transformation cancéreuse
- E. ulcère de stress.

Un vomissement de sang s'appelle :

- A. Hémothorax
- B. Melaena
- C. Métrorragie
- D. Hématémèse

Quel est parmi les propositions suivantes, celle qui correspond à l'objectif que vise la prévention de l'hépatite virale :

- A. stopper la propagation de la maladie
- B. vacciner de la communauté
- C. recommander aux malades d'éviter les rapports sexuels non protégés
- D. conseiller aux malades de maintenir une activité physique régulière

Au cours de la ponction d'ascite, l'infirmier assure la surveillance :

- A. du rythme de l'évacuation
- B. de l'alimentation du malade
- C. de l'hémorragie digestive

Une hémorragie digestive est une hémorragie

- A. Externe
- B. Extériorisée
- C. Interne
- D. Expressive

Un ulcère gastro-duodénal débute toujours par un déséquilibre entre ce qui attaque la muqueuse et ce qui la défend.

- A. Vrai
- B. faux

En cas d'extériorisation d'un ulcère gastro-duodénal trois symptômes principaux sont constatés :

- A. Vrai
- B. faux

L'hématémèse est un vomissement de sang rouge ou couleur « marc de café » dans les cas où le sang a été digéré :

- A. Vrai
- B. Faux

Le Syndrome ulcéreux typique se caractérise par les signes suivant sauf un seul. Lequel?

- A. Douleur à type de crampe
- B. Dyspepsie
- C. douleur de siège épigastrique
- D. douleur post prandial
- E. douleur calmée par les repas ou les anti-acides

Devant une hématémèse un Bilan d'hémostase est effectué

- A. Vrai
- B. Faux

Devant une hématémèse, l'infirmier placer une sonde à oxygène, branche l'oxygène et régler le débit :

- A. Vrai
- B. Faux

Le Méléna se reconnaît par des selles noires, couleur goudron qui survient plusieurs heures après le saignement

- A. Vrai B. faux

Les Rectorragies sont des excréments diarrhéiques rouges qui est le signe en général d'une hémorragie massive et ne permet pas de trancher sur l'origine du saignement

- A. Vrai B. faux

Au cours du lavage d'estomac, la surveillance ne portera que sur la détection de la cyanose :

- A. Vrai B. Faux

Le tubage gastrique est réalisé par l'introduction par les voies naturelles d'un tube de caoutchouc dans l'estomac pour aspirer le contenu gastrique. Au cours de ce soins tout ce matériel est nécessaire sauf un. Lequel ?

- A. Un tube de faucher
- B. Un drap
- C. Un lubrifiant et des compresses stériles
- D. Des tubes de prélèvement
- E. De l'eau bouillie ou un liquide de lavage

L'aspiration est une technique de soin permettant d'assurer l'évacuation des sécrétions à la suite d'une intervention ou d'une maladie :

- A. Vrai B. Faux

Altération de la mobilité Liée à l'intervention chirurgicale se manifestant par des difficultés à assurer les gestes de la vie quotidienne. Toutes les actions suivantes sont à mener sauf une laquelle :

- A. Faire la toilette intime deux fois par jour
- B. Faire le bilan des entrées et des sorties
- C. Aider à l'élimination urinaire et fécale.
- D. Frictionner des parties les plus sujettes aux escarres

Le lavement est un soin qui consiste à l'injection d'un liquide par voie rectale

- A. Vrai B. faux

Les problèmes pour la réalisation d'un lavement évacuateur sont parmi les propositions suivantes : lesquels :

- A. Constipation
- B. Incapacité d'utiliser les toilettes
- C. Manque de connaissance
- D. Peur d'aller éliminer
- E. Douleur

Le lavement évacuateur permet de lever un obstacle en cas d'occlusion intestinale :

- A. Vrai B. faux

Vous recevez un malade qui présente une douleur sous costale, sans fièvre, irradiant vers l'épaule droit, qui coupe la inspiration profonde à la pression de l'hypochondre droit (signe de Murphy), vous pensez à :

- A. Une colique hépatique
- B. Une atteinte de l'appendice
- C. Une colique néphrétique
- D. Une cholécystite aigue

Une douleur de la fosse iliaque droite peut révéler (une réponse est exacte) :

- A. Une atteinte de la rate
- B. Une atteinte du rein

- C. Une atteinte de l'appendice
- D. Une douleur sous costale

Vous recevez un malade qui présente une douleur sous costale, avec nausées voire vomissements, fièvre, défense de l'hypochondre droit irradiant vers l'épaule droite, vous pensez à :

- A. Une atteinte de l'appendice
- B. Une colique néphrétique
- C. Une colique hépatique
- D. Une cholécystite aigue

Vous recevez un malade qui présente une douleur de la fosse lombaire droite ou gauche, avec irradiations descendant vers les parties génitales chez l'homme ou vers les grandes lèvres chez la femme avec ventre souple, sans fièvre, agitation et position antalgique difficile à trouver, vous pensez à :

- A. Une atteinte de l'appendice
- B. Une colique néphrétique
- C. Une cholécystite aigue
- D. Une colique hépatique

Le matériel nécessaire au lavement évacuateur se compose du matériel suivant sauf un

- A. le liquide à injecter (eau tiède)
- B. un bock à lavement avec
- C. un tuyau de caoutchouc de 1,5m
- D. une tubulure
- E. un robinet en ébonite surmonté d'une sonde rectale
- F. de la vaseline et des compresses pour lubrifier la sonde
- G. un bassin de lit

Le rôle de l'infirmier avant la réalisation d'une endoscopie haute consiste à :

- A. Mettre le malade en décubitus latéral gauche
- B. Informer le patient sur le déroulement de l'examen
- C. Surveiller l'apparition des éventuels signes hémorragiques

Avant d'utiliser un aspirateur vous :

- A. Vérifiez si l'aspirateur est en position de « marche »
- B. Changez la sonde de position
- C. Notez la quantité, la couleur, la consistance de liquide aspiré

Sachant qu'une quantité de sang de 500 ml doit passer en 6 heures, le débit est :

- A. 02 gouttes par minutes
- B. 03 gouttes par minutes
- C. 05 gouttes par minutes

Parmi les propositions suivantes concernant la maladie ulcéreuse gastroduodénale, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s)?

- A- Elle est toujours associée à une douleur abdominale
- B - La douleur est le plus souvent post-prandiale tardive
- C - En cas d'ulcère bulbaire, la face antérieure est le plus souvent atteinte
- D - La douleur est aggravée par l'alimentation
- E - Elle est le plus souvent secondaire à une infection par *Helicobacter pylori*

L'ulcère du tube digestif se localise au niveau :

- A. Du Duodénum
- B. Du Bulbe
- C. De L'estomac

D. Du Pylore

E. Des Fesses

L'ulcère gastroduodénal (UGD) est une maladie chronique récidivante définie anatomiquement par un ou plusieurs des critères suivants :

- A- Perte de substance pariétale ne dépassant pas la sous muqueuse
- B- Perte de substance interrompant la paroi gastrique au moins jusqu'à la musculuse
- C- Cicatrisation par réépithélisation sur un bloc scléreux
- D- Absence d'altération vasculaire
- E- Sièges préférentiels au niveau des zones de moindre épaisseur.

L'ulcère duodénal :

- A- Est une affection quasi fréquente que le syndrome du côlon irritable
- B- Touche environ 2% de la population
- C- Est 3 ou 4 fois plus fréquent que l'ulcère gastrique
- D- Est beaucoup plus fréquente chez la femme
- E- A un pic d'incidence maximal entre 40 et 50 ans

Les assertions exactes concernant l'ulcère gastrique sont :

- A- Est associée généralement à une sécrétion acide élevée
- B- Est favorisé par des altérations de la barrière muqueuse.
- C- Est principalement dû à *helicobacter pylori*
- D- Est plus nettement influencé par des facteurs psychoaffectifs que l'ulcère duodénal
- E- Peut se canceriser

La douleur gastrique et duodénale :

- A. siège dans l'hypochondre gauche
- B. est habituellement sans irradiation
- C. est calmé par le bol alimentaire
- D. est soulagé par l'antéflexion du buste
- E. est aggravé par l'antéflexion du buste

Le ou les caractères suivants s'appliquent à la douleur d'un ulcère gastroduodénal :

- A. Elle perçue comme une crampe
- B. Elle est calmée par l'alimentation
- C. Elle est volontiers nocturne
- D. Elle permanente pendant la journée
- E. Elle est calmée par l'antéflexion

Une épi-gastralgie de type ulcéreux peut être observée au cours de :

- A. L'ulcère gastroduodénal
- B. L'ulcère gastrique
- C. La gastrite chronique atrophique
- D. Le cancer de l'estomac
- E. La gastrite chronique érosive

Parmi les symptômes suivants, lesquels sont évocateurs d'un syndrome ulcéreux typique :

- A. Douleur rythmée par les repas avec un intervalle de 2 heures
- B. Hypersécrétion acide
- C. Douleur épigastrique, sans irradiation
- D. Douleur à type de crampe
- E. Régurgitation

Parmi les propositions suivantes concernant la maladie ulcéreuse gastroduodénale, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s)?

- A- Elle est toujours associée à une douleur abdominale
- B- La douleur est le plus souvent post-prandiale tardive
- C- En cas d'ulcère bulbaire, la face antérieure est le plus souvent atteinte
- D- La douleur est aggravée par l'alimentation

E- Elle est le plus souvent secondaire à une infection par *Helicobacter pylori*

Indiquer parmi les éléments cliniques suivants celui qui ne caractérise pas un syndrome ulcéreux :

- A- La douleur est une crampe
- B - Son siège est épigastrique
- C - Son irradiation est scapulaire droite
- D - L'alimentation calme la douleur
- E - Son horaire est postprandial immédiat

Le diagnostic clinique d'un ulcère gastrique peut être rendu difficile par :

- A- L'absence de tout symptôme.
- B- La fréquence des symptômes atypique de type dyspepsie
- C- La ressemblance avec une douleur pancréatique.
- D- La grande fréquence des complications révélatrices de l'affection.
- E- La rareté du syndrome ulcéreux typique.

Concernant l'évolution d'un ulcère duodénal, cocher les assertions vraies :

- A- Lors du traitement d'une poussée ulcére, la cicatrisation est parallèle à l'évolution des douleurs.
- B- Une récurrence est attendue 1 fois sur 4 dans l'année s'il n'y a pas d'éradication d'*helicobacter*.
- C- Le tabac influence favorablement l'évolution
- D- Des risques de dégénérescence peuvent être observés après 10 à 15 ans d'évolution.

L'examen à réaliser en première intention dans le bilan d'un ulcère gastroduodénal est :

- A. Tubage gastrique basal
- B. Tomodensitométrie abdominale
- C. Gastrinémie basale
- D. Recherche d'une hyperthyroïdie
- E. Recherche d'*helicobacter pylori* dans la région antrale

L'examen complémentaire de premier choix pour le diagnostic au cours de l'ulcère gastroduodénal est :

- A- L'échographie abdominale
- B- La fibroscopie
- C- Le transit baryté gastroduodénal
- D- L'abdomen sans préparation
- E- La tomodesimétrie

Les buts du traitement de l'ulcère sont :

- A. cicatriser l'ulcère
- B. réduire les facteurs d'agression de la muqueuse
- C. éviter les récurrences

Les principes du traitement de l'ulcère :

- A. renforcer les facteurs de protection
- B. cicatriser l'ulcère
- C. éviter les récurrences
- D. réduire les facteurs d'agression de la muqueuse.

Au cours des complications hémorragiques de l'ulcère duodénal :

- A- Le siège antérieur de l'ulcère est de bon pronostic
- B- Le méléna est beaucoup plus fréquent que l'hématémèse
- C- Le pronostic est influencé par le terrain

- D- L'endoscopie est indispensable en urgence pour préciser le mécanisme du saignement
- E- La récurrence est moins fréquente si on éradique l'helicobacter ou en l'absence d'helicobacter on entreprend un traitement d'entretien.

Dans l'ulcère duodénal hémorragique, l'indication d'un traitement chirurgical doit être posée dans un ou plusieurs cas suivants. Le(s) quel(s) :

- A- Ulcère saignant en jet
- B- Collapsus mal contrôlé par traitement médical
- C- Récurrence de l'hémorragie au cours du traitement médical
- D- Hémorragie de moyenne abondance révélant la maladie ulcéreuse
- E- Sténose pyloro-bulbaire associée.

En présence d'une hématomérose grave par ulcère duodénal, l'importance de l'hémorragie sera au mieux appréciée par :

- A- La quantité de sang rejetée
- B- L'importance de la quantité de sang nécessaire pour rétablir et maintenir une tension correcte
- C- L'agitation du sujet
- D- La fréquence respiratoire
- E- La soif.

Dans une perforation d'ulcère duodénal on observe typiquement :

- A- Une contracture abdominale
- B- Un collapsus cardiovasculaire
- C- Une disparition de la matité pré-hépatique à la percussion
- D- Une température supérieure à 38°C
- E- Une douleur au toucher rectal
- F- Un pneumopéritoine sur la radiographie de face

Parmi les facteurs étiologiques suivants, quels sont deux qui apparaissent actuellement les plus importants en ce qui concerne l'ulcère gastroduodénal :

- A- L'hérédité
- B- Le tabac
- C- Le stress
- D- La prise d'AINS ou d'aspirine
- E- Infection à helicobacter pylori

Les mesures hygiéno-diététique à enseigner à une personne atteinte de l'ulcère gastroduodénal sont :

- A. Arrêter la consommation de tabac, d'épices, d'alcool
- B. Prendre les repas dans le calme et à heures régulières
- C. Bien mâcher les aliments

Le mot "gastre" est utilisé dans les mots : épigastre, douleur gastrique, gastrectomie. De quel organe s'agit-il ?

- A. Vessie
- B. Vésicule biliaire
- C. Colon
- D. Estomac

Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (s) qui correspond au rôle infirmier devant l'UGD :

- A. Expliquer au malade et son entourage les modalités et le but du traitement et lui faire accepter la nécessité de poursuivre la thérapeutique.
- B. Le régime alimentaire sera large, il faut donc exclure les aliments épicés et toutes boissons alcoolisés.
- C. Obtenir que le malade diminue ou supprime le tabac surtout le matin à jeun.
- D. Administrer et surveiller la thérapeutique
- E. Informer le malade que certains médicaments lui sont formellement contre indiqués (anticoagulants, AIS, AINS...) en raison du risque de rechute et d'hémorragie.
- F. Peser le malade une fois par semaine.
- G. Surveillance à chaque selle l'aspect la coloration, les selles noires feront signe de présence de sang ;
- H. Prendre le pouls et la TA 2 fois par jour et à la demande si le malade présente un tableau évoquant une hémorragie interne.

La détresse la plus fréquente lors d'une grave urgence digestive est :

- A. Circulatoire
- B. Respiratoire
- C. Cérébrale

Famien est reçu aux urgences pour hémorragie digestive sous forme de périodes de lipothymies inexpliquées avec collapsus. Choisir parmi les propositions suivantes les autres formes de manifestations d'une hémorragie digestive :

- A–Hématémèse B–Rectorragie C–Méléna

La complication immédiate en face d'un malade cirrhotique présentant une hémorragie digestive est :

- A. Varices Œsophagiennes B. Détresse Respiratoire C. Ulcère duodéal

Les circonstances favorisant l'hémorragie digestive :

- A. Prises d'alcool
- B. Prise d'aspirine
- C. Prise d'antiinflammatoire non stéroïdien
- D. Prise de corticoïde, d'anticoagulant
- E. Anomalie préexistante de l'hémostase

Indiquez les gestes en urgence immédiats que vous poserez devant une hémorragie digestive :

- A. Mise en place d'une voie veineuse de bon calibre
- B. Détermination du groupe sanguin et le facteur rhésus
- C. Correction d'une hypovolémie avec des macrolides
- D. Prévention des troubles de la déglutition

Dès que Famien a été déchoqué, le médecin prescrit une endoscopie haute. Le rôle de l'infirmier Avant la réalisation l'endoscopie haute est :

- A. Informer le patient sur le déroulement de l'examen : rapide, indolore mais très désagréable
- B. Mettre le patient à jeun strict au moins 6 heures avant l'examen
- C. Arrêter le traitement anticoagulant si le malade y est
- D. Arrêter le pansement gastrique au moins 48 heures avant le traitement
- E. Effectuer le bilan sanguin avec bilan de coagulation ou hémostase prescrit : TP=taux de prothrombine, TCA= temps de céphaline activé, numération plaquettaire
- F. Ce bilan permet de pratiquer des biopsies en cours d'endoscopie s'ils sont normaux.
- G. Attendre 3 jours pour faire passer une fibroscopie si le patient a passé un examen nécessitant l'injection de produit opaque.

Dès que Famien a été déchoqué, le médecin prescrit une endoscopie haute. Le rôle de l'infirmier Pendant la réalisation l'endoscopie haute est :

- A. Mettre le malade en décubitus latéral gauche
- B. Retirer les prothèses dentaires si nécessaire
- C. Mettre à la disposition du le médecin le matériel nécessaire
- D. Observer les réactions du patient au cours de l'examen.

Dès que Famien a été déchoqué, le médecin prescrit une endoscopie haute. Le rôle de l'infirmier Après la réalisation l'endoscopie haute est :

- A. Si l'examen a été effectué sous anesthésie générale le patient doit se reposer sur le côté pendant une longue période
- B. Mettre à la disposition du malade un haricot pour les vomissements et des compresses pour s'essuyer
- C. Prendre les constantes (pouls, tension artérielle) et les noter
- D. Surveiller la conscience, l'apparition d'éventuels signes hémorragiques
- E. Si l'examen a été effectué sous anesthésie générale attendre au moins 1 heure avant de reprendre l'alimentation
- F. Suivre les prescriptions médicales

La fibroscopie est un examen qui consiste à introduire une fibre optique dans le tube digestif.

- A. Vrai B. Faux

Le rôle de l'infirmier avant d'effectuer une fibroscopie consiste à :

A. Informer le patient sur le déroulement de l'examen : rapide, indolore mais très désagréable

- A. Mettre le patient à jeun strict au moins 6 heures avant l'examen
- B. Arrêter le traitement anticoagulant si le malade y est ;
- C. Arrêter le pansement gastrique au moins 48 heures avant l'examen
- D. Effectuer le bilan sanguin avec bilan de coagulation ou hémostase.

Cas clinique.

Un patient de 35 ans aux antécédents d'ulcère gastrique est admis dans le service de médecine pour hématomèse.

L'examen clinique relève les signes de gravité clinique suivants en cas d'hématomèse :

- A - Une tachycardie à 120 battements / min
- B - Une sensation de soif
- C - Une pâleur
- D - Une hypotension artérielle à 85/40 mmHg
- E - Des marbrures aux membres inférieurs

Le bilan biologique de l'hématomèse doit comporter :

- A – une numération formule sanguine
- B – un groupe sanguin
- C – une urée – créatinine
- D – ASAT – ALAT
- E – un TCK – TP

Pour assurer un remplissage vasculaire initial au cours de l'hématomèse, vous procédez à :

- A – la mise en place d'un cathéter veineux central jugulaire interne
- B – la perfusion d'emblée de solutés colloïdes
- C- la transfusion de culot globulaire
- D- la mise en place de deux voies veineuses périphériques aux membres supérieures de gros calibres (16G)
- E – la perfusion de 1 à 2 l de cristalloïdes

L'évaluation de l'efficacité de la prise en charge de l'hématémèse se fait sur :

- A – l'évolution de la pression veineuse centrale
- B – la diurèse horaire
- C – la mesure de la pression artérielle
- D – la fréquence respiratoire
- E – la fréquence cardiaque

La lithiase biliaire

La lithiase biliaire, c'est la formation de calculs à :

- A. L'intérieur de la vésicule biliaire
- B. L'intérieur du foie
- C. L'intérieur du pancréas mais obstruant l'écoulement de la bile produite par le foie

Les calculs biliaires sont de petits cailloux formés principalement par du cholestérol cristallisé. A. Vrai B. Faux

Lorsqu'il y a un excès de pigments biliaires, et aussi lorsqu'il y a défaut des sels biliaires il y a formation de calculs.

- A. Vrai B. Faux

Dans 80% des cas, les calculs sont asymptomatiques et il n'y a pas besoin de les traiter.

- A. Vrai B. Faux

Dans la majorité des cas, les calculs biliaires bouchent le canal cystique et le canal cholédoque

- A. Vrai, ces canaux mènent la bile jusqu'au duodénum
- B. Faux, les calculs biliaires ne peuvent pas atteindre le canal cholédoque

Le canal cystique et le canal cholédoque mènent la bile jusqu'au duodénum

- A. Vrai B. Faux

Lorsqu'un calcul obstrue les conduits qui mènent la bile vers le duodénum, on appelle cela une colique hépatique A. Vrai B. Faux

Une crise de colique hépatique dure en moyenne de 30 minutes à 4heures :

- A. Vrai B. Faux

Les douleurs s'estompent lorsque le calcul se déloge spontanément, permettant alors à la bile de s'écouler de nouveau normalement.

- A. Vrai B. Faux

Une personne qui a souffert d'une crise de colique hépatique risque, dans 70% des cas d'en subir d'autres. A. Vrai B. Faux

Les complications principales des calculs biliaires sont :

- A. La cholécystite aiguë (inflammation de la vésicule biliaire)
- B. L'angiocholite (inflammation des canaux biliaires)
- C. La pancréatite aiguë (inflammation du pancréas)
- D. La cystite

Parmi les signes fonctionnels suivant, indiquer ceux ou celui qui caractérise(nt) la lithiase biliaire :

- A. Douleurs à type de pesanteur de l'hypochondre droit
- B. douleurs qui surviennent après un voyage.
- C. vomissement bilieux.
- D. constipation,

E. Migraines

Les douleurs au cours de la lithiase biliaires est :

- A. situé dans l'hypochondre droit
- B. permanente à type de pesanteur ou de tension
- C. irradiant vers l'épaule droite et le dos
- D. déclenché par le régime riche en graisses
- E. situé dans flanc droit

Les symptômes d'une colique hépatique incluent :

- A. Une douleur intense et soutenue ressentie au milieu ou dans la partie supérieure droite de l'abdomen
- B. Méléna (selles noires)
- C. Une douleur qui irradie parfois vers l'épaule et l'omoplate droites
- D. Des nausées et des vomissements

Parmi les propositions suivantes concernant la crise de colique hépatique. Une est inexacte, laquelle :

- A. La douleur peut siéger dans l'hypochondre gauche.
- B. La douleur peut être soulagée par la pression profonde du creux épigastrique.
- C. L'irradiation de la douleur à l'épaule droite est fréquente.
- D. La douleur est liée à la mise en tension brutale des voies biliaires.
- E. Une douleur épigastrique brutale sans défense péritonéale évoque une colique hépatique

Le traitement habituel de la crise de colique hépatique non compliquée est représenté par la prescription de : une réponse est exacte, laquelle ?

- A. L'acide urso- ou chénodésoxycholique
- B. Un antibiotique
- C. Un antispasmodique
- D. Une sphinctérotomie endoscopique
- E. Une cholécystectomie

Le traitement habituel de la crise de colique hépatique non compliquée est représenté par la prescription de : une réponse est exacte, laquelle

- A. L'acide urso- ou chénodésoxycholique
- B. Un antibiotique
- C. Un antispasmodique
- D. Une sphinctérotomie endoscopique
- E. Une cholécystectomie.

Les symptômes donnant suite à une consultation d'urgence au cours d'une colique hépatique sont :

- A. Fièvre
- B. Ictère (signe avant-coureur d'une jaunisse)
- C. Méléna (selles noires)
- D. Douleur très intense et subite
- E. Douleur située du côté droit de l'abdomen et qui persiste au-delà de 6 heures
- F. Vomissements persistants.

Les facteurs de risque de la lithiase biliaire sont :

- A. Des œstrogènes

- B. L'obésité
- C. l'hérédité.
- D. L'hypothyroïdie
- E. Les maladies hémolytiques

Les symptômes donnant suite à une consultation d'urgence au cours d'une colique hépatique sont :

- A. Fièvre
- B. Ictère (signe avant-coureur d'une jaunisse)
- C. Méléna (selles noires)
- D. Douleur très intense et subite
- E. Douleur située du côté droit de l'abdomen et qui persiste au-delà de 6 heures
- F. Vomissements persistants

Les facteurs de risque de la lithiase biliaire sont :

- A. Des œstrogènes
- B. L'obésité
- C. l'hérédité.
- D. L'hypothyroïdie
- E. Les maladies hémolytiques

La prévention de la lithiase biliaire préconise de :

- A. Conserver un poids normal
- B. S'adonner régulièrement à des exercices physiques
- C. Consommer des bons gras
- D. Manger des fibres alimentaires
- E. Limiter l'apport en sucres

Les examens para-cliniques à demander en urgence au cours d'une crise de colique hépatique sont :

- A. ASP
- B. Echographie abdominale
- C. NFS,
- D. Urée- glycémie.
- E. Radiographie pulmonaire.

Le diagnostic d'une crise de colique hépatique se fait par l'échographie de l'abdomen :

- A. Vrai
- B. Faux

Le traitement d'une crise de colique hépatique se fait par :

- A. On calme d'abord la douleur (antispasmodiques, antalgiques non opiacés, AINS)
- B. L'ursodiol (Urso®) est un médicament (acide biliaire naturel) qui dissout les calculs composés de cholestérol (de six mois à deux ans de traitement)
- C. La chirurgie contre les calculs biliaires problématiques, on recommande le plus souvent l'ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)
- D. L'extraction des calculs lorsque ceux-ci bouchent le canal cholédoque.

La vésicule biliaire est un organe indispensable. La cholécystectomie doit être faite seulement lorsque la vie du patient est en jeu.

- A. Vrai
- B. Faux, l'ablation de la vésicule est de loin le traitement le plus efficace et avec des complications rares

Les calculs biliaires de cholestérol se forme lorsque :

- A. La bile contient trop peu de cholestérol

- B. La bile ne contient pas suffisamment de sels biliaires
- C. La vésicule biliaire ne se contracte pas régulièrement (la vésicule est alors dite « paresseuse »)

Les surveillances post-opératoires de la cholécystectomie peuvent être :

- A. Surveillance de la conscience, de la vigilance
- B. Surveillance de la couleur des téguments
- C. Surveillance du pouls, tension artérielle, diurèse
- D. Surveillance du drain de redon : contenu, quantité, aspect, absence de bile
- E. Surveillance du pansement

Chez une femme de 40 ans ayant fait une première crise de colique hépatique régressive sous traitement symptomatique, l'échographie abdominale montre une lithiasie vésiculaire simple.

Quelle est la conduite à tenir ?

- A. La prise régulière de spafon
- B. Un traitement dissolvant pendant 6 mois
- C. Un cathétérisme rétrograde avec sphinctérotomie endoscopique
- D. Une cholécystectomie
- E. L'abstention thérapeutique

Chez une femme de 40 ans, ayant fait une 2ème crise de colique hépatique typique mais régressive sous traitement symptomatique, le bilan biologique montre une augmentation des ALAT à 3 fois la valeur normale et des gamma GT à 4 fois la valeur normale régressive en 48 heures. L'échographie abdominale est strictement normale. *Quel examen complémentaire doit être réalisé ?*

- A. Une cholecystographie orale
- B. Une cholangiographie intra-veineuse
- C. Une échoendoscopie des voies biliaires
- D. Un cathétérisme rétrograde des voies biliaires
- E. Une cholangiographie transparétale

Parmi les signes radiologiques suivants, quel est celui qui permet d'affirmer l'existence d'une cholécystite aiguë ?

- A. une grosse vésicule biliaire
- B. la présence de calculs sous forme d'échos denses intra-vésiculaires
- C. une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques
- D. une dilatation de la voie biliaire principale
- E. un épaissement de la paroi vésiculaire

Parmi les signes radiologiques suivants, quel est celui qui permet de faire le diagnostic de cholécystite aiguë ?

- A. Présence d'une lithiasie vésiculaire calcifiée
- B. Présence d'une lithiasie vésiculaire calcifiée
- C. Présence de plusieurs lithiasies de petite taille non calcifiées
- D. Calculs enclavés dans le canal cystique
- E. Épaississement de la paroi vésiculaire
- F. Dilatation de la voie biliaire principale

Quelle(s) pathologie(s) parmi les suivantes peut (peuvent) être responsable(s) d'une anémie hémolytique ?

- a) Drépanocytose
- b) Leucémie aiguë lymphoblastique

- c) Déficit en G6PD
- d) Carence martiale prolongée
- e) Morsure de serpent venimeux

La lithiase biliaire, c'est la formation de calculs à :

- A. L'intérieur de la vésicule biliaire
- B. L'intérieur du foie
- C. L'intérieur du pancréas mais obstruant l'écoulement de la bile produite par le foie

Les calculs biliaires sont de petits cailloux formés principalement par du cholestérol cristallisé.

- A. Vrai
- B. Faux

Lorsqu'il y a un excès de pigments biliaires, et aussi lorsqu'il y a défaut des sels biliaires il y a formation de calculs.

- A. Vrai
- B. Faux

Dans 80% des cas, les calculs sont asymptomatiques et il n'y a pas besoin de les traiter.

Vrai Faux

Dans la majorité des cas, les calculs biliaires bouchent le canal cystique et le canal cholédoque

Vrai, ces canaux mènent la bile jusqu'au duodénum

Faux, les calculs biliaires ne peuvent pas atteindre le canal cholédoque

Une crise de colique hépatique dure en moyenne de 30 minutes à 4 heures : Vrai

Faux

Les douleurs d'une colique hépatique s'estompent lorsque le calcul se déloge spontanément, permettant alors à la bile de s'écouler de nouveau normalement. Vrai Faux

Une personne qui a souffert d'une crise de colique hépatique risque, dans 70% des cas d'en subir d'autres. Vrai Faux

Les complications principales des calculs biliaires sont :

- A. La cholécystite aiguë (inflammation de la vésicule biliaire)
- B. L'angiocholite (inflammation des canaux biliaires)
- C. La pancréatite aiguë (inflammation du pancréas)
- D. La cystite

Parmi les signes fonctionnels suivants quels sont ceux ou celui qui caractérise(nt) la lithiase biliaire :

- A. Douleurs à type de pesanteur de l'hypochondre droit
- B. douleurs qui surviennent après un voyage.
- C. vomissement bilieux.
- D. Constipation
- E. Migraines

Les douleurs au cours de la lithiase biliaires est

- A. Situé dans l'hypochondre droit
- B. permanente à type de pesanteur ou de tension
- C. irradiant vers l'épaule droite et le dos
- D. déclenché par le régime riche en graisses
- E. situé dans flanc droit

Le diagnostic de la lithiase biliaire se fait par l'échographie de l'abdomen : Vrai

Faux

Le traitement de la lithiase biliaire se fait par :

- A. On calme d'abord la douleur (antispasmodiques, antalgiques non opiacés, AINS)
- B. L'ursodiol (Urso®) est un médicament (acide biliaire naturel) qui dissout les calculs composés de cholestérol (de six mois à deux ans de traitement)
- C. La chirurgie contre les calculs biliaires problématiques, on recommande le plus souvent l'ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)
- D. L'extraction des calculs lorsque ceux-ci bouchent le canal cholédoque

Les symptômes d'une colique hépatique incluent :

- A. Une douleur intense et soutenue ressentie au milieu ou dans la partie supérieure droite de l'abdomen
- B. Méléna (selles noires)
- C. Une douleur qui irradie parfois vers l'épaule et l'omoplate droites
- E-Des nausées et des vomissements

Les symptômes donnant suite à une consultation d'urgence au cours d'une colique hépatique sont :

- A. Fièvre
- B. Ictère (signe avant-coureur d'une jaunisse)
- C. Méléna (selles noires)
- D. Douleur très intense et subite du côté droit de l'abdomen et qui persiste au-delà de 6 heures
- E. Vomissements persistants

Les personnes à risque sont :

- A. Les femmes. Elles sont 2 à 3 fois plus sujettes à la lithiase biliaire que les hommes (en cause l'œstrogène)
- B. Les femmes n'ayant pas donné de naissance. Plus les grossesses sont nombreuses, plus le risque diminue.
- C. Les personnes atteintes d'une maladie gastro-intestinale, comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse
- D. Le risque de calculs biliaires augmente aussi avec l'âge.

Les facteurs de risque de la lithiase biliaire sont :

- A. Des œstrogènes
- B. L'obésité
- C. l'hérédité.
- D. L'hypothyroïdie
- E. Les maladies hémolytiques

La prévention préconise de :

- A. Conserver un poids normal
- B. S'adonner régulièrement à des exercices physiques
- C. Consommer des bons gras
- D. Manger des fibres alimentaires
- E. Limiter l'apport en sucres

Les examens para-cliniques à demander en urgence au cours d'une crise de colique hépatique sont :

- A. ASP
- B. Echographie abdominale :
- C. NFS,
- D. Urée- glycémie.

E. Radiographie pulmonaire

La vésicule biliaire est un organe indispensable. La cholécystectomie doit être faite seulement lorsque la vie du patient est en jeu.

- A. Vrai
- B. Faux, l'ablation de la vésicule est de loin le traitement le plus efficace et avec des complications rares

Les calculs biliaires de cholestérol se forme lorsque :

- A. La bile contient trop peu de cholestérol
- B. La bile ne contient pas suffisamment de sels biliaires
- C. La vésicule biliaire ne se contracte pas régulièrement (la vésicule est alors dite « paresseuse »)

Dans le cancer de l'estomac, il est exact de dire que :

- A. Le cancer du cardia est épidermoïde
- B. Tout ulcère gastrique traité médicalement doit faire l'objet d'une surveillance endoscopique et biopsique
- C. Le cancer de l'antrum gastrique peut être sténosant
- D. Le cancer de l'estomac peut se révéler par une anémie
- E. Les hématuries importantes sont fréquentes dans le cancer gastrique

Un cancer de l'estomac peut être révélé par:

- A - Douleurs épigastriques
- B - Vomissements alimentaires
- C - Hématurie
- D - Phlébites récurrentes
- E - Constipation

Pour traiter de manière curative un cancer du sigmoïde on peut réaliser :

- A - Une colectomie segmentaire
- B - Une hémicolectomie gauche
- C - Une colostomie
- D - Une dérivation interne par anastomose
- E - Une amputation du rectum

Une femme de 62 ans, sans antécédent particulier, présente depuis 4 jours une fièvre à 38¹⁰, un ralentissement du transit intestinal et surtout une douleur de la fosse iliaque gauche; à l'examen, un empatement de cette région. Le toucher rectal est normal, la numération formule sanguine montre une leucocytose avec polynucléose. On doit évoquer :

- A - Colite ischémique
- B - Cancer du sigmoïde
- C - Diverticulite
- D - Maladie de Crohn chronique
- E - Toutes les réponses ci-dessus

La complication la plus fréquente en cas de cancer de sigmoïde :

- a. Abscess péri-sigmoïdien
- b. Fistule colo-vésicale
- c. Occlusion intestinale aiguë
- d. Perforation tumorale

Une dilatation de l'œsophage peut être observée en cas:

- a. D'un cancer du cardia
- b. D'un cancer du tiers inférieur de l'œsophage

- c. D'une maladie de Chagas
- d. D'une maladie des spasmes diffus de l'œsophage.

La localisation la plus fréquente des cancers colorectaux est

- a. Le caecum
- b. Le côlon descendant
- c. Le recto-sigmoïde

Un cancer du foie peut être révélé par :

- A- l'évolution d'une maladie du foie déjà existante.
- B- de problèmes digestifs
- C- de douleurs à l'abdomen.
- D- Un ballonnement abdominal à répétition

Un cancer primitif du foie désigne

- A- la formation de calculs au niveau du foie
- B- Une tumeur maligne qui s'est développée à partir des cellules du foie
- C- Une douleur qui se localise dans le flanc droit
- D- Des tumeurs formées de cellules cancéreuses qui se sont détachées d'une tumeur situées ailleurs dans l'organisme

Parmi les traitements suivant quels sont ceux qui peuvent être proposés en cas de traitement du cancer du foie?

- A- l'ablation partielle du foie sur laquelle se trouve la tumeur ;
- B- la greffe de foie
- C- la destruction tumorale à travers la peau
- D- la chimiothérapie

Dans le cancer de l'estomac, il est exact de dire que :

- A. Le cancer du cardia est épidermoïde
- B. Tout ulcère gastrique traité médicalement doit faire l'objet d'une surveillance endoscopique et biopsique
- C. Le cancer de l'antre gastrique peut être sténosant
- D. Le cancer de l'estomac peut se révéler par une anémie
- E. Les hématomés importantes sont fréquentes dans le cancer gastrique

Un cancer de l'estomac peut être révélé par :

- A - Douleurs épigastriques
- B - Vomissements alimentaires
- C - Hématémèse
- D - Phlébites récidivantes
- E-Constipation

Pour traiter de manière curative un cancer du sigmoïde on peut réaliser :

- A - Une colectomie segmentaire
- B - Une hémicolectomie gauche
- C - Une colostomie
- D - Une dérivation interne par anastomose
- E - Une amputation du rectum

Une femme de 62 ans, sans antécédent particulier, présente depuis 4 jours une fièvre à 38^o, un ralentissement du transit intestinal et surtout une douleur de la fosse iliaque gauche; à l'examen, un empatement de cette région. Le toucher rectal est normal, la numération formule sanguine montre une leucocytose avec polynucléose. *On doit évoquer*

- A - Colite ischémique
- B - Cancer du sigmoïde
- C - Diverticulite
- D - Maladie de Crohn chronique
- E - Toutes les réponses ci-dessus

Cette femme est porteuse d'un cancer occupant la moitié antérieure de l'ampoule rectale; le pôle inférieur de la tumeur est situé à 3 centimètres de la marge anale. Cette lésion est mobile et paraît extirpable. Si l'on peut donc réaliser une exérèse, *quelle sera la situation de la patiente après l'intervention curatrice habituellement pratiquée dans ce cas ?*

- A - Aura une cicatrice abdominale
- B - Aura une cicatrice périnéale
- C - Sera porteuse d'une iléostomie
- D - Sera porteuse d'une colostomie iliaque gauche
- E - Gardera son anus périnéal naturel

Complication la plus fréquente en cas de cancer de sigmoïde :

- a. Abscess péri-sigmoïdien
- b. Fistule colo-vésicale
- c. Occlusion intestinale aiguë
- d. Perforation tumorale

Une dilatation de l'œsophage peut être observée en cas :

- a. D'un cancer du cardia
- b. D'un cancer du tiers inférieur de l'œsophage
- c. D'une maladie de Chagas
- d. D'une maladie des spasmes diffus de l'œsophage.

La localisation la plus fréquente des cancers colorectaux est

- a. Le caecum
- b. Le côlon descendant
- c. Le recto-sigmoïde

Appareil respiratoire

La pleurésie est une inflammation chronique de la plèvre, avec ou sans épanchement

A vrai B faux

Le syndrome restrictif est une anomalie de la pompe respiratoire A. vrai B. faux

Le syndrome obstructif est une anomalie du diffuseur gazeux :

A. vrai B faux

L'asthme est une maladie caractérisée par une inflammation plus ou moins grave des voies respiratoires

A vrai B faux

Une crise d'asthme commence par une toux sèche, suivie d'une difficulté à respirer, qui provoque une respiration sifflante clairement audible : A vrai B faux

La ponction pleurale consiste à introduire une aiguille dans la cavité thoracique en vue de prélever le contenu : A vrai B faux

La ponction de la plèvre se fait dans un but, évacuateur et thérapeutique A vrai B faux

L'insuffisance respiratoire est une maladie inflammatoire, au long cours, des poumons et des bronches caractérisée par un rétrécissement des voies aériennes : A vrai B faux

Recueillir les urines émises et noter la diurèse en cas d'OAP permet d'apprécier les effets des diurétiques : A vrai B faux

Les tests tuberculiniques sont des réactions cutanées qui permettent de savoir si un individu a déjà été en contact avec le BK ou non : A vrai B faux

L'index tuberculinique : c'est le nombre d'enfants qui en 1 an voit les IDR devenir positives
A vrai B faux

12/ On fait un tubage pour recueillir le crachat et les sécrétions bronchiques déglutis au cours du sommeil : A vrai B faux

Les perfusions de soluté trop abondantes et trop rapides provoquent un OAP :

A vrai B faux

L'infection représente un facteur déclenchant fréquent de l'asthme :

A vrai B faux

Indiquez les deux bonnes réponses :

Les causes toxiques d'un OAP sont :

A. Gaz toxique irritant

B. Grippe

C. Hypertension artérielle

D. Monoxyde de Carbone

Les signes de gravité d'un OAP sont

- A. Trouble de la conscience
- B. Polypnée
- C. Bradycardie
- D. Picotements laryngés

Les signes généraux évocateurs d'une tuberculose pulmonaire sont

- A. amaigrissement
- B. toux
- C. asthénie
- D. douleur thoracique

Les signes de gravité de l'asthme sont

- A. agitation
- B. tachycardie
- C. dyspnée à type de bradypnée expiratoire
- D. saturation en oxygène en air ambiant inférieur à 90%

L'asthme s'installe suite à :

- A. un œdème bronchique avec contraction des muscles lisses bronchiques
- B. une hypersécrétion des cellules à mucus qui va aboutir à une diminution du calibre des bronches
- C. un gêne important au passage de l'air, réalisant ainsi le bronchospasme.

Le bronchospasme au cours de l'asthme est dû à une importante gêne :

- A. Vrai
- B. Faux

Au cours d'une crise d'asthme les bronches Voient leur calibre se réduire :

- A. c'est l'obstruction bronchique.
- B. S'inondent de mucus

L'inflammation dans l'asthme :

- A. Provoque un œdème et une infiltration cellulaire de la muqueuse bronchique
- B. Fait intervenir des mastocytes et des éosinophiles
- C. Diminue sous l'effet des β_2 mimétiques
- D. Disparaît entre les crises
- E. Contribue à l'obstruction bronchique

Les propositions justes parmi les suivantes concernant l'asthme

- A. L'asthme se manifeste par une dyspnée inspiratoire ?
- B. L'asthme se manifeste par une dyspnée expiratoire ?
- C. Cette dyspnée est à recrudescence nocturne ?
- D. Une toux est souvent associée à la dyspnée ?
- E. L'amélioration des symptômes d'asthme est souvent spontanée ou facilitée par les bronchodilatateurs

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

- A. L'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent aggraver l'asthme
- B. Les médicaments bêta-bloquants et calcium-bloquants sont contre indiqués chez l'asthmatique
- C. L'anxiété et la dépression peuvent aggraver l'asthme
- D. La pollution atmosphérique n'est pas assez importante pour aggraver l'asthme
- E. Les infections respiratoires peuvent aggraver l'asthme

Parmi les pathologies suivantes, lesquelles peuvent ressembler à un asthme et rendre son diagnostic plus difficile ?

- A. BPCO
- B. Syndrome de dysfonction des cordes vocales
- C. Bronchiolite
- D. Œdème aigu du poumon
- E. Corps étranger

La forme clinique de l'asthme qu'il faut redouter est l'état de mal asthmatique

Vrai faux

Comment se manifeste la forme clinique de l'asthme qu'il faut redouter, le mal asthmatique ?

- A. Une dyspnée intense avec tirage sus sternal et intercostal
- B. Une cyanose des extrémités
- C. Une tachycardie à plus de 130 battements par mn

L'obstruction bronchique au cours de la crise d'asthme s'explique schématiquement par :

- A. L'épaississement de la paroi des bronches.
- B. La persistance de l'inflammation des bronches
- C. La contraction des muscles qui entourent les bronches.
- D. La sécrétion de mucus épais et collant par la paroi des bronches

Citer 3 types de pneumallergènes (allergènes) pouvant déclencher une crise d'asthme.

- A. Acariens, B. Pollens, C. Phanères d'animaux, D. Blattes

Parmi les éléments suivants quels sont ceux qui sont exactes dans le cas de l'asthme

- A. La crise d'essoufflement aiguë est le symptôme de l'asthme le plus fréquent
- B. Les manifestations de l'asthme peuvent survenir à n'importe quel moment de la journée
- C. La toux peut-elle être le seul signe de l'asthme
L'intensité des symptômes de l'asthme peut être très variable
- D. Les symptômes peuvent aller d'une simple gêne à une véritable sensation d'étouffement.
- E. La crise d'asthme est la manifestation la plus fréquente de la maladie asthmatique

Concernant la pathologie asthmatique, quelles sont les propositions exactes ?

- A. L'asthme est une maladie inflammatoire bronchique
- B. Il existe une hypersécrétion bronchique associée
- C. Les bronches de l'asthmatique sont dites hyper-réactives
- D. La constriction des fibres musculaires lisses bronchiques est le seul élément, qui intervient pour rétrécir le diamètre bronchique chez l'asthmatique
- E. L'asthme est une maladie chronique

Les complications de l'asthme sont :

- A. Asthme à dyspnée continue B. Attaque d'asthme
- C. Les crises successives D. Les crises particulières
- E. Le mal asthmatique

Les complications aiguës de l'asthme comportent :

- A- Mort subite
- B- Pneumothorax
- C- Etat de mal asthmatique
- D- Œdème aigu du poumon
- E- Pneumo médiastin

Concernant l'asthme difficile, quels sont les items corrects,

- A. L'anxiété et la dépression sont possiblement en cause dans la difficulté à contrôler un asthme ?
- B. La consommation de psychotropes est plus importante chez les asthmatiques que dans la population générale ?
- C. Le reflux gastro-oesophagien doit être systématiquement recherché, par gastroscopie et/ou pHmétrie, en présence d'un asthme non contrôlé ?
- D. L'aspirine et les AINS sont contre-indiqués chez l'asthmatique ?
- E. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués chez l'asthmatique ?

Parmi les propositions suivantes concernant l'asthme aigu, la(es)quelle(s) est(sont) vraie(s) ?

- A. une crise d'asthme en apparence banale chez une femme enceinte doit être considérée comme potentiellement grave
- B. au cours des crises d'asthme suraiguës, le facteur spastique prédomine sur le phénomène inflammatoire
- C. les asthmes aigus graves nécessitant la ventilation mécanique augmentent
- D. au cours de l'asthme aigu grave, le facteur spastique prédomine toujours sur le phénomène inflammatoire
- E. les formes les plus sévères d'asthme aigu grave sont annoncées par des signes précurseurs

Au cours de l'asthme aigu, l'obstruction bronchique est responsable du(es) phénomène(s) suivant(s) :

- A. diminution des débits inspiratoires
- B. diminution des débits expiratoires
- C. augmentation du volume résiduel
- D. diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle

Le traitement de l'asthme aigu grave comporte :

- A- des aérosols de bronchodilatateurs
- B- des aérosols d'antibiotique
- C- des aérosols de sérum physiologique
- D- des corticoïdes par voie inhalée

Au cours de l'asthme aigu grave, quelle est la proposition exacte ?

- A- la présentation clinique la plus commune est une bradypnée inspiratoire avec un cornage
- B -la radiographie thoracique est inutile
- C -la présence d'une normocapnie est un signe de gravité
- D- la recherche d'un facteur déclenchant est inutile
- E -l'intubation avec ventilation mécanique doit être systématique

Lors d'une crise d'asthme, lequel de ces éléments est un marqueur de gravité ?

- A- l'hypocapnie
- B- la normoxie
- C- la normocapnie
- D- l'hyperleucocytose
- E l'existence de crépitations

Au cours d'une crise d'asthme sévère, quelle est l'affirmation vraie ?

- A- la radiographie standard n'est jamais normale
- B- le traitement repose sur oxygénation, bronchodilatateurs et corticoïdes
- C- il faut absolument allonger le malade bien à plat
- D- les antibiotiques doivent être prescrits systématiquement
- E- en cas de persistance de la crise, il ne faut surtout pas orienter le malade vers un secteur spécialisé de réanimation

Parmi les propositions suivantes, la(es)quel(les) est(sont) des signes de détresse au cours de l'asthme aigu grave ?

- A. fréquence respiratoire à 30/min
- B. somnolence
- C. orthopnée
- D. silence auscultatoire
- E. pauses respiratoires

Une crise d'asthme peut être déclenchée par :

- A. Des bêtalactamines
- B. Des bétamimétiques
- C. Une atmosphère chaude et humide
- D. Un effort
- E. L'aspirine

Les trois allergènes alimentaires les plus souvent en cause dans la crise d'asthme sont :

- A- le lait
- B- la viande
- C- l'œuf
- D- l'arachide
- E- les légumes
- F- les fruits

Les deux principaux moyens de mise en évidence d'une allergie sont :

- A. l'examen clinique
- B. l'interrogatoire
- les tests cutanés
- C. les tests biologiques
- D. les radiographies

Les différents types d'asthme :

- A. Asthme d'effort
- B. Asthme de la personne âgée
- C. Asthme allergique
- D. Asthme de l'enfant
- E. Asthme cardiaque
- F. Asthme professionnel

L'inflammation dans l'asthme :

- A. Provoque un œdème et une infiltration cellulaire de la muqueuse bronchique
- B. Fait intervenir des mastocytes et des éosinophiles
- C. Diminue sous l'effet des β_2 mimétiques
- D. Disparaît entre les crises
- E. Contribue à l'obstruction bronchique

Enumérer 4 des critères sur lesquels le médecin se base pour évaluer le contrôle de l'asthme.

- A. Les symptômes diurnes
- B. les symptômes nocturnes
- C. le recours aux médicaments de secours
- D. le retentissement sur les activités et la fonction respiratoire

Parmi les propositions suivantes concernant le traitement de l'asthme, lesquelles sont correctes ?

- A. La corticothérapie inhalée est le traitement de fond de référence ?
- B. La posologie de corticoïdes inhalés doit toujours être maximale pour assurer le contrôle de l'asthme ?
- C. Le traitement de fond peut faire appel à des bêta-2 mimétiques de courte durée d'action ?
- D. Le traitement de fond peut faire appel à des bêta-2 mimétiques de longue durée d'action ?
- E. le sevrage tabagique est indispensable à une prise en charge optimale de l'asthmatique ?

La gazométrie est l'étude de la teneur en oxygène et des gaz artériel ou capillaire ainsi que le PH.

Vrai Faux

Indiquez l'intérêt de cet examen qu'est la gazométrie : Evaluer l'importance de l'insuffisance respiratoire

Vrai Faux

Concernant la gazométrie effectuée, indiqué pour chaque chiffre l'anomalie

PH=7,47 : le PH est normal

SO₂=95% - valeur normale 97% le SO₂ est élevée

PCO₂= 35mmHg- valeur normale 40mmHg le PCO₂ est très élevé.

Parmi les propositions suivantes concernant les anomalies cliniques et gazométriques constatées au cours de l'asthme aigu grave, la(es)quel(les) est (sont) vrai(es) ?

- A. la pression artérielle baisse à l'inspiration par rapport à l'expiration
- B. l'inspiration est freinée
- C. l'hypercapnie est constante
- D. les muscles inspiratoires accessoires sont en tension permanente
- E. l'hypoxémie (en air ambiant) est constante.

Concernant les gaz du sang artériel suivants : pH : 7,58 ; PaCO₂ : 26,5 mmHg ; PaO₂ : 168 mmHg ; HCO₃⁻ : 25 mmol/L ; quelle affirmation est vraie ?

- A- il existe une hypoxémie
- B- il existe une alcalose respiratoire
- C- il existe une acidose respiratoire
- D- il existe une acidose métabolique à trou anionique augmenté
- E- il existe une acidose métabolique à trou anionique normal

À propos de l'embolie pulmonaire, laquelle de ces affirmations est vraie ?

- A- un dosage des D-dimères par méthode ELISA inférieur à 500 ng/mL élimine formellement le diagnostic
- B- la PaCO₂ est classiquement augmentée
- C- l'examen clinique peut être strictement normal
- D- la thrombolyse est toujours indiquée
- E- l'échographie doppler veineux des membres inférieurs est utile dans les formes graves

Quel signe clinique parmi les suivants est un critère de gravité en cas d'embolie pulmonaire ?

- A- la dyspnée
- B- la douleur thoracique
- C- la syncope
- D- l'hypertension artérielle systémique
- E- un bloc de branche droit sur l'ECG

La thrombolyse est indiquée en cas d'embolie pulmonaire :

- A- dans tous les cas
- B- en cas de choc
- C- en cas de polypnée > 35/min
- D- en cas de turgescence jugulaire
- E- jamais

Au cours de l'embolie pulmonaire grave, quelle est l'affirmation vraie ?

- A. les signes cliniques et paracliniques sont toujours les mêmes, d'un cas à l'autre
- B. si un état de choc est associé, le mécanisme en est généralement cardiogénique

- C. l'électrocardiogramme (ECG) affirme le diagnostic à chaque fois
- D. l'angioscanner spiralé n'est pas un très bon examen complémentaire
- E. l'échographie cardiaque n'est que de très faible intérêt

Au cours de la prise en charge de l'embolie pulmonaire grave, quelle affirmation est vraie ?

- A. la fibrinolyse est formellement indiquée dans tous les cas puisqu'elle lyse le thrombus
- B. l'embolectomie chirurgicale est très fréquemment mise en œuvre
- C. le traitement symptomatique associe oxygène, expansion volémique prudente et éventuel support vasopresseur
- D. le filtre cave améliore vite la situation E il n'existe pas de contre-indications aux anticoagulants

Le salbutamol (Ventoline):

- A. Est faiblement résorbé par l'arbre trachéobronchique
- B. A une faible biodisponibilité
- C. Stimule les récepteurs bêta2 bronchiques.
- D. Peut être responsable de tachycardie
- E. A une longue durée d'action

Parmi les effets indésirables de la théophylline, on cite:

- A. Les troubles digestifs
- B. La somnolence
- C. Les troubles du rythme cardiaque
- D. La dépression respiratoire
- E. Les convulsions

L'asthme semble influencer par des facteurs hormonaux, avec une recrudescence avant les règles.

- A. Vrai
- B. faux

Madame AF âgée de 35 ans, asthmatique depuis l'enfance, sous traitement de fond à base de fluticasone 1000 µg/j se présente aux urgences pour crise d'asthme. À l'examen, elle présente une fréquence respiratoire à 25 c/mn, une fréquence cardiaque à 100b/mn, des râles sibilants diffus à l'auscultation pulmonaire. Le débit expiratoire de pointe est à 70% de la théorique.

Le stade de sévérité de la crise d'asthme est : crise modérée

Que se passe-t-il dans les bronches au cours d'une crise d'asthme il y a :

- A. Une obstruction bronchique.
- B. Une augmentation bronchique
- C. Une multiplication bronchique

Rôle de l'infirmier auprès d'un patient asthmatique à l'accueil est :

- A. L'installer en position assise, maintenu par plusieurs coussins
Le rassurer et l'encourager
- B. Laisser la sonnette à sa portée afin qu'il puisse signaler une aggravation de son état respiratoire
- C. Prendre et noter les paramètres vitaux
- D. Surveiller la fréquence respiratoire

La pneumonie est :

- A- l'atteinte d'une portion d'un ou plusieurs lobes
- B- l'atteinte du parenchyme pulmonaire
- C- l'atteinte d'une partie du poumon

- D- Une inflammation des bronches
- E- Inflammation de la plèvre

On dit que la pneumonie est lobaire Lorsqu'elle

- A. touche une portion d'un ou plusieurs lobes
- B. touche le parenchyme du poumon
- C. touche les bronches

Citer trois étiologies de la pneumonie franche lobaire aigue :

- A. Haemophilus influenzae
- B. Mycoplasme pneumoniae
- C. Altération des moyens de défense de l'organisme
- D. Pneumocoque.

En ce qui concerne le mode d'installation de la pneumonie, indiquer les assertions qui sont exactes :

- A. Les germes (bactéries, virus ou parasites) qui envahissent le parenchyme pulmonaire provoque une réaction inflammatoire et provoque la formation d'exsudat (liquide suintant).
- B. Le suintement du liquide suite à la réaction inflammatoire nuit au déplacement et à la diffusion de l'oxygène et du gaz carbonique.
- C. Certaines parties du poumon ne sont pas et/ou plus ventilées adéquatement à cause des sécrétions, de l'œdème muqueux et du bronchospasme.
- D. Le sang veineux qui passent dans les zones hypo ventilées sort des poumons et se rend au cœur droit sans avoir été oxygéné.

Patient âgé de 35 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, ouvrier agricole consulte pour point de côté thoracique violent évoluant depuis 2 mois avec toux non productive, dyspnée avec polypnée. L'examen clinique relève à la percussion une matité siégeant au niveau d'un hémithorax avec au centre un foyer de râles crépitant à l'auscultation. La radiographie du thorax montre une opacité homogène, segmentaire.

Le diagnostic que vous évoquez en priorité face aux signes dans le cas de ce patient

- A. Pneumonie franche lobaire aigue
- B. Asthme
- C. Bronchite

Les arguments en faveur de ce diagnostic sont :

- A. point de côté thoracique violent
- B. toux non productive, dyspnée avec polypnée
- C. une matité siégeant au niveau d'un hémithorax à la percussion
- D. foyer de râles crépitant à l'auscultation.
- E. La radiographie du thorax montre une opacité homogène, segmentaire.

Lors de la phase d'état de la pneumonie franche lobaire aigue, les signes cliniques évoqués sont :

- A. Une fièvre en plateau à 40°
- B. Une oligurie avec urine foncée
- C. Une asthénie intense
- D. Une diarrhée
- E. Une polypnée
- F. Une langue saburrale
- G. Une toux productive
- H. Une anorexie
- I. Une tachycardie.

Une pneumonie franche lobaire aigue se traduit sur la radiographie du thorax par :

- A. Une opacité ronde de tonalité hydrique à limites nettes
- B. Une opacité parcourue par un bronchogramme aérique
- C. Une opacité à limites externes nettes et à limites internes noyées dans le médiastin
- D. Une opacité systématisée non rétractile

E. Une opacité à limite supérieure concave vers le haut

Au cours d'une Pneumonie Franche Lobaire Aigue, l'examen biologique porte sur :

- A. la recherche du germe dans le crachat
- B. le groupe +rhésus
- C. la NFS
- D. la vitesse de sédimentation qui sera très accélérée
- E. la radiographie du poumon

Au cours d'une pneumonie lobaire la vitesse de sédimentation est accélérée :

Vrai Faux

Le rôle de l'infirmier et de l'infirmière face à la Pneumonie Franche Lobaire Aigue est constitué :

- A. Accueillir et installer le malade
- B. Mener un interrogatoire pour rechercher les facteurs favorisant (éthylisme, vieillard, diabétique, affection maligne, immunodéprimé...)
- C. Etablir une feuille de température ou de surveillance
- D. Prendre et noter les paramètres vitaux (température, pouls, tension artérielle, fréquence respiratoire)
- E. Donner un crachoir pour recueillir les expectorations pour examen bactériologique
- F. Donner les consignes pour le recueil des expectorations
- G. Transporter les prélèvements au laboratoire immédiatement
- H. Faire les prélèvements de sang prescrits
- I. Administrer le traitement prescrit selon les doses indiquées et les horaires
- J. Effectuer ou Faire effectuer les examens radiologiques demandés
- K. Surveiller le contrôle des examens biologiques et radiologiques
- L. Surveiller les effets secondaires du traitement
- M. Assurer les soins d'hygiène et de confort (toilette générale, soins des orifices naturelles, changement de position, réfection de lit...)

Les consignes pour le recueil des expectorations sont :

- A. Le malade doit être à jeun
- B. Eliminer les crachats
- C. Recueillir les expectorations
- D. Expectorations recueillies pendant trois jours de suite

M foki vous consulte pour syndrome infectieux, il y a 15 jours. L'interrogatoire précise qu'il a fait des frissons, une asthénie, des céphalées, une sensation de faiblesse, avec baisse de l'appétit, courbature physiques, fièvre modérée à 38°C

Toux sèche accompagnée de sécrétions visqueuses de couleur verdâtre et d'une respiration bruyante.

A partir des signes cliniques décrits plus haut, indiquer l'affection

- A. Pneumonie franche lobaire
- B. Une bronchite aigue
- C. Asthme
- D. Pleurésie
- E. Tuberculose

La particularité de la bronchite aigue dans la majorité des cas est que les symptômes disparaissent d'eux-mêmes sans traitement en moins de 15 jours :

Vrai Faux

Le diagnostic infirmier correspondant au cas de M.foki

- A. Altération de la respiration reliée aux sécrétions bronchiques

- B. Perturbation des échanges gazeux reliés aux sécrétions bronchiques
- C. Dégagement inefficace des voies respiratoires relié aux sécrétions bronchiques

Parmi les signes cliniques suivants, quel est celui qui permet de distinguer une pneumonie d'une bronchite aiguë infectieuse ?

- A. une dyspnée
- B. une toux
- C. un foyer de râles crépitants
- D. une fièvre
- E. des ronchi bilatéraux

Bronchopneumopathie chronique obstructive

Mr RA âgé de 58 ans, tabagique à 60 PA est suivi à la consultation pour une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). L'examen physique trouve une fréquence cardiaque à 80c/min, une fréquence respiratoire à 24 c/mn, une distension thoracique et des râles bronchiques au niveau des bases. La gazométrie à l'état de base montre un pH à 7,39, une PaO₂ à 52 mmHg, une PaCO₂ à 47mmHg, HCO₃⁻ à 32 mmHg et SaO₂ à 88%. Sa spirométrie à l'état de base montre un VEMS à 1000 ml (40%) et à 1020 ml après bronchodilatation, la CVF est à 2300 ml (70%) et VEMS/CFV à 43% à 170 L/min (33 % de la théorique).

Que signifie l'abréviation BPCO bronchopneumopathie chronique obstructive

Les râles bronchiques sont

- A. Bruits surajoutés
- B. Bruits assourdisants
- C. Bruits de galope

L'examen clinique mène-t-on pour identifier les râles bronchique :

- A. L'auscultation.
- B. Préciser le stade de sévérité de la BPCO chez ce patient :
- C. Asthme aigu grave ou crise d'asthme sévère

Une oxygénothérapie au long cours est-elle indiquée chez ce patient ? Justifier votre réponse.

- A. Vrai
- B. Faux

Parmi les situations suivantes, la ou lesquels permet de mettre le malade sous une oxygénothérapie au long cours :

- A. Bronchopneumopathie non contrôlé :
- B. Depuis une semaine essoufflement
- C. gêne respiratoire
- D. survenue d'une exacerbation
- E. aucune réponse

En cas de dyspnée aiguë, les sibilants auscultatoires sont évocateurs d' :

- A. une pneumopathie bactérienne
- B. une épiglottite
- C. un épanchement pleural
- D. une crise d'asthme
- E. un pneumothorax

Un jeune enfant se présente dyspnéique aux urgences deux heures après avoir inhalé une cacahuète, votre premier réflexe est :

- A. de le forcer à s'allonger pour l'examiner
- B. de tenter la manœuvre de Heimlich
- C. d'appeler l'ORL
- D. de faire un ECG
- E. de prescrire un aérosol de bronchodilatateurs.

Quelle est, parmi les suivantes, la cause de dyspnée inspiratoire ?

- A. crise d'asthme non compliquée
- B. décompensation de BPCO pneumothorax
- D. œdème de Quincke
- E. œdème pulmonaire

Mr RA âgé de 58 ans, tabagique à 60 PA est suivi à la consultation pour une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). L'examen physique trouve une fréquence cardiaque à 80c/min, une fréquence respiratoire à 24 c/mn, une distension thoracique et des râles bronchiques au niveau des bases. La gazométrie à l'état de base montre un pH à 7,39, une PaO₂ à 52 mmHg, une PaCO₂ à 47mmHg, HCO₃⁻ à 32 mmHg et SaO₂ à 88%. Sa spirométrie à l'état de base montre un VEMS à 1000 ml (40%) et à 1020 ml après bronchodilatation, la CVF est à 2300 ml (70%) et VEMS/CFV à 43%.

Deux diagnostics différentiels à évoquer devant une pneumopathie abcédée chez un sujet tabagique

- A. cancer
- B. bronchopulmonaire
- C. pleurésie
- D. tuberculose pulmonaire.

Les éléments ci-dessous sont des indications du traitement chirurgical des dilatations des bronches sauf deux :

- A. Hémoptysies
- B. Complications infectieuses récidivantes
- C. Méléna
- D. une distension thoracique

Concernant la présence d'un bronchospasme bilatéral entendu en urgence et pour la première fois chez un malade, quelle est l'affirmation vraie ?

- A. la radiographie standard n'est jamais normale
- B. il n'est jamais dû à une embolie pulmonaire
- C. il peut traduire une insuffisance ventriculaire gauche
- D. il impose la prescription de bronchodilatateur
- E. il ne traduit jamais d'autre pathologie que respiratoire

Une insuffisance respiratoire aiguë est :

- A. Est un échec brutal et sévère de la capacité que possèdent habituellement les poumons à assurer les échanges gazeux entre l'air et le sang.
- B. Est la faillite rapide de la fonction d'échanges gazeux assurés par l'appareil respiratoire entraînant un état de détresse et d'urgence.

Parmi ces signes ou symptômes, quel est celui qui est primordial pour définir l'insuffisance respiratoire aiguë ?

- A. la douleur thoracique
- B. les marbrures
- C. une somnolence
- D. la cyanose

Lors d'une décompensation aiguë d'insuffisance respiratoire chronique obstructive avec bronchospasme et hypercapnie, lequel de ces traitements est contre-indiqué ?

- A. la ventilation mécanique invasive
- B. la ventilation mécanique non invasive
- C. les bêta-2-mimétiques
- D. l'oxygénothérapie à haut débit pour obtenir une SaO₂ à 100 %
- E. les anticholinergiques.

La tuberculose pulmonaire se définit comme : (indiquer les affirmations exactes)

- A. une maladie infectieuse, contagieuse,
- B. guérissable,
- C. sévit à l'état endémique dans toutes les régions du globe.

La tuberculose :

- A - Est liée à une infection par un virus
- B - Peut donner des lésions disséminées
- C - Peut prendre, macroscopiquement, un aspect pseudo-tumoral
- D - Peut comporter du caséum
- E - Est caractérisée par des follicules épithélioïdes et giganto-cellulaires

Les facteurs de risque de la tuberculose pulmonaire sont :

- A. L'insuffisance rénale
- B. L'incarcération
- C. L'infection par le virus HIV
- D. L'hypothyroïdie
- E. L'insuffisance cardiaque gauche.

En cas de suspicion de tuberculose pulmonaire quels sont les analyses bactériologiques à prescrire en priorité :

- A. Un examen cytbactériologique des crachats en spécifiant « recherche de mycobactéries »
- B. Trois examens cytbactériologiques des crachats en spécifiant « recherche de mycobactéries »
- C. Six examens cytbactériologiques des crachats en spécifiant « recherche de mycobactéries »
- D. Une PCR diagnostique sur les crachats car ce test est plus sensible que la culture
- E. Une hémoculture en spécifiant la recherche de mycobactéries car la tuberculose pulmonaire s'accompagne régulièrement d'une bactériémie.

M. P. 25ans est embauché en tant qu'infirmier Diplômé d'Etat dans un centre hospitalier. Sa visite médicale révèle une IDR à la tuberculine positive (10mm) d'induration. M. P. ne se plaint de rien, son auscultation est normale et n'a aucun antécédent. La radiographie pulmonaire systématique, réalisée par le médecin du travail, est normale.

M. P. a -t-il une tuberculose ? (cocher la bonne réponse)

- A. Oui, car son IDR est positive
- B. Non, il a une infection latente tuberculeuse car son IDR est positive, il a une cicatrice vaccinale de son BCG car son IDR est positive et le test IGRA est négatif

Parmi les facteurs suivants lesquels augmentent le risque de développer une tuberculose en cas d'infection tuberculeuse latente :

- A. Le diabète
- B. La prise au long cours de corticoïdes
- C. La coinfection par le virus de l'hépatite B
- D. La coinfection par le VIH
- E. L'éthylisme

La forme clinique de la tuberculose plus fréquente :

- A- Ganglionnaire
- B- Méningée
- C- Pulmonaire
- D- Pleurale
- E- Disséminée

L'infection tuberculeuse latente :

- A- Est une forme clinique contagieuse.
- B- Se caractérise par des cultures positives des prélèvements
- C- S'accompagne d'une IDR à la tuberculine et de tests IGRA positifs
- D- Se caractérise par un titre élevé d'anticorps dirigés contre *Mycobacterium tuberculosis*
- E- Evolue dans 90% des cas vers une maladie tuberculeuse.

Le risque de transmission du bacille tuberculeux est d'autant plus élevé en cas :

- A- BAAR visibles à l'examen microscopique des produits d'expectoration
- B- Proximité et longue exposition avec la source de contamination
- C- Retard dans l'instauration du traitement antituberculeux du malade contagieux
- D- TB pulmonaire non excavée
- E- Méningite tuberculeuse

Le mode de transmission du bacille tuberculeux se produit :

- A- Par contact avec des surfaces contaminées par du bacille tuberculeux
- B- Au cours de rapports sexuels
- C- De personnes à personne par l'air
- D- Par piqûre d'insecte
- E- Par piqûre de moustique.

*Parmi les affirmations suivantes concernant *Mycobacterium tuberculosis*, laquelle est exacte*

- A- C'est une bactérie à croissance rapide
- B- C'est une bactérie à développement strictement intracellulaire
- C- C'est une bactérie capable de résister à la phagocytose
- D- C'est une bactérie colorable par la méthode de Gram
- E- C'est une bactérie colorable par la méthode de Ziehl-Neelsen

C'est le bacille de Koch qui est responsable de la tuberculose

- A. Vrai
- B. Faux

La tuberculose est une maladie virale

- A. Vrai
- B. faux (maladie bactérienne)

On retrouve la tuberculose surtout dans les pays en voie de développement

- A. Vrai
- B. Faux

Les personnes à risques sont :

- A. Les sujets nés en zone endémique
- B. Les sujets vivants dans le luxe
- C. Les patients porteurs d'une immunodépression (VIH)

La transmission de la tuberculose se fait par voie aérienne seulement

- A. Vrai (par les gouttelettes de pfügge)
- B. Faux

La tuberculose évolue vers une infection latente puis une infection des voies bronchiques.

- A. Vrai
- B. Faux (par les macrophages)

Le bacille de la tuberculose pénètre les voies inférieures respiratoires où il sera phagocyté par les lymphocytes Tcd4

- A. Vrai
- B. Faux (il n'existe pas de tuberculose latente)

Lors de la dissémination de la tuberculose par voies bronchiques, les signes cliniques sont :

- A. Toux
- B. Hémoptysie
- C. Douleur thoracique et dyspnée
- D. Fièvre vespérale
- E. Hypersthénie
- F. Asthénie.

La symptomatologie typique de la tuberculose pulmonaire

- A. Asthénie ou sueurs nocturnes
- B. Anorexie
- C. Amaigrissement depuis plusieurs mois
- D. Toux insignifiante au début et qui s'aggrave avec le temps
- E. Expectoration au début muqueuse puis muco-purulente et purulente et parfois hémoptoïque
- F. Douleur thoracique
- G. Dyspnée
- H. Dysphonie.

L'examen biologique essentiel sur lequel repose le diagnostic de la tuberculose pulmonaire est Examen de crachat à la recherche de BK

- A. Vrai
- B. Faux

les critères de fiabilité bactériologique d'un prélèvement cyto bactériologique des crachats.

- A. Examen chez un malade à JEUN
- B. Donner de vrais crachats c'est-à-dire contenant des particules purulentes après un effort de toux
- C. Faire l'examen trois fois de suite
- D. Envoyer le plus rapidement possible le prélèvement au laboratoire.

La tuberculose peut être disséminée par la voie hématogène (à travers le sang, la lymphe)

- A. Vrai (tuberculose miliaire)
- B. Faux

Lors de la tuberculose, il y a obligatoire un syndrome

- A. Vrai
- B. Faux

L'échec d'un traitement d'une pneumonie avec altération de l'état général doit évoquer la tuberculose : VraiFaux

Le diagnostic de certitude est le fait de faire 3 prélèvements des expectorations spontanées matinales sur 3 jours consécutifs.

- A. Vrai
- B. Faux, un seul prélèvement suffit

L'intradermoréaction (IDR) à la tuberculine est un diagnostic de l'immunocompétence d'une personne à la tuberculose.

- A. Vrai
- B. Faux

La lecture se fait 48 heures après l'injection de tuberculine.

- A. Vrai
- B. Faux « 72h »

Le sujet est immunocompétence si l'IDR est inférieur à 5mm

- A. Vrai
- B. Faux « (supérieur à 10mm) »

Tout malade de tuberculose doit être :

- A. Être hospitalisé
- B. Placé en isolement respiratoire
- C. Placé en chambre individuelle
- D. Placé sous oxygénothérapie
- E. Placé sous assistance ventilatoire

Non traitée, la tuberculose est mortelle dans 100% des cas.

- A. Vrai
- B. Faux « 50% des cas » Non traitée,

La tuberculose est mortelle dans 100% des cas.

- A. Vrai
- B. Faux « 50% des cas »

La tuberculose n'est pas une maladie à déclaration obligatoire

- A. Vrai
- B. Faux

On traite la tuberculose avec 4 antibiotiques pendant les 2 premiers mois, puis 2 antibiotiques pendant les 4 mois suivants.

- A. Vrai (le traitement prolongé est indispensable afin de guérir la maladie et éviter l'émergence de souches résistantes.
- B. Faux

L'isoniazide et la rifampicine sont un exemple d'antibiotique utilisé en cas de tuberculose pulmonaire.

- Vrai
- Faux

Indiquer les affirmations dans les assertions suivantes :

- A Rifampicine ® et isoniazide (INH). R est contreindiqué en cas de grossesse
- B. R est un inducteur enzymatique diminuant les demi-vies de nombreux médicaments (contraception orale, corticoïdes, antiépileptiques, etc.....)
- C. Elle a une toxicité hépatique imposant un contrôle régulier des transaminases
- D. INH est contreindiqué chez l'alcoolique
- E. INH a comme effet secondaire des troubles de la vision à surveiller régulièrement
- F. 2RHEZ/4EH désigne le schéma le plus utilisé pour le traitement des nouveaux cas de T.

Parmi les effets indésirables neurologiques de l'isoniazide, on peut citer :

- A. La névrite optique rétrobulbaire
- B. La méningite
- C. Les neuropathies périphériques
- D. Les convulsions
- E. Les atteintes cochléo-vestibulaires

Le BCG est le vaccin contre la tuberculose

Vrai Faux

Le BCG n'est plus obligatoire depuis 2010 en Côte d'Ivoire

Vrai Faux

Combien de temps une personne souffrant d'une tuberculose contagieuse peut-elle contaminer d'autres personnes?

- A. en règle générale deux à trois semaines
- B. en règle générale au bout de trois jours
- C. en règle générale deux à trois mois
- D. en règle générale deux à trois semestres

Parmi les localisations ou formes suivantes, lesquelles sont des tuberculoses graves ?

- A. Ganglionnaire
- B. Uro-génitale
- C. Pulmonaire excavée
- D. Milliaire
- E. Pleurésie TB bilatérale
- F. Péricardite TB
- G. Méningite TB
- H. Mal de Pott

Les facteurs de risque de la tuberculose pulmonaire sont :

- A. L'insuffisance rénale
- B. L'incarcération
- C. L'infection par le virus HIV
- D. L'hypothyroïdie
- E. L'insuffisance cardiaque gauche

L'IDR à la tuberculine :

- A. mesure l'immunité cellulaire vis à vis de *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb)
- B. Elle est absolument spécifique de Mtb
- C. Elle est positive chez tous les sujets vaccinés par le BCG
- D. La prévalence de tests positifs permet de déterminer celle des sujets infectés par Mtb dans une population
- E. L'IDR positive si elle est lue à 48 h et consiste en une induration > 12 mm
- F. L'IDR est très utile dans le diagnostic de la maladie TB
- G. Elle est négative chez le sujet atteint de SIDA, même s'il présente une TB

L'index tuberculinique est le nombre d'enfants suivi en 1 an voit leur IDR devenir spontanément positive. A. Vrai B. Faux

Parmi les propositions suivantes concernant l'interprétation des réactions tuberculiniques, quelle est celle ou celles qui est ou sont exacte(s) ?

- A- Le délai correct de lecture de l'IDR à la tuberculine est de 24 heures
- B - La positivité des réactions tuberculiniques peut être due à une infection par des mycobactéries atypiques
- C - La négativité des réactions tuberculiniques peut être due à une infection virale intercurrente
- D - Chez un enfant antérieurement vacciné, l'augmentation franche de la positivité des réactions tuberculiniques traduit une surinfection exogène

Le DOTS est :

- A. Une stratégie de contrôle de la TB recommandée par l'OMS et s'adressant aux pays en développement

- B. Elle consiste uniquement en supervision par un observateur de la prise adéquate et régulière des médicaments par le malade
- C. Dans le système DOTS les médicaments sont gratuits
- D. Le DOTS est un système centralisé sur l'hôpital ou le malade doit se rendre pour recevoir son traitement
- E. 80% du coût du DOTS est représenté par le coût des médicaments
- F. le coût d'un traitement anti-TB complet de 6 mois est de l'ordre de 6000f Cfa

La supervision de la prise du traitement antituberculeux(DOTS) :

- A. Est assurée par le malade lui-même tout le long du traitement
- B. A pour but de détecter de façon précoce les effets secondaires du traitement
- C. Permet d'éviter la sélection de souches résistantes
- D. Consiste en la prise du traitement sous le contrôle d'une tierce personne
- E. Est indiqué uniquement pendant la phase d'attaque du traitement antituberculeux

Les règles du traitement antituberculeux sont :

- A. Jamais un seul médicament mais une association d'au moins 3 médicaments
- B. Le traitement doit être régulier
- C. respecter les doses prescrites
- D. La durée d'au moins six mois de traitement doit être respectée.

Les principes de la lutte ou traitement antituberculeux sont :

- A. Diagnostiquer les malades de BK
- B. Traiter les personnes atteintes de la tuberculose pulmonaire
- C. Vacciner les personnes non infectées
- D. Education pour la santé
- E. Améliorer les conditions socio-économiques

Les Groupes les plus à risque de développer une TB:

- A - personnes en contact avec un patient présentant une tuberculose pulmonaire à crachats positifs
- B - personnes en contact avec un patient présentant une tuberculose ganglionnaire fistulisée
- C - personnes VIH positives
- D - personnes sous corticoïdes ou autres immunodépresseurs dans les PED
- E - personnes souffrant de malnutrition ou de grande pauvreté
- F - enfants < 5 ans vivant dans l'entourage d'un tuberculeux
- G- sujets des pays développés qui voyagent en pays pauvres à haute endémie.

Parmi les propositions suivantes concernant les pleurésies tuberculeuses, quelles sont celles qui sont exactes?

- A - Une pleurésie tuberculeuse est de type exsudative
- B - Une pleurésie tuberculeuse s'accompagne à la cytologie du liquide d'un taux élevé de lymphocytes
- C - Une pleurésie tuberculeuse s'accompagne obligatoirement de la positivité des cultures de bacille de Koch dans le liquide pleural
- D - Peut être confirmé par l'histologie obtenue par l'étude de prélèvement pleural biopsique
- E - Est inconstamment associée à la positivité de l>IDR

Cardiologie

Quelles propositions concernant l'angine de poitrine sont vraies ?

- A. On l'appelle aussi l'angor
- B. Elle se traduit par une sensation de brûlure thoracique
- C. Cette douleur survient uniquement pendant l'effort
- D. C'est un symptôme d'un début d'ischémie myocardique.

Quelles propositions sont vraies à propos des bêta-bloquants, une des classes de médicaments de l'angor ?

- A. Ils favorisent la transmission adrénergique
- B. Ils inhibent le système sympathique
- C. Ils sont essentiellement administrés par voie orale
- D. Ils peuvent être prescrits dans l'hyper-tension artérielle (HTA) et l'insuffisance cardiaque à très faible dose

Un œdème aigu du poumon(OAP) est une inondation brutale des alvéoles pulmonaires et du tissu interstitiel par transudation du plasma provenant d'une augmentation de la pression capillaire pulmonaire

- A. OAP
- B. Asthme
- C. Infarctus du myocarde

Indiquer l'assertion exacte concernant le mécanisme (physiopathologie) d'installation de l'OAP

- A. La défaillance brutale du cœur gauche entraîne une baisse du débit cardiaque et une gêne du retour veineux pulmonaire.
- B. Une forte élévation des pressions en amont se crée et la sérosité plasmatique inonde les alvéoles pulmonaires.

Les signes d'OAP (œdème aigu du poumon) sont :

- A. Suffocation, cyanose, sueur, angoisse, torpeur.
- B. Dyspnée à type de polypnée
- C. Sensation de dépression thoracique
- D. Orthopnée (le patient ne supporte pas la position allongée, il est assis au bord du lit)
- E. Toux sèche puis expectoration abondante

L'œdème aigu pulmonaire

- A. Se manifeste par une détresse respiratoire aigüe.
- B. Est une manifestation d'insuffisance cardiaque gauche
- C. Survient à l'effort
- D. Peut s'accompagner d'hémoptysie

L'hépatomégalie de l'insuffisance cardiaque :

- A. est dure avec une surface irrégulière
- B. est lisse et douloureuse à la palpation
- C. est totalement indolore à la palpation
- D. est généralement associée à une vésicule palpable
- E. est parfois expansive en systole

Quel est l'élément sémiologique qui permet d'affirmer l'origine cardiaque d'une hépatomégalie ?

- A. Œdème des membres inférieurs
- B. Ascite
- C. Reflux hépatojugulaire
- D. Caractère douloureux
- E. Circulation collatérale

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des étiologies d'insuffisance ventriculaire gauche ?

- A. infarctus du myocarde antérieur étendu
- B. hypotension artérielle pulmonaire primitive
- C. myocardiopathie dilatée primitive
- D. communication interauriculaire
- E. rétrécissement aortique

Chez un malade en insuffisance cardiaque, l'utilisation des digitaliques est l'indication privilégiée en cas de :

- 1- bradycardie sinusale
- 2- bigéminisme ventriculaire
- 3- tachyarythmie par fibrillation auriculaire
- 4- tachycardie ventriculaire
- 5- rythme électrostimulé en permanence

Parmi les traitements suivants de l'insuffisance cardiaque, pour lesquels est-il important de surveiller la fonction rénale ?

- 1-Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC)
- 2- diurétique
- 3- épargneur potassique
- 4- nitré

Le tabac augmente le risque :

- A. De cancer bronchique à petites cellules
- B. De bronchite chronique obstructive
- C. De mésothéliome
- D. De fibrose interstitielle diffuse
- E. De syndrome ventilatoire restrictif

Lors d'une embolie pulmonaire de moyenne gravité l'examen des gaz du sang montre :

- A. Une hypoxémie avec hypercapnie
- B. Une hypoxémie avec normocapnie
- C. Une hypoxémie avec hypocapnie
- D. Une normoxémie avec hypercapnie
- E. Aucune de ces perturbations

Parmi les anomalies suivantes, quelles sont celles qui peuvent être responsables d'une cyanose ?

- A. Shunt gauche-droit
- B. Communication interventriculaire simple
- C. Communication interauriculaire et sténose artérielle pulmonaire
- D. Canal artériel
- E. Transposition des gros vaisseaux et communication interventriculaire

Vous êtes appelé auprès d'un malade en état de choc, avec une auscultation pulmonaire normale et des veines jugulaires externes turgescents. Parmi les diagnostics suivants, cette situation évoque pour vous:

- A. Une hémorragie interne
- B. Une embolie pulmonaire massive
- C. Une tamponnade
- D. Un infarctus inférieur avec extension au ventricule droit
- E. Un choc anaphylactique.

En l'absence de prophylaxie, le risque de thrombose veineuse est :

- A. Plus important chez l'enfant que chez l'adulte
- B. prise en charge en chirurgie
- C. Plus élevé pendant la grossesse normale par rapport à celui d'une femme du même âge non enceinte
- D. Augmenté sous contraception oestroprogestative
- E. Favorisé par la présence d'un anticoagulant circulant

Un homme de 50 ans consulte pour une douleur thoracique constrictive angoissante d'apparition récente survenant à la marche, forçant à l'arrêt et cédant rapidement. Quelle est la proposition la plus appropriée?

- A. Infarctus du myocarde ambulatoire
- B. Dystonie neurovégétative
- C. Angine de poitrine
- D. Dissection aortique débutante
- E. L'épreuve d'effort est indispensable au diagnostic

Le choc anaphylactique :

- A. Est fatal dans la majorité des cas
- B. Peut s'accompagner de manifestations cutanées à type d'urticaire
- C. Est surtout provoqué par des allergènes inhalés
- D. Est dû principalement à une libération d'hormone
- E. Est dominé par un collapsus vasculaire

Les facteurs favorisant une poussée d'insuffisance cardiaque :

- A. Une infection broncho-pulmonaire
- B. Une intervention chirurgicale abdominale
- C. Un stress modéré
- D. Un écart de régime
- E. Un trouble du rythme

Devant un jeune adulte apyrétique qui consulte pour une douleur thoracique gauche et une dyspnée aiguë fait penser à :

- A. Pneumonie franche lobaire aiguë
- B. Pleurésie ?
- C. Pneumothorax spontané
- D. Embolie pulmonaire
- E. Péricardite aiguë bénigne

L'insuffisance cardiaque est l'incapacité du muscle cardiaque à assurer un débit cardiaque avec un régime de pression de remplissage normal :

- A. Vrai
- B. Faux

L'insuffisance cardiaque est un phénomène de santé grave qui se traduit souvent par une dyspnée et une fatigue disproportionnées par rapport à l'effort produit :

- A. Vrai
- B. Faux

L'insuffisance cardiaque provient généralement :

- A. Du diabète
- B. De troubles cardiaques
- C. De troubles respiratoires
- D. D'hypertension artérielle
- E. D'hypotension artérielle

L'insuffisance cardiaque est une cause importante de mortalité chez les personnes âgées. Le taux de survie 5 ans après le diagnostic est d'environ 50%.

Vrai Faux

L'insuffisance cardiaque c'est :

- A. Lorsque le cœur n'a plus autant de force pour expulser le sang dans les artères
- B. Lorsque le cœur se remplit moins bien de sang parce qu'il s'est rigidifié
- C. Lorsque le cœur se remplit moins bien de sang parce qu'il s'est dilaté
- D. Lorsque les contractions du cœur sont efficaces
- E. Lorsque le sang met plus de temps à passer dans les artères et tend à stagner dans les veines

Généralement, l'insuffisance cardiaque ne touche que l'un des deux ventricules : Vrai
Faux

L'insuffisance cardiaque droite est la forme la plus fréquente :

Vrai Faux, c'est l'insuffisance cardiaque gauche

Lors d'insuffisance cardiaque droite, il y a accumulation des fluides au niveau des jambes et des chevilles, provoquant ainsi leur gonflement (œdème) : Vrai Faux

L'insuffisance cardiaque droite est souvent causée par une insuffisance cardiaque gauche :
Vrai Faux,

L'insuffisance cardiaque droite peut aussi être la conséquence :

- A. De la bronchite chronique
- B. De l'emphysème
- C. De l'embolie pulmonaire les symptômes de l'insuffisance cardiaque droite peuvent-être :
- D. Une asthénie (fatigue plus ou moins importante)
- E. Une pesanteur abdominale
- F. Des gaz intestinaux en grande quantité
- G. Des nausées, des vomissements, de la diarrhée
- H. Des douleurs de l'hypochondre droit (à droite de l'abdomen) provenant d'une affection hépatique

Lors de l'insuffisance cardiaque gauche, des fluides s'accumulent dans les tissus et se concentre principalement dans les poumons, entraînant des difficultés respiratoires marquées : Vrai Faux

L'insuffisance cardiaque gauche peut aussi être la conséquence :

- A. D'insuffisance hépatique
- B. D'une hypertension non traitée ou mal traitée
- C. D'angines de poitrine
- D. D'infarctus du myocarde

L'insuffisance cardiaque gauche peut être consécutive à :

- A. Une élévation de la tension artérielle
- B. Une atteinte des valvules telle qu'un rétrécissement
- C. Une insuffisance des valves aortiques ou des valves mitrales
- D. Une maladie cardiaque d'origine congénitale

L'insuffisance cardiaque gauche peut être consécutive à :

- A. Une cardiopathie de type ischémique (diminution ou un arrêt de la circulation du sang dans une ou plusieurs artères du cœur)
- B. Une myocardiopathie (maladie du muscle cardiaque proprement dit)
- C. Un trouble endocrinien (hyperthyroïdie : excès de sécrétion d'hormones thyroïdiennes)

L'insuffisance cardiaque est l'incapacité du muscle cardiaque assuré un débit cardiaque avec un régime de pression de remplissage normal

- A. Vrai B. Faux

L'insuffisance cardiaque est un phénomène de santé grave qui se traduit souvent par une dyspnée et une fatigue disproportionnées par rapport à l'effort produit :

- A. Vrai B. Faux

L'insuffisance cardiaque provient généralement :

- A. Du diabète
- B. De troubles cardiaques
- C. De troubles respiratoires
- D. D'hypertension artérielle
- E. D'hypotension artérielle

L'insuffisance cardiaque est une cause importante de mortalité chez les personnes âgées. Le taux de survie 5 ans après le diagnostic est d'environ 50% : Vrai Faux

L'insuffisance cardiaque peut :

- A. Entraîner une embolie pulmonaire
- B. Entraîner une hypertension intracrânienne
- C. Endommager le foie
- D. Endommager les reins

Les mesures préventives de l'insuffisance cardiaque sont :

- A. Une alimentation saine et salée
- B. De l'exercice physique
- C. L'arrêt du tabagisme
- D. Le contrôle de son hypertension
- E. Le contrôle de son taux de cholestérol et de son diabète

La vaccination contre la grippe et contre le pneumocoque est recommandée : Vrai
Faux

La nitroglycérine est un traitement d'urgence d'une crise aigüe d'insuffisance cardiaque
Vrai Faux, la nitroglycérine est extrêmement toxique

Les traitements disponibles de l'insuffisance cardiaque sont :

- A. Les diurétiques (en augmentant le volume d'urine, ils aident à éliminer le surplus de fluides qui s'accumule dans les poumons ou dans les membres)
- B. L'aspirine
- C. L'antagoniste de l'aldostérone (ce type de médicament a un effet diurétique)
- D. La digoxine (son effet tonique sur le cœur permet d'obtenir des contractions cardiaques plus efficaces)

Se peser le matin, après avoir uriné et constater une prise de poids égale à 3 kg en l'espace de 24 h est un signal d'alerte d'une insuffisance cardiaque.

- A. Vrai B. Faux : 1, 5 kg suffit

Les patients en insuffisance cardiaque ont souvent une soif intense :

- A. Vrai, en dépit qu'ils aient trop d'eau dans le corps à cause des troubles de circulation sanguine
- B. Faux, ils ont trop d'eau dans le corps alors ils ne boivent pas suffisamment

Dès l'admission d'une personne victime d'une insuffisance cardiaque à l'hôpital, quelles sont les actions principales que doit accomplir l'équipe soignante non médicales ?

- A. Installer le patient en position couchée
- B. Oxygénation
- C. Prendre une voie veineuse de bon calibre
- D. Dépister les signes de choc et d'œdème aigu du poumon
- E. Prendre les constantes (tension artérielle, pouls, fréquence respiratoire)

L'examen complémentaire à pratiqué obligatoirement être en urgence est : échographie abdominale

La finalité de la pratique de l'examen complémentaire en urgence est : échographie abdominale car la plaie siège dans la zone charnière thoraco-abdominale et on doit craindre une rupture diaphragmatique ou d'un organe intra-abdominal

Les reins, qui reçoivent aussi moins de sang (fatigue du cœur), réagissent en limitant les pertes de fluides par l'urine. Ce phénomène se nomme rétention d'eau :

- A. Vrai, La rétention d'eau favorise l'œdème et une augmentation du volume de sang, qui contribue en retour à fatiguer le cœur. Cercle vicieux.
- B. Faux, les reins n'ont pas d'influence sur l'insuffisance cardiaque

L'insuffisance cardiaque peut :

- A. Entraîner une embolie pulmonaire
- B. Endommager le foie
- C. Entraîner une hypertension intracrânienne
- D. Endommager les reins

Le diagnostic de l'insuffisance cardiaque se fait :

- A. Par le dosage des différents constituants du sang (cholestérol, glucose, potassium, créatinine...)
- B. Par le dosage du peptide natriurétique de type B (BNP afin de déterminer le degré de l'insuffisance)
- C. La radiographie de la poitrine (La silhouette du cœur informe de son état et permet de vérifier la présence de liquide dans les poumons)
- D. Un électrocardiogramme (Il permet de détecter les arythmies et les troubles de conduction électrique à l'intérieur du cœur)
- E. Échocardiographie (existence d'une malformation, la taille des ventricules, l'état des valves du cœur, les traces d'un ancien infarctus...)

Pour éviter que l'insuffisance cardiaque ne s'aggrave, les mesures préventives sont :

- A. Maintenir un poids dans les limites des normes
- B. Apprendre à mieux contrôler le stress
- C. Limiter la consommation d'alcool
- D. Limiter une alimentation trop riche en sel ou en gras
- E. Eviter la consommation excessive d'eau, de jus, de boissons ou de soupes

*La vaccination contre la grippe et contre le pneumocoque est recommandée : Vrai
Faux*

Les patients en insuffisance cardiaque ont souvent une soif intense :

- A. Vrai, en dépit qu'ils aient trop d'eau dans le corps à cause des troubles de circulation sanguine
- B. Faux, ils ont trop d'eau dans le corps alors ils ne boivent pas suffisamment dès l'admission d'une personne victime d'une insuffisance cardiaque à l'hôpital,

Les actions principales que doit accomplir l'équipe soignante non médicales sont :

- A. Installer le patient en position couchée
- B. Oxygénation
- C. Prendre une voie veineuse de bon calibre
- D. Dépister les signes de choc et d'œdème aigu du poumon
- E. Prendre les constantes (tension artérielle, pouls, fréquence respiratoire)

Chez un malade en insuffisance cardiaque, l'utilisation des digitaliques est l'indication privilégiée en cas de :
bradycardie sinusale

- A- bigéminisme ventriculaire
- B- tachyarythmie par fibrillation auriculaire
- C- tachycardie ventriculaire
- D- rythme électrostimulé en permanence

Parmi les médicaments suivants utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, quel est celui qui est contre indiqué en cas de trouble rythmique ventriculaire ?

- A. digitalique B. beta-bloquant C. diurétique D. IEC

Parmi les traitements suivants de l'insuffisance cardiaque, pour lesquels est-il important de surveiller la fonction rénale ?

- A. inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC)
- B. épargneur potassique
- C. diurétique
- D. Nitré

L'œdème aigu du poumon est une inondation brutale des alvéoles pulmonaires et du tissu pulmonaire interstitiel par transsudation du plasma provenant d'une augmentation de la pression capillaire pulmonaire : Vrai Faux

L'augmentation de la pression capillaire pulmonaire au cours de l'œdème aigu du poumon est due à une baisse du débit cardiaque et une gêne du retour veineux pulmonaire : Vrai Faux

Indiquer parmi les signes suivants ceux qui évoquent une manifestation de détresse respiratoire

- A. asphyxie aigu. B. Suffocation,
- C. cyanose, D. sueur,
- E. angoisse, F. position assise
- G. polypnée > 30/min. H. oppression thoracique

Citer deux examens biologiques et un examen radiologique à effectuer chez un patient atteint d'OAP

- A-Urée B-ionogramme-créatinine
- C-enzyme cardiaque D-NFS
- E-bilan de coagulation F-gaz du sang G-bilan urinaire

Devant un malade présentant un infarctus du myocarde, relevez-le ou les éléments de soutien psychologique à lui transmettre

- A. Rassurer le patient,
- B. Aider le malade à s'adapter à l'environnement
- C. Adopter une attitude sûre, détendue, rassurante,
- D. Expliquer les soins et leurs objectifs,
- E. Informer le patient du fonctionnement des appareils

Les perfusions et les transfusions sanguines provoquent un œdème aigu pulmonaire :

- A. Lorsqu'elles sont installées très tôt le matin
- B. Lorsque leur débit est trop rapide
- C. Lorsqu'elles sont suivies d'un régime désodé
- D. Lorsqu'il y a une inadéquation d'un traitement

Parmi les examens suivants, quels sont ceux que peut demander le médecin au cours d'un œdème aigu pulmonaire ?

- A- Taux de prothrombine Temps de céphaline kaolin
- B- ionogramme sanguin C- E.C.G.
- D- N.F.S. E- Bilan urinaire.

Parmi les affirmations, Quelle est ou quelles sont celle (s) qui correspondent au rôle de l'infirmier devant un cas d'œdème aigu pulmonaire ?

- A. Prévenir le médecin
- B. Mettre le malade en position assise ou demi-assise.
- C. Surveiller l'oxygénothérapie en continu à 6-9 l/min.
- D. Prendre la tension artérielle et la fréquence cardiaque, amplitude et fréquence respiratoire, saturation en oxygène.
- E. Mettre le patient sous monitoring et effectuer une électrocardiographie (ECG).
- F. Pose d'une voie d'abord de gros calibre.
- G. Prélèvement sanguin par ponction veineuse : enzyme cardiaque (CPK, troponine), ionogramme, hémogramme, hémostase.
- H. Prélèvement sanguin par ponction artérielle pour gazométrie.
- I. Radiographie pulmonaire.
- J. Établir une feuille de surveillance et marquer les paramètres prise
- K. Réduire la pression capillaire pulmonaire en diminuant le volume sanguin : faire uriner, restriction hydrique, vasodilatation veineuse.
- L. Préparation pour intubation et ventilation assistée dû à l'hypocapnie.
- M. Aider le malade à rejeter les expectorations

L'embolie pulmonaire se manifeste par

- A- une dyspnée aiguë
- B- Son examen clinique est souvent normal
- C- Le cliché thoracique est souvent normal
- D- L'électrocardiogramme est souvent normal

L'embolie pulmonaire est l'obstruction brutale et massive de l'artère pulmonaire ou d'une de ses branches principales par un caillot de sang : Vrai faux

Le tableau clinique caractéristique d'une embolie pulmonaire :

- A. Début brutal : en plein sommeil le malade se réveille par des picotements laryngés et surtout une sensation d'étouffement
- B. Le malade assis dans son lit présente :
- C. Une polypnée
- D. Des sueurs
- E. Angoisse
- F. Il est pâle, cyanosé
- G. Des quintes de toux ramenant des expectorations abondantes, mousseuses.

Le mécanisme d'apparition d'une embolie pulmonaire se présente comme suit :

- A. La défaillance brutale du cœur gauche entraîne une baisse du débit cardiaque et une gêne du retour veineux pulmonaire.

- B. Une forte élévation des pressions en amont se crée et la sérosité plasmique inonde les alvéoles pulmonaires.
- C. Les échanges gazeux se font mal, on observe alors une hypoxie et une hypocapnie.
- D. Le patient se met à hyper ventiler pour compenser le manque d'oxygène.

L'orthopnée

- A- Survient à l'orthostatisme
- B- Survient à l'effort
- C- Survient en décubitus
- D- Est un signe d'insuffisance cardiaque

Le germe le plus fréquemment retrouvé dans les pneumopathies aiguës de l'adulte est :

- A- Hémophilus influenzae
- B- Pneumocoque
- C- Staphylocoque aureus
- D- Mycoplasma pneumoniae
- E- Legionella pneumophila

Parmi les méthodes suivantes, quelle(s) est (sont) la (ou les) plus intéressante pour effectuer le diagnostic bactériologique au cours des pneumopathies aiguës de l'adulte.

- A- Ponction Trans trachée
- B- Examen bactériologique des crachats
- C- Prélèvement endoscopie
- D- Hémoculture
- E- Fibroscopie

Mr AB âgé de 45ans, tabagisme est traité pour une pneumopathie infectieuse de la base pulmonaire gauche. L'évolution est favorable avec nettoyage radiologique complet. Quel examen systématique doit être indiqué chez ce patient ; Fibroscopie bronchique.

Au cours d'un œdème aigu du poumon cardiogénique, quelle est l'affirmation vraie ?

- A l'électrocardiogramme (ECG) est inutile
- B une hypotension artérielle n'est pas un signe de gravité
- C une expansion volémique est injustifiée parce que délétère
- D les diurétiques sont inutiles
- E l'échographie cardiaque est un examen invasif inutile

4 étiologies possibles d'une pleurésie transsudative sont :

- A. Insuffisance cardiaque gauche ou globale
- B. Péricardite chronique constrictive
- C. Cirrhose
- D. Syndrome néphrotique ou Insuffisance rénale
- E. Atélectasie pulmonaire
- F. Dénutrition

Préciser le mécanisme de l'obstruction bronchique au cours de l'emphysème pan lobulaire : collapsus expiratoire des voies aériennes qui sont atrophiques et sans support parenchymateux

Citer 3 bactéries incriminées dans les pneumopathies atypiques

- A. Legionellapneumophila
- B. -Mycoplasmapneumoniae
- C. Chlamydia psittaci-
- D. Coxiellaburnetii

Chez une femme enceinte de 8 mois, vous avez la certitude d'une thrombose veineuse fémorale sans embolie pulmonaire. Quelle thérapeutique préconisez-vous dans l'immédiat ?

- A. Antivitamines K avec doses de charge
- B. Héparinothérapie
- C. Antiagrégants plaquettaires
- D. Traitement thrombolytique

E. Interruption de la veine cave inférieure

Les manifestations cliniques d'une insuffisance cardiaque globale sont :

- A. Une dyspnée à l'effort ou permanent
- B. Une toux
- C. Une expectoration
- D. Une tachycardie
- E. Des modifications des chiffres de la tension
- F. Un reflux hépato-jugulaire
- G. Une oligurie

Citez deux examens au plan rénal, au plan cardiaque et au plan neurologique de première intention dans le bilan de retentissement de l'hypertension artérielle chez un malade hypertendu.

Examens au plan rénal :

urée- créatinine

au plan cardiaque :

électrocardiogramme : ECG

radio pulmonaire

au plan neurologique :

électroencéphalogramme

En vous référant à vos connaissances pharmacologiques, indiquez les classe thérapeutique des produits suivants : risordan 10mg, adalate LP. Nibiol ;

classe thérapeutique des produits

risordan 10mg, vasodilatateur coronarien

adalate LP. antihypertenseur

Nibiol antibactérien urinaire

Au cours de la prise en charge le médecin instaure le traitement suivant : Héparine : 30 000UI en IV par 24 heures

Examens : taux de prothrombine ; temps de quick et de Howel

la classe thérapeutique et l'antidote de l'héparine

- A. un médicament anticoagulant
- B. un médicament antibiotique
- C. un médicament anti-inflammatoire

Les effets secondaires de l'héparine :

Les anticoagulants freinent le processus de coagulation du sang et cette action prévient la formation de dangereux caillots dans les vaisseaux sanguins.

L'intérêt des examens (taux de prothrombine ; temps de quick et de Howel) demandés dans le traitement est :

- A. Suivre l'évolution de la maladie
- B. Surveiller les saignements
- C. Poser le diagnostic

Parmi les affirmations suivantes celle(s) cocher celle 's) est (sont) exacte(s)

A - L'athérosclérose est la principale cause de mortalité dans les pays africains

B - Hypercholestérolémie, tabagisme, hypertension artérielle sont les trois principaux facteurs de risque d'athérosclérose

- C - Les lipoprotéines de haute densité (HDL) sont particulièrement athérogènes alors que les lipoprotéines de basse densité (LDL) protègent de l'athérosclérose.
- D - Il existe une relation très forte entre la consommation de tabac et l'incidence de l'infarctus du myocarde et de la mort subite
- E - La prévention cardio-vasculaire doit être multi-factorielle

Cas : vous recevez M.DUPUIS pour : douleurs du membre inférieur +/- importantes crampes, pesanteur au niveau du mollet, sensation d'engourdissement avec une dissociation pouls / température avec une fébricule 37° – 37°8, douleur à la palpation le long du trajet veineux, œdème du mollet : le mollet prend le godet. Douleurs intenses et tenaces sur tout le membre inférieur qui irradient allant même jusqu'à l'impotence fonctionnelle complète Fièvre, Tachycardie ; Œdème cylindrique : jambe en poteau douloureux, Mollet chaud, blanc, dur, qui ne prend pas le godet.

L'affection à laquelle vous pensez

- A. Phlébite
- B. l'infarctus du myocarde
- C. Insuffisance cardiaque

La Phlébite est une inflammation d'une veine le plus souvent profonde oblitérée ou bouchée par la formation d'un caillot (thrombus). Vrai faux

Les méthodes physiques pour la prévention des phlébites au cours de la surveillance infirmière :

- A. Lever précoce sur prescription médicale chez tout patient susceptible d'avoir une phlébite
- B. Mobilisation active et passive des membres inférieurs : contracter les muscles
- C. Contention des membres inférieurs sur prescription médicale
- D. Il s'agit d'augmenter le retour veineux et de diminuer les œdèmes, à mettre impérativement avant le lever de la personne et éduquer la personne à les mettre en place elle-même.

La différence entre une syncope et un coma :

La syncope est une perte de connaissance brutale, totale et brève, spontanément réversible en 1 à 2 minutes.

A quoi correspondent les signes suivants : une pâleur, un refroidissement des extrémités, une tachycardie, des veines collabées, instabilité de la TA, une diminution du débit urinaire :

- A. Choc
- B. Syncope
- C. collapsus cardiovasculaire

Un choc hypovolémique résulte de la perte de liquide par le système circulatoire, donnez les différentes modes de perte de liquide :

- A. Hémorragie : une telle perte résulte habituellement d'une blessure (qui provoque une hémorragie)
- B. Brûlure (qui entraîne la perte de plasma)
- C. déshydratation (qui est une perte de liquide).

Cas : En congé au village vous recevez M. Agniblou. Après une sommaire anamnèse, vous diagnostiquez un choc. Vous effectuez des gestes simples de maintien des fonctions vitales tout en essayant d'en déterminer l'étiologie. Indiquez ces gestes :

- allonger complètement le patient s'il n'existe pas de détresse respiratoire ; sinon mettre les jambes à l'horizontale, le patient étant en position demi-assise. Les jambes peuvent être

également surélevées par un coussin (Position déclive ou Position de Trendelenburg (tête basse, pieds surélevés) pour assurer une irrigation du cerveau en sang) ;

- mettre en place une ou deux voies veineuses de gros calibre avec soluté cristalloïde ou colloïde si possible ;
- dégager les voies aériennes supérieures;
- prendre le pouls,
- mesurer à intervalles courts la pression artérielle.
- Administrer des calmants si possibles

Les différents stades du coma sont :

- A. Coma stade 1 ou coma vigil : Le malade réagit aux stimulations douloureuses en ouvrant les yeux
- B. Coma stade 2 : Les réactions aux stimulations disparaissent mais les réactions motrices persistent
- C. Coma stade 3 ou coma carus : Disparition de toutes réactions motrices et apparition de troubles oculaires et végétatifs.
- D. Coma stade 4 ou coma dépassé : Il y a une mort cérébrale, cependant l'activité cardiaque persiste.

Indiquez deux causes probables du coma ;

Causes post traumatiques-accidents vasculaires cérébraux-causes métaboliques (hypoglycémie, diabète, urémique, hépatique)-causes toxiques (oxycarboné, barbiturique, éthylique)-causes neurologiques (épilepsie, éclampsie, hystérie).

Un état de choc se définit comme : une inadéquation entre les apports en oxygène (O₂) et la demande en O₂ cellulaire quand le cœur ne pompe pas assez de sang pour remplir les artères avec une pression sanguine nécessaire pour faire parvenir l'O₂ aux organes et aux tissus.

Le rôle de l'infirmier dans la surveillance d'un malade choqué est :

- A. -l'installer en décubitus dorsal dans un endroit calme
- B. rechercher les premiers signes d'une insuffisance circulatoire basée sur la mesure et la surveillance de :
- C. -la fréquence cardiaque
- D. -la pression artérielle
- E. -la coloration des extrémités et la chaleur cutanée
- F. -la diurèse
- G. -l'état de conscience
- H. l'état respiratoire et la température
- I. Participer à la pratique des examens complémentaires : biologiques et radiologiques groupe sanguin et facteur rhésus, ionogramme sanguin et urinaire, ECG, radio pulmonaire, hémoculture
- J. -réunir le matériel de soins et de surveillance
- K. assurer la surveillance clinique, des moyens diagnostics et thérapeutique.

Définissez les termes suivants : électrocardiogramme, pulsations Electrocardiogramme : enregistrement graphique des phénomènes de la révolution cardiaque.

Pulsation : est la sensation de soulèvement que l'on perçoit en déprimant légèrement une artère sur un plan osseux.

Cas : M^{lle} L. a 24 ans. Devant un épisode d'essoufflement et de céphalées, sensation de mouches volantes, sa pression artérielle est chiffrée à 240/140 mm de mercure. Elle prend des

oestroprogestatifs depuis six mois. Elle n'a pas d'antécédent pathologique personnel ou familial particulier.

L'examen clinique confirme le caractère fixe de l'élévation tensionnelle, il est négatif par ailleurs.

Les examens biologiques avant tout traitement montrent dans le sang : créatinine 72 μ mol/L, sodium 141mmol/L, potassium 3,3 mmol/L. Dans les urines de 24 heures : sodium 252 mmol, potassium 110 mmol/24 heures. L'activité rénine mesurée au niveau du sang veineux périphérique s'élève à 10 fois la normale.

Indiquer les éléments de l'énoncé qui orientent vers une HTA secondaire à une sténose de l'artère :

- A. jeune âge
- B. sexe féminin
- C. chiffres tensionnels élevés d'emblée
- D. hypokaliémie, évoquant une HTA endocrinienne ou réno-vasculaire

Les facteurs, présents dans l'énoncé, pouvant aggraver l'hypertension :

- A. Prend des oestroprogestatifs
- B. élévation du taux de sel dans les urines

Les arguments de la liste suivante qui orientent vers une hypertension réno-vasculaire chez un homme de 58 ans atteint d'une hypertension artérielle sévère.

- A. Tabagisme important
- B. HTA familiale
- C. Signes palpatoires et auscultatoire d'athérome des membres inférieurs
- D. Obésité
- E. HTA résistante à une trithérapie bien conduite

Pour y remédier, il faut :

- A. supprimer les facteurs en cause avant le traitement de la sténose
- B. arrêter l'oestroprogestatif,
- C. réduire la consommation de sel

MME. Sention, 46 ans vous consulte pour Céphalée frontale et matinale, Insomnie, Bourdonnement d'oreille, Vertiges, Mouches devant les yeux, Asthénie, Sensation de doigts morts.

Affection à laquelle vous pensez

- A. Insuffisance cardiaque
- B. Hypertension artérielle
- C. Infarctus du myocarde à la phase aigue
- D. Accident vasculaire cérébral ischémique
- E. Œdème aigu du poumon cardiogénique

Parmi les examens ci-dessous, lequel n'entre pas dans le bilan de retentissement d'une HTA

- A- Fond d'œil
- B- Echographie cardiaque
- C- Electrocardiogramme
- D- Créatininémie
- E- Ionogramme urinaire

Parmi les items suivants quels sont ceux qui constituent les indicateurs de risque de survenue d'une hypertension artérielle :

- A- Des facteurs individuels (âge, sexe, surpoids, diabète)
- B- Des facteurs d'environnement (consommation de sodium, alcool)
- C- L'appartenance à une catégorie socio-professionnelle défavorisée

D- La présence d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire

Des chiffres de pression artérielle à 230/120 mm hg sont retrouvés chez Mme sention. Quelle est la circonstance clinique où cette HTA doit être respectée ?

- A- Grossesse
- B- Dissection aortique
- C- Infarctus du myocarde à la phase aigue
- D- Accident vasculaire cérébral ischémique
- E- Œdème aigu du poumon cardiogénique

Une hypertension artérielle est fréquemment retrouvée dans les pathologies suivantes sauf :

- A- Un bloc auriculo-ventriculaire
- B- Une insuffisante aortique
- C- Une insuffisance surrénale aigue
- D- Une hyperthyroïdie
- E- Une greffe hépatique

Quel est le signe, parmi les suivants, qui peut orienter vers une hypertension artérielle(HTA) non essentielle ?

- A- Antécédent familial d'HTA
- B- HTA modérée
- C- Race noire
- D- Début d'HTA à 60 ans
- E- Souffle para ombilical gauche

En présence d'une poussée hypertensive, dans quel cas ne préconisez-vous pas de traitement antihypertenseur, en urgence ?

- A. Œdème aigu
- B. Dissection aortique
- C. Accident vasculaire de type ischémique
- D. Hémorragie méningée
- E. Hémorragie cérébrale

Lors de la survenue d'un accident vasculaire cérébral ischémique avec tension artérielle élevée, on peut adopter toutes les attitudes sauf une, laquelle ?

- A. Hospitalisation du sujet
- B. Mise en place de sérum glucosé
- C. Mise en place d'oxygène par voie nasale
- D. Traitement hypertenseur
- E. Intubation

L'hypertension artérielle (HTA) peut être secondaire à une pathologie spécifique. Lesquelles des maladies ou anomalies suivantes peuvent être responsable d'une HTA ?

- A. Sténose d'une artère rénale
- B. Hyperthyroïdie
- C. Glomérulonéphrite
- D. Hémorragie méningée
- E. Maladie de marfan

Une hypertension artérielle est fréquemment retrouvée dans les pathologies suivantes sauf :

- A- Un bloc auriculo-ventriculaire
- B- Une insuffisante aortique
- C- Une insuffisance surrénale aigue
- D- Une hyperthyroïdie

E- Une greffe hépatique

Une femme de 56 ans, hypertendue présente une déstabilisation de ses *chiffres tensionnels* à la mesure clinique sur plusieurs mesures consécutives. Quel est l'argument qui peut faire évoquer une origine réno-vasculaire ?

- A. Sexe Féminin
- B. L'âge de la patiente
- C. Dégradation simultanée de sa fonction rénale
- D. Variabilité importante des mesures sur holter PA
- E. Antécédents familiaux d'HTA

Quels sont les arguments de la liste suivante qui orientent vers une hypertension réno-vasculaire chez un homme de 58 ans atteint d'une hypertension artérielle sévère ?

- A. Tabagisme important
- B. HTA familiale
- C. Signes palpatoires et auscultatoire d'athérome des membres inférieurs
- D. Obésité
- E. HTA résistante à une trithérapie bien conduite

Quels sont les différents organes dont l'hypertension artérielle peut avoir un retentissement ?

- A. Retentissement cérébral (cerveau)
- B. Retentissement oculaire (œil)
- C. Retentissement cardiaque (cœur)
- D. Retentissement rénal (rein)

L'hypertension artérielle peut se manifester par :

- A. des céphalées,
- B. des vertiges,
- C. une épistaxis
- D. des acouphènes.

L'effet blouse blanche au cours de l'hypertension artérielle est :

Le terme correspondant à l'augmentation de la pression artérielle liée au stress provoqué par la présence d'une infirmière ou d'un médecin.

On définit une *urgence hypertensive* comme une décompensation rapide et progressive de la fonction d'un organe vital causée par une augmentation inappropriée de la TA. : Vrai
Faux

L'urgence hypertensive se définit par :

- A. un chiffre spécifique,
- B. une manifestation évidente d'une dysfonction aiguë dans les systèmes cardiovasculaire, neurologique ou néphrologique.
- C. L'élévation des chiffres tensionnels du minima et du maxima

Au cours d'une anémie, l'infirmier doit rechercher

- A. Une polyarthrite ;
- B. Altération de l'Etat Général avec asthénie et fièvre ;
- C. Des anomalies cardiaques à l'auscultation ;
- D. Des douleurs abdominales et troubles digestives ;
- E. Des troubles neurologiques ;
- F. Hématurie microscopique

La syncope est une perte de connaissance brutale, totale et brève, spontanément réversible en 1 à 2 minutes.

Vrai Faux

Au cours de l'arrêt cardio-circulatoire, quelles procédures doivent être systématiquement mises en œuvre d'emblée?

- A - Le massage cardiaque externe
- B - La ventilation artificielle précoce
- C - Un enregistrement le plus précoce possible de l'ECG
- D - L'utilisation de Bicarbonates
- E - L'utilisation de gluconate de calcium

Un état de choc peut être engendré par :

- a. une hypoventilation.
- b. une chute de la volémie.
- c. une anémie.
- d. une altération de l'extraction de l'oxygène liée à une hémorragie.

Le choc hypovolémique est lié à :

- a. une baisse brutale du volume sanguin circulant.
- b. une réaction immuno-allergique.
- c. une atteinte de la pompe cardiaque.
- d. un obstacle sur les voies d'éjection.

Parmi les signes cliniques communs des états de choc, on retrouve :

- a. une hypoxie.
- b. une hyperventilation.
- c. des marbrures.
- d. une oligurie.
- e. une bradycardie.

Appareil uro-génital

Quelle différence faites-vous entre néphropathie aiguë et glomérulonéphrite ?

Néphropathie : Groupe de maladies rénales caractérisé par une réaction inflammatoire des néphrons

Glomérulonéphrite : Groupe de maladies rénales caractérisé par une réaction inflammatoire des glomérules.

La différence entre urologie et néphrologie est :

Urologie= étudie et traite les maladies des voies urinaires. C'est une discipline essentiellement chirurgicale

Néphrologie= étudie et traite les maladies du parenchyme rénal. C'est une discipline purement médicale

Les signes cliniques d'une glomérulonéphrite :

- A. Hématurie
- B. oligurie.
- C. anurie dans de rare cas pendant un à deux jours
- D. Urine foncée avec d'importantes quantités de protéines

Un syndrome néphrotique est un trouble clinique caractérisé par :

- A. une protéinurie marquée
- B. une hypo albuminémie
- C. un œdème
- D. une hypercholestérolémie.

Cas : Mlle D. 19, ans, se présente au service des urgences pour des douleurs du flanc droit accompagnées de fièvre à 39,5°C et de frissons. Mlle D. n'a aucun antécédent médical. Les douleurs sont apparues depuis 5 jours, irradiant à la fosse lombaire droite et à la fosse iliaque, sans troubles mictionnels. Elles sont mal calmées par le paracétamol (doliprane) à raison de 3 comp. /j. A l'examen, la palpation lombaire réveille la douleur. Les urines sont troubles et la bandelette montre : protéines ++, sang ++, leucocytes +++, nitrites ++.

L'interrogatoire ressort une notion de dysurie et envies fréquentes d'uriner. Le diagnostic évoqué est une pyélonéphrite aiguë.

Le médecin demande des examens qui donnent les résultats suivant : dans le sang, créatinine 95 µmol/L (normale < 115), leucocytes 15 00 :mm³ (normale 5 000-8 000). Sont en outre prélevées des hémocultures et des urines pour un examen bactériologique.

La pyélonéphrite aiguë est :

- A. une infection bactérienne du bassinet et du tissu interstitiel d'un rein ou des deux reins.

Indiquer deux maladies avec lesquelles on peut confondre la pyélonéphrite aiguë :

- A. para- néphrite,
- B. la nécrose papillaire,
- C. la cholécystite aiguë,
- D. la pancréatite,
- E. le diverticule,
- F. la pneumonie,
- G. l'embolie de la base du poumon
- H. chez la femme : la salpingite, la torsion d'un kyste ovarien.

En dehors des examens adressés au laboratoire, quelles sont les démarches qui peuvent être utilement réalisées par l'infirmier avant la mise en route d'un traitement antibiotique ?

- A. refaire un examen d'urine avec un antibiogramme pour isoler le germe
- B. échographie rénale
- C. radiographie de l'arbre urinaire sans préparation, indispensable pour vérifier l'absence d'obstacles comme un calcul.

Quelles sont les informations à donner à la patiente relatives à la conduite du traitement ?

- A. les informations à donner à la patiente relatives à la conduite du traitement :
 - B. l'administration des antibiotiques (à forte dose ou énergique) doivent être administrés pendant 24 heures par voie injectable puis relayés si la fièvre tombe par voie orale.
 - C. demander à la patiente de poursuivre le traitement oral pendant plusieurs semaines après la sortie de l'hôpital même si les problèmes urinaires ont complètement disparus.
 - D. Revenir au RDV pour un contrôle
- Prendre des précautions après les rapports sexuels : uriner immédiatement après les rapports sexuels, prendre un antibiotique par voie orale après les rapports sexuels.

Cas : M., 44 ans, est hospitalisé pour des douleurs lombaires droites à irradiations descendantes (le long du trajet urinaire vers les organes génitaux externes), à paroxysmes intolérables, accompagné de nausées, d'agitation++, d'une impossibilité de trouver une position antalgique. Il exerce le métier de boucher. Il a une activité sportive très régulière. Il transpire beaucoup après chaque effort prolongé. C'est un gros mangeur de viande et il apprécie les alcools et le tabac. Très souvent après l'exercice (volley-ball, tennis ou course à pied), il souffre de douleurs lombaires droites rapidement régressives et a des urines foncées. Il s'agit donc d'une colique néphrétique.

Le médecin demande des examens du sang qui donnent les résultats suivants : créatinines 122 $\mu\text{mol/L}$ (normale < 115), leucocytes 7 000/ mm^3 (normale 5 000- 8 000). Sont en outre prélevées des urines, pour un examen bactériologique. Une échographie rénale et un ASP sont demandés.

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la définition de la colique néphrétique

- A. La colique néphrétique est une douleur de distension aigue de la voie d'excrétion.

Les activités à effectuer chez un malade suspecté de souffrir de colique néphrétique :

- A. calmer le patient
- B. lui demander s'il prend des AINS
- C. arrêter immédiat de tout apport liquidien. (La diminution du débit urinaire permet de réduire la tension des voies excrétrices)
- D. tamiser toutes les urines dès constatations de la crise, afin de récupérer un éventuel calcul émis
- E. Administrer le traitement prescrit
- F. maintenir la restriction hydrique jusqu'à sédation complète des douleurs.

La diminution du débit urinaire chez un malade suspecté de souffrir de colique néphrétique permet de réduire la tension des voies excrétrices :

- A. Vrai
- B. Faux

Le calcul au cours de la colique néphrétique a été éliminé. Indiquer ce que vous conseillerez à M.M. pour prévenir les récives

- A. maintenir son activité physique et sportive

- B. modérer l'alimentation pour obtenir des apports caloriques permettant une perte de poids lente et progressive
- C. réduire la quantité de viande, d'abats et d'apports sodés
- D. s'hydrater abondamment pour assurer une diurèse aqueuse.

Citer les examens biologiques d'urgence à pratiquer.

- A. Urée sanguine ; créatinine ; pH urinaire
- B. ECBU
- C. bilan phospho-calcique sanguin et urinaire
- D. hémoculture en cas de pic fébrile ou d'hypothermie

Parmi les examens radiologiques suivants, cocher celles qui sont utiles au diagnostic de la colique néphrétique :

- A. Abdomen sans préparation pour rechercher des calculs radio-opaques.
- B. Urographie intraveineuse permettant de situer le ou les calculs et d'éliminer les fausses images de calculs, précise le retentissement du calcul sur la voie d'excrétion et sur le rein ; recherche une cause possible à cette lithiase
- C. Echographie sans grand intérêt sauf dans le cas d'IRA.

La demande d'un Abdomen sans préparation au cours de la colique néphrétique permet de situer le ou les calculs et d'éliminer les fausses :

Vrai Faux

Donner deux diagnostics différentiels en cas de colique néphrétique.

- A. Tumeurs pelvienne
- B. cancer prostatiques
- C. tumeur vésicale
- D. tuberculose
- E. bilharziose
- F. malformation congénitale ou acquise de la voie excrétrice.

CAS : un malade de 23 ans, consulte pour une hypertension artérielle. L'examen à l'entrée indique que Monsieur PIQUINI est pâle, facilement essoufflé à l'effort modéré. il dit avoir peu d'appétit depuis quelques semaines et même quelques nausées matinales, mais il n'a perdu de poids. En effet, il présente des œdèmes des membres inférieurs bilatéraux gardant le godet. Il signale également des crampes musculaires nocturnes. La pression artérielle mesurée au repos est de 204/107 mmHg.

Le bilan effectué montre une augmentation de l'urée 50mmol/L, la créatinine 1240mmol/L, le sodium 140mmol/L. L'hémogramme montre une anémie à 9,1g/100Ml d'hémoglobine. Il existe une protéinurie et une hématurie. Au vu des résultats le médecin pose le diagnostic d'insuffisance rénale

L'insuffisance rénale est : la défaillance rapidement progressive, souvent transitoire, de la fonction excrétrice rénale, empêchant le maintien de l'équilibre interne nécessaire au fonctionnement normal de l'organisme.

L'hématurie est définie :

- A. la présence de sang dans les urines
- B. La coloration des urines par le sang
- C. L'émission d'urine suivie de sang

En présence de l'insuffisance rénale, les anomalies cliniques que présente le malade sont :

- A. Hypertension artérielle,
- B. Œdèmes des membres inférieurs bilatéraux,

- C. pâleur,
- D. essoufflement,
- E. anémie,
- F. anorexie
- G. nausées,
- H. crampes musculaires.

Face à une insuffisance rénale, que faut-il faire dans l'immédiat, en dehors du traitement par dialyse :

- A. mettre en place une restriction hydrique :
- B. Conseiller un régime désodé strict
- C. traiter l'hypertension par des diurétiques et des vasodilatateurs
- D. faire une supplémentation en calcium et vitamine D
- E. réduire la consommation de phosphore
- F. traiter l'anémie par recharge en fer.

Indiquez les interventions infirmières face à l'insuffisance rénale aigue :

- A. Dépister les complications
- B. Participer au traitement d'urgence des déséquilibres hydro-électrolytiques
- C. Evaluer le progrès du client
- D. Rencontrer la famille et les informer de l'état du patient
- E. Expliquer au malade et à la famille les différents traitements
- F. Prendre les mesures destinés à traiter les troubles tels que le choc, le traumatisme...
- G. Surveiller les entrées et les sorties, les œdèmes, la distension des veines jugulaires pour dépister le déséquilibre hydrique
- H. Vérifier minutieusement les solutions parentérales, les substances ingérées par voie orale ainsi que les médicaments pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de potassium.
- I. assurer le contrôle des examens biologiques de façon régulière
- J. conseiller un repos strict au lit
- K. surveiller les signes cardiaques et musculo-squelettiques d'hyperkaliémie
- L. assurer l'intégrité de la fonction pulmonaire et prévenir l'ectasie et les infections pulmonaires en aidant le malade à changer de position régulièrement, à tousser et à respirer profondément.
- M. Assurer les soins d'hygiène et de propreté et le confort du malade
- N. En cas de dialyse offrir aide et réconfort au malade, à sa famille et à son entourage.

Dans les cystites urinaires :

- a- la fièvre et les douleurs lombaires sont fréquemment retrouvées (ds pyélonéphrite)
- b- un ECBU doit systématiquement être réalisé (seulement si cystite compliquée, récidivante)
- c- La bandelette urinaire détecte l'activité nitrate réductase des bactéries et la présence de leucocytes.
- d- Sa sensibilité est de 100%
- e- sont traitées systématiquement par fluoroquinolones

Le traitement minute d'une infection urinaire :

- a- s'adresse uniquement aux femmes jeunes (≤ 65 ans)
- b- est recommandé lors de pyélonéphrite
- c- peut être utilisé si le début de l'infection date de moins de 3 jours
- d- est contre indiqué chez les femmes enceintes

e- est possible chez l'homme

Les facteurs de risques d'infections urinaires sont :

- a- l'âge (début acte sexuelle, post ménopause, □ □ avec l'âge chez l'homme)
- b- la présence d'uropathie malformative
- c- un sondage urinaire
- d- sexe féminin
- e- neuropathies diabétiques

Pour un ECBU, l'urine peut être recueillie :

- a- urine de milieu de jet dans un pot stérile le matin après toilette
- b- dans le sac collecteur à urine d'un patient sondé (il existe un orifice de prélèvement au niveau de la sonde)
- c- par poche stérile autocollante chez les nourrissons
- d- par ponction sus pubienne
- e- par sondage vésicale

Quelles sont les affirmations fausses ?

- a- une septicémie peut être une complication de pyélonéphrite
- b- une cystite aigue peut être une complication de pyélonéphrite
- c- un abcès rénal être une complication de pyélonéphrite
- d- Faire un Gram si le clinicien demande un recherche de *Mycobacterium tuberculosis* (faire une coloration de Ziehl)

Les reins sont situés dans la cavité rétro péritonéale de part et d'autre de la colonne vertébrale dans la fosse lombaire

- A. Vrai B. Faux

On parle d'insuffisance rénale terminale lorsque :

- A. la clairance de la créatinine est < 10 ml/minute.
- B. la clairance de la créatinine est < 20 ml/minute.
- C. la clairance de la créatinine est < 15 ml/minute.

Un rein malade provoque l'augmentation des ions au niveau du sang sauf un lequel :

- A. Urée B. Créatinine C. Calcium D. Potassium

Lors de l'atteinte du rein, les troubles digestifs sont signes de l'augmentation de l'urée :

- A- Vrai B- Faux

En cas d'hématurie, l'infirmier surveille :

- A- Cystite B- Constantes C- Anticoagulant

Une surveillance attentive de l'hémorragie après une adénomectomie est de :

- A. Empêcher la formation et la rétention de caillots dans la vessie
- B. Surveiller l'état des téguments et prévenir les escarres
- C. Lors de l'atteinte du rein, les troubles digestifs sont signes de l'augmentation de l'urée : Veiller à la perméabilité de la sonde urinaire pour assurer la vacuité de la vessie

Devant une insuffisance rénale aigue, le rôle de l'infirmier consiste à :

- A. Observer l'apport liquidien, le débit urinaire, les variations de poids, la présence d'œdème, la distension des veines jugulaires
- B. Éliminer les fausses images de calculs, préciser le retentissement du calcul sur la voie d'excrétion et sur le rein

- C. Demander à la patiente de poursuivre le traitement oral pendant plusieurs semaines après la sortie de l'hôpital même si les problèmes urinaires ont complètement disparus

Encerclez la lettre correspondant à la bonne définition de l'urologie

- a) Traite les maladies du paralyse rénal
- b) Etudie les maladies des voies urinaires
- c) Etudie et traite les maladies des voies urinaires
- d) Etudie et traite maladies du parenchyme rénal

Encerclez la lettre correspondant à la bonne définition de la néphrologie

- a) Traite les maladies des voies urinaires
- b) Etudie les maladies du parenchyme rénal
- c) Etudie et traite les maladies du parenchyme rénal
- d) Etudie et traite les maladies de l'appareil urinaire

L'urologie est une discipline chirurgicale: Vrai faux

La néphrologie est une discipline médicale; Vrai faux

Coche le ou les caractéristiques de la dysurie franche

- a) Douleurs pelviennes
- b) Globe vésical
- c) Lenteur de la miction
- d) Impossibilité de pisser
- e) Faiblesse du jet

Encerclez la lettre correspondant à la caractéristique de la dysurie vésicale complète

- a) Attente
- b) Faiblesse du jet
- c) Agitation
- d) Globe vésical

Encerclez la lettre correspondant à la définition de la pollakiurie

- a) Trouble portant sur la fréquence normale des mictions
- b) C'est la fréquence exagérée des mictions
- c) Trouble de la fréquence des mictions
- d) Trouble de la fréquence normale élevée des mictions

Entourez les lettres correspondant à la bonne définition de la polyurie

- a) La polyurie est d'abondance excessive par jour
- b) Le volume quotidien des urines dépasse trois (03) litres
- c) Les urines dépassent trois (03) litres
- d) Diurèse supérieure à trois (03) litres

La Polyurie du diabète insipide vrai est due à : Cochez la bonne réponse.

- a) L'anomalie des cellules tubulaires
- b) L'absence de sécrétion d'hormones antidiurétiques à la suite de lésion neuro-post-hypophysaire

- a) La présence de liquide lymphatique des urines
- b) C'est l'effraction lymphatique dans les voies urinaires
- c) C'est la présence de pus dans les urines
- d) C'est la présence de la lymphe mêlée de sang

La présence de liquide lymphatique donne aux urines un aspect graisseux.

Vrai faux

Encerle deux (02) lettres correspondant aux signes de la colique néphrétique.

- a) Agitation
- b) Troubles digestifs
- c) Globe vésical
- d) Dysurie masquée.

L'hémoglobinurie se reconnaît à la couleur rouge vif des urines

Vrai faux

La présence de myoglobine donne aux urines une couleur allant au brun foncé.

Vrai faux

Les examens diagnostiques ci-après sont évocateurs de la glomérulonéphrite aigue, sauf un, lequel ?

- a) Hématurie
- b) Oligurie
- c) Anurie
- d) Œdème pulmonaire

Cochez la mauvaise réponse. Les éléments ci-après favorisent glomérulonéphrite aigue ; sauf un, lequel ?

- a) Angine
- b) Scarlatine
- c) Furoncle
- d) Hépatite B

Cochez deux (02) éléments de complication des glomérulonéphrites aigue.

- a) Œdème pulmonaire
- b) Insuffisance cardiaque
- c) Encéphalopathie hypertensive
- d) Hématurie.

La glomérulonéphrite post-streptococcique provoque souvent une diminution du taux des antistreptolysines O.

Vrai faux

Dans la glomérulonéphrite chronique, la protéinurie est inconstante. Vrai faux

Dans la glomérulonéphrite chronique, l'hématurie microscopique est constante.

Vrai faux

Dans la glomérulonéphrite chronique, certaines épreuves de laboratoire sont anormales. Lesquelles ? Cochez-les.

- a) Hématurie
- b) Hyperkaliémie
- c) Acidose métabolique
- d) Hyperglycémie

Dans la glomérulonéphrite chronique, les conséquences ci-après surviennent. Cochez-les.

- a) Anémie
- b) Infection cutanée
- c) Hipoalbunimurie
- d) Baisse de l'acuité visuelle.

Dans la glomérulonéphrite chronique, la radiographie révèle des signes, cochez-les.

- a) Hypertrophie du cœur
- b) Décalcification osseuse
- c) Œdème pulmonaire
- d) Hypercongestion des reins

Dans la prise en charge des patients atteints de glomérulonéphrite chronique, le repos au lit s'impose. A. Vrai B. faux

Dans la prise en charge des patients atteints de glomérulonéphrite, l'infirmière mène des activités suivantes : Cochez-les.

- a) Expliquer au patient et à sa famille ce qui se passe
- b) Multiplier les actions de dépistage
- c) Soutenir le patient et sa famille tout au cours de la maladie
- d) Faire marcher le patient régulièrement.

Le tableau révélateur le plus fréquent de la lithiase urinaire est : cocher la bonne réponse.

- a) Un syndrome douloureux d'origine sciatique
- b) Un syndrome douloureux d'origine lombaire
- c) Un syndrome douloureux d'origine urétéro-pyélique
- d) Un syndrome douloureux d'origine hépato-digestive.

La colique néphrétique traduit : cocher la bonne réponse.

- a) Une rétention aigue de l'arbre urinaire
- b) Une souffrance urinaire aigue
- c) Une mise en tension de l'arbre urinaire
- d) Une pression exercée sur l'arbre urinaire.

L'examen radiologique pratiqué au cours de la lithiase urinaire est : cocher la bonne réponse.

- a) L'urographie intraveineuse d'urgence
- b) L'abdomen sans préparation
- c) Le lavement baryté
- d) La radiographie des reins.

La prise en charge infirmière des patients atteints de lithiase urinaire vise un objectif. Lequel ?

Cocher la bonne réponse

- a) Le soulagement de la douleur et du malaise
- b) L'accompagnement du malade et son entourage
- c) L'alimentation correcte du malade
- d) Le suivi du patient et sa famille.

L'un des principaux objectifs de soins dans la prise en charge infirmière des malades atteints de lithiase urinaire est : cocher la bonne réponse

- a) L'éviction des rechutes
- b) La prévention de l'infection et de l'obstruction
- c) Le maintien d'une bonne hydratation
- d) L'alimentation normale du malade.

Les soins infirmiers aux patients atteints de lithiase urinaire visent l'un des objectifs ci-après : cocher la bonne réponse.

- a) L'acquisition de connaissance sur la prévention des récives
- b) L'accroissement de la satisfaction des besoins du patient
- c) Le développement des réflexes de déglutition
- d) La promotion d'un bon repos.

La prévention de l'infection et de l'obstruction dans la prise en charge infirmière des patients atteints de lithiase urinaire repose sur les activités ci-après : cocher les bonnes réponses.

- a) L'infirmière incite le patient à boire beaucoup d'eau de boisson
- b) L'infirmière aide le patient à marcher
- c) L'infirmière encourage le patient à suivre un régime alimentaire préventif
- d) L'infirmière administre des analgésiques narcotiques.

Dans l'enseignement aux patients et soins à domicile, la prise en charge infirmière repose sur des activités : lesquelles ? Cocher-les.

- a) L'infirmière déconseille l'absorption excessive de la vitamine D et des sels minéraux
- b) L'infirmière fait la promotion d'une alimentation saine
- c) L'infirmière enseigne aux patients comment mesurer le PH urinaire
- d) L'infirmière encourage le développement des réflexes de pratiques sportives

Rhumatologie

Votre père est traité pour gonarthrose et coxarthrose. il présente une arthrite suppurée du genou droit qui a nécessité une hospitalisation et l'immobilisation de sa jambe droite par une gouttière plâtrée. Au cours de l'hospitalisation de votre père vous suspectez une phlébite traitée à la Calciparine. IL présente une hernie hiatale depuis de nombreuses années.

Indiquez les affirmations exactes en ce qui concerne les définitions suivantes :

- A. Gonarthrose est une arthrose affectant le genou,
- B. Coxarthrose est une forme d'arthrose qui touche spécifiquement la hanche,
- C. Hernie hiatale est une situation anormale caractérisée par le passage d'une partie de l'estomac de l'abdomen vers le thorax au travers de l'orifice hiatale du diaphragme.
- D. Arthrose est une affection chronique qui se manifeste par des douleurs persistantes aux articulations causées par l'usure anormale du cartilage et de l'ensemble de l'articulation.

La branche de la médecine qui prend en charge ses affections est la rhumatologie : A. Vrai
B. faux

Dans la polyarthrite rhumatoïde:

- A - Les interphalangiennes distales des doigts sont volontiers atteintes
- B - Le rachis cervical est le seul segment rachidien touché
- C - Les nodules rhumatoïdes, inconstants, sont habituellement observés au cours de polyarthrites sévères
- D - La positivité du latex et du Waaler Rose est nécessaire au diagnostic
- E - Il n'y a pas de ténosynovites rhumatoïdes

Un homme jeune vient consulter pour des lombalgies inflammatoires installées progressivement et associées à une discrète altération de l'état général. Certains éléments peuvent orienter vers le diagnostic de spondylarthrite ankylosante:

- A - Antécédent d'iritis
- B - Antécédent de Talalgies
- C - Sensibilité très importante des douleurs aux anti-inflammatoires non stéroïdiens
- D - Présence d'une péricardite
- E - Eczéma

Les arthrites aiguës dues à la chondrocalcinose articulaire concernent préférentiellement une de ces articulations :

- A - La métatarsophalangienne du gros orteil
- B - Le genou
- C - La hanche
- D - Le coude
- E - L'épaule

Parmi les items suivants, citez la(ou les) cause(s) possible(s) d'anémie par carence en fer:

- A - Saignement muqueux unique mais abondant
- B - Syndrome inflammatoire chronique
- C - Hémolyse intra-tissulaire chronique
- D - Ménorragies chroniques
- E - Thalassémie

Diabète

Un diabète est :

- A. Une hypoglycémie non régulée
- B. Une hyperglycémie non régulée
- C. Une glycémie trop régulée
- D. Une diurèse excessive

Le diabète est une maladie chronique caractérisée par:

- A. un taux de glycémie à jeun égal ou inférieur à 1.10 g/l de sang
- B. un taux de glycémie à jeun égal ou supérieur à 1,26 g/l de sang
- C. un taux de glycémie à jeun égal ou inférieur à 1 g/l de sang.

Un diabétique traité à l'insuline depuis 25 ans est porteur d'une rétinopathie diabétique. Il n'a pas de protéinurie. Il existe un résidu de 100 ml. Une bactériurie à E.Coli est restée à 10.

Parmi les affirmations suivantes, cochez celle(s) qui est (sont) exacte(s) :

- A- Le risque de pyélonéphrite aiguë est élevé
- B - L'infection urinaire est facilitée par les troubles de vidange vésicale
- C - L'hypocontractilité vésicale secondaire au diabète peut favoriser l'infection urinaire
- D - En cas de pyélonéphrite aiguë, le risque de nécrose papillaire est important
- E - Une poussée d'infection urinaire aiguë peut décompenser le diabète.

L'hormone hypoglycémisante est :

- A. la thyroxine
- B. le glucagon
- C. l'insuline
- D. la prolactine
- E. la calcitonine

La glycémie est :

- A. La concentration de glycogène dans le sang
- B. La concentration du glucose dans le sang
- C. La concentration de saccharose dans le sang
- D. La concentration de l'amidon dans le sang

Une hyperglycémie est :

- A. Une glycémie trop faible
- B. Une glycémie nulle
- C. Une glycémie trop importante

Le diabète de type 2 est associé à :

- A. Une résistance des cellules- β du pancréas
- B. Une résistance du glucagon des cellules cibles de cette hormone
- C. Une absence d'îlots de Langerhans dans le pancréas
- D. Une résistance à l'insuline des cellules cibles de cette hormone

Le diabète de type 1 est :

- A. Précoce
- B. Tardive (après 40 ans)
- C. Je ne sais pas

Une glycémie normale est de l'ordre de :

- A) 1 mg.l-1
- B) 1g.ml-1
- C) 1g.l-1
- D) 1mg.ml-1

La valeur normale de la glycémie est comprise entre :

- 0,40g/l à 0,80g/l

- 0,60g/l à 0,90g/l
- 0,50g/l à 0,70g/l
- 0,60g/l à 1,20g/l

Indiquez la bonne affirmation

- A. Les diabètes ont pour seule origine une alimentation déséquilibrée
- B. Le diabète de type 1 se développe dans la majeure partie des cas à la suite d'une obésité
- C. Le diabète de type 2 peut se développer suite à une réaction auto-immune
- D. Un diabète peut-être dû à une prédisposition génétique et à des facteurs environnementaux comme l'alimentation

Le diabète de type 1 est caractérisée par une anomalie au niveau :

- A. De la rate
- B. Du rein
- C. du pancréas
- D. Du foie

Au niveau moléculaire, le diabète de type 1 est associé à :

- A. Une faible concentration en glucose
- B. Une faible sécrétion d'insuline
- C. Forte sécrétion en insuline
- D. Faible concentration en sucre

Comment se nomme la spécialité du médecin dans cette pathologie qu'est le diabète ?

- A. Néphrologue
- B. Endocrinologue
- C. Diabétologue
- D. Urologue
- E. Biochimiste

Propriétés de l'insuline

- A. Elle permet de diminuer la glycémie
- B. Elle est libérée par la cellule bêta du foie
- C. Elle peut stimuler l'activation de la lipoprotéine lipase
- D. Elle est en quelque sorte 'l'antagoniste' du glucagon concernant la régulation de la glycémie.

Le seuil Rénal du glucose est de :

- A. 0,60g/l
- B. 0,80g/l
- C. 1,20g/l
- D. 1,80g/l

Dans le diabète insipide on note :

- Une polyphagie et une polyurie
- Une polydipsie et une polyphagie
- Une polyphagie, une polydipsie et une polyurie

Le pancréas a :

- Une fonction
- Deux fonctions
- Trois fonctions
- Quatre fonctions

L'insuline est sécrétée par :

- Les cellules somatotropes

- Les cellules beta
- Les cellules mélanotropes
- Les cellules chromophores

Le glucagon est une

- Hypoglycémiant
- Hyperglycémiant
- Normoglycémiant
- Aucune réponse n'est exacte

Chez le diabétique les aliments suivants sont à prescrire sauf un :

- Les gelées
- Les bonbons
- Le miel
- La laitue

Le diabète insipide :

- A. Est une mutation de certaines aquaporines permettant le passage de l'eau
- B. Amène le patient à excréter beaucoup d'eau dans les urines
- C. Il s'agit d'un sous-genre du diabète de type 2

Il existe deux types de diabète :

- A. le diabète malin et le diabète insidieux
- B. il n'existe qu'un seul type de diabète
- C. le diabète de type 1 et le diabète de type 2.
- D. Le diabète de type 3 et le diabète chronique

Le diabète de type 1

- A. Est observable dans la majorité des cas à partir de l'enfance
- B. Consiste en une dégradation totale de la cellule bêta des ilots de Langerhans

Le diabète de type 1 est :

- A. un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie
- B. un excès de plaquette dans le sang
- C. un excès de globule dans le sang

Quels sont les symptômes du diabète de type 1 ?

- A. polyurie,
- B. polydipsie
- C. vomissement,
- D. diarrhée
- E. anorexie,
- F. apraxie

Le diabète de type 2

- A. Il s'agit d'un diabète dit insulino-dépendant
- B. L'utilisation d'insuline est donc primordiale pour ce type de diabète
- C. Il est généralement retrouvé chez l'adulte
- D. Afin de diminuer l'incidence de la pathologie, il est indispensable d'éviter la sédentarité et de changer ses habitudes de vie : alimentation, sport...

Quels sont les facteurs de risque du diabète de type 2 ?

- A. Une maladie auto-immune
- B. La sédentarité
- C. Une alimentation trop riche
- D. Une glycémie à jeun supérieure à 1.26 g/L

Le diabète de type 2 :

- A. Il n'existe pas
- B. c'est le plus fréquent
- C. c'est le moins fréquent

Le diabète de type 2 est le plus fréquent

- A. c'est le diabète type 1 qui est le plus fréquent
- B. je ne sais pas
- C. il représente 90 % des diabètes

La différence entre diabète sucré et le diabète insipide est :

- A. La glycémie dans diabète sucré
- B. La polyurie dans diabète sucré
- C. La polydipsie dans diabète sucré
- D. La polyphagie dans diabète sucré

Les complications éventuelles du diabète :

- A. Maladies cardio-vasculaires
- B. Insuffisance rénales
- C. Maladies neuro-dégénératives type 'Alzheimer'
- D. Infarctus
- E. Accident Vasculaire-Cérébral

L'atteinte artérielle des membres inférieurs chez les malades diabétiques

- A. N'apparaît cliniquement qu'après plusieurs années d'évolution
- B. Peut s'accompagner d'une atteinte polynévritique
- C. Entraîne constamment une douleur à la marche
- D. Se complique parfois de mal perforant plantaire
- E. Se manifeste à l'artériographie toujours par des lésions distales

On diminue le taux de sucre dans le sang en modifiant son alimentation.

- A. Vrai
- B. faux
- C. peut être

Il n'existe aucun traitement médicamenteux contre le diabète.

- A- C'est vrai il n'existe pas de traitement il faut juste faire attention à notre alimentation avec un bon traitement je peux manger ce que je veux
- B- Faux le médecin peut prescrire des médicaments pour réguler le taux de glycémie.

Parmi leurs effets indésirables on retrouve l'augmentation de la sensation de fatigue dans la vie quotidienne

Quelle proposition à propos du diabète est erronée ?

- A. Dans le cas d'un diabète de type 1, il y a une absence d'insuline
- B. Dans le cas d'un diabète de type 2, il peut y avoir une hyperglycémie
- C. Dans le cas d'un diabète de type 2, il peut y avoir une hypoglycémie

Les incrétines sont des hormones qui inhibent la libération de l'insuline

Quelles informations concernant l'insuline et la glycémie sont vraies ?

- A. Il faut leur administrer de l'insuline avant les repas pour éviter que la glycémie ne baisse
- B. Il y a plus de facteurs glycémiant que de facteurs hypoglycémiant
- C. L'insuline administrée est plus efficace que l'insuline normalement produite par le pancréas
- D. L'insuline va faire rentrer le glucose dans les tissus adipeux

Concernant l'absorption et les effets de l'insuline, cocher les propositions vraies :

- A. L'effort physique augmente l'absorption de l'insuline
- B. Le tabac peut réduire l'absorption du dépôt d'insuline
- C. Les hormones de contre-régulation (glucagon, catécholamines) diminuent la glycémie
- D. L'effet de l'insuline est d'autant plus efficace si le pic insulinaire correspond au pic glycémique

Dans le diabète de type 1, l'insuline est un médicament exogène. Quel est son effet indésirable principal ?

- A. L'hyperglycémie
- B. L'hypoglycémie
- C. L'hypercalcémie
- D. L'hypotension

Concernant le diabète de type 2, les propositions vraies sont :

- A. Il y a souvent une surproduction d'insuline par le pancréas jusqu'à épuisement
- B. Les médicaments antidiabétiques sont oraux
- C. Les médicaments antidiabétiques ont notamment pour effet d'augmenter la sensibilité à l'insuline (metformine)
- D. Les médicaments antidiabétiques ont notamment pour effet de freiner la libération de l'insuline

Quelle molécule/hormone n'intervient pas dans le traitement médicamenteux du diabète de type 2 ?

- A. Les glinides
- B. Les leucotriènes
- C. Les sulfamides hypoglycémiant
- D. L'incrétine

Cas : Mme Annick Lisa, 49 ans vient vous voir dans votre centre de santé, elle est fatiguée, a envie d'uriner fréquemment. Vous lui faites des analyses et observez une glycémie à 1.38g/L

Vous suspectez un diabète de type 1.

- A. Vous confirmez la présence d'un diabète, vous lui faites immédiatement une ordonnance d'insuline
- B. Vous lui expliquez que manger pâtisserie n'est pas la meilleure chose à faire
- C. Vous lui recommandez vivement de s'inscrire dans le club de sport local
- D. Vous lui recommandez d'aller chez un nutritionniste et de venir régulièrement vous voir afin d'empêcher une aggravation de la pathologie.

Satisfaite de vos compétences médicales, Mme Annick-Lisa vient vous voir avec sa sœur et son neveu de 10 ans, assez maigre. Son neveu souffre clairement d'un diabète au vu des analyses :

- A. Vous expliquez aux deux sœurs que l'enfant est malheureusement atteint d'un diabète.
- B. Vous lui faites une ordonnance d'insuline et vous lui apprenez à s'en servir de même que l'analyseur de glycémie
- C. Vous lui faites une prescription de glucagon afin de déclencher une hypoglycémie

- D. Vous informez les deux sœurs que, plus tard une intervention chirurgicale consistant à implanter une pompe à insuline automatique sera envisageable
E. Vous insistez pour que l'enfant change ses repas afin de les équilibrer

CAS ; Mr S.N, 56 ans, diabétique depuis 4 ans, consulte pour une asthénie persistante. Actuellement traité par Metformine (850 mg x /), il prend également une statine (Simvastatine 40 mg) depuis 6 ans.

Le bilan biologique montre les résultats suivants : HbA1c = 7,2%, LDL-c « 1,23 g/l, HDL -c = 0,29 g/l, Triglycérides » 2,94 g /l.

Il a cessé de fumer depuis 6 ans, son SMC est égal à 30,5 Kg/m².

Les facteurs de risque cardio-vasculaire retrouvés chez ce patient sont: (cochez la réponse fausse)

- A. Age supérieur à 50ans
B. Hypo KDL-C
C. Antécédent de tabagisme
D. Hypertriglycéridémie
E. Diabète depuis 4 ans

Pour ajuster le traitement hypolipémiant, il faut: (cochez la réponse fausse)

- A. Prescrire un autre type de statine
B. Obtenir d'abord un bon équilibre glycémique
C. Instaurer une bithérapie antidiabétique
D. Majorer les mesures hygiéno-diététiques
E. Prescrire une bithérapie hypolipémiante (Statine +fibrate) en cas d'échec

Les objectifs glycémiques et lipidiques recommandés sont: (cochez la réponse fausse)

- A. Ramener l'HbA1c en dessous de 6,5%
B. Obtenir un LDL-c inférieur à 1g/l
C. Diminuer le taux de Triglycérides à moins de 1,5 g/l
D. Tenir compte des facteurs de risque associés au diabète, à savoir l'âge supérieur à 56 ans

La phase d'intensification hygiéno-diététique et d'équilibration du diabète est de : (cochez la réponse juste)

- A. 1 mois
B. 2 mois
C. 3 mois
D. 3 à 6 mois
E. 6 à 12 mois

Si le diabète avait évolué depuis plus de 10 ans avec ces mêmes facteurs de risque: (cochez la réponse juste).

- A. Ce patient devient un diabétique à haut risque
B. L'objectif est d'obtenir un LDL-c inférieur à 1,30 g/l
C. L'objectif est d'obtenir un LDL-c inférieur à 1 g/l
D. A+B
E. A+C

*Le glucose 10% en Y sert à ré-sucrer en cas d'hypoglycémie au cours du traitement : Vrai
Faux*

Le bicarbonate sert à corriger l'acidose : Vrai Faux

Dans la surveillance de ce malade, la conscience, la diurèse, la température, la cétonurie et glycémie capillaire toutes 30 mn n'est pas indispensable : Vrai
Faux

Un diabétique traité à l'insuline depuis 25 ans est porteur d'une rétinopathie diabétique. Il n'a pas de protéinurie. Il existe un résidu de 100 ml. Une bactériurie à E.Coli est restée à 10(6). Parmi les affirmations suivantes, cochez celle(s) qui est (sont) exacte(s) :

- A- Le risque de pyélonéphrite aiguë est élevé
- B - L'infection urinaire est facilitée par les troubles de vidange vésicale
- C - L'hypocontractibilité vésicale secondaire au diabète peut favoriser l'infection urinaire
- D - En cas de pyélonéphrite aiguë, le risque de nécrose papillaire est important
- E - Une poussée d'infection urinaire aiguë peut décompenser le diabète.

L'hypophyse est différente de la glande pituitaire. VRAI FAUX

Un diabète sucré diagnostiqué chez une femme à la 20ème semaine de gestation est dit gestationnel. VRAI FAUX

L'action de l'insuline n'est pas l'équivalent de celle du glucagon. VRAI FAUX

L'ADH agit au niveau de l'anse de Henlé. VRAI FAUX

La quantité de 250ml de sérum à 30% correspond à 75g de glucose. VRAI FAUX

La post hypophyse sécrète l'ocytocine. VRAI FAUX

Un enfant devient diabétique quand il naît de mère Diabétique. VRAI FAUX

La zone glomérulaire produit les minéralocorticoïdes. VRAI FAUX

Le diagnostic de diabète gestationnel se pose au premier trimestre de la grossesse sans signe d'appel. VRAI FAUX

La maladie de BASEDOW est égale à une insuffisance corticosunénalienne. VRAI FAUX

Cochez la ou les lettres correspondant aux bonnes réponses.

Il existe :

- A. Un type de diabète sucré
- B. Deux types de diabète sucré
- C. Trois types de diabète sucré
- D. Quatre types de diabète sucré X
- E. Cinq types de diabète sucré

Il y a diabète sucré lorsque la glycémie à jeun est supérieur à :

- A. 3,00mmol/l
- B. 4,50mmol/l
- C. 5,00mmol/l
- D. 6,00mmol/l
- E. 7,00mmol/l X

Parmi les signes cliniques suivants, un n'est pas fondamental dans le diagnostic du diabète sucré. Lequel ?

- A. Polyurie
- B. Polydipsie
- C. Polyphagie
- D. Polyarthrite X

14° L'hypophyse est formé de:

- A. Un lobe
- B. Deux lobes
- C. Trois lobes X
- D. Quatre lobes

15° Chez les personnes suivantes le diabète doit être recherché :

- A. Les footballeurs
- B. Les alcooliques X
- C. Les athlètes
- D. Les sédentaires X
- E. Les minces

Les gonadostimulines agissent sur :

- A. Le pancréas
- B. Les testicules X
- C. Les surrénales
- D. Les ovaires X
- E. La thyroïde

La prolactine stimule :

- A. Le développement du fœtus
- B. Le développement des seins X
- C. Le développement de l'utérus
- D. Le développement du clitoris

Des quatre femmes, laquelle est obèse :

- A. Taille 1,90m, 85kg de poids
- B. Taille 1,40m, 75kg de poids X
- C. Taille 1,50m, 55kg de poids
- D. Taille 1,70m, 70kg de poids

Avec les bandelettes urinaires, l'on peut rechercher :

- A. La protéinurie X
- B. L'anémie
- C. Le PH X
- D. L'acétone X
- E. La testostérone

Les lecteurs glycémiques donnent des résultats :

- A. Précis
- B. Normale X
- C. Imprécis
- D. Positif ou négatif

Pour réaliser une glycémie avec un lecteur glycémique il faut :

- A. Un désinfectant
- B. Une crème
- C. Une lotion
- D. De l'eau X

Parmi les besoins suivants un est lié à la personne :

- A. S'occuper en vue de se réaliser X
- B. Maintenir la température dans les limites de la normale
- C. Se récréer
- D. Manger et boire

Parmi les valeurs de l'hémoglobine glyquée et leur correspondance en g/l, cocher la réponse juste :

- A. HbA1c 5,0 – 0,97g/l X
- B. HbA1c 4,4 – 1,00g/l
- C. HbA1c 3,3 - 1,50g/l
- D.

Les paramètres suivants peuvent modifier le résultat de la glycémie :

- A. Prise de sang veineux X
- B. Prise de sang artériel X
- C. Prise de vitamine C X
- D. Prise de d'eau fraîche
- E. Prise de tranquillisant

Les Caractéristiques du diabète non insulino-dépendant.

- A. Son début est brutal
- B. Un antécédent familial de diabète
- C. Son début tardif après 40ans X
- D. Survient avant 30 ans
- E. Mauvaise alimentation X

Parmi les complications suivantes une n'est pas aiguë. Laquelle ?

- A. Hyperglycémie
- B. Acidocétose
- C. Rétinopathie X
- D. Hypoglycémie

Les signes suivants sont ceux de l'hypoglycémie sauf un. Lequel ?

- A. Céphalées
- B. Pâleur
- C. Polyurie X
- D. Sueur

Devant une hypoglycémie le rôle de l'agent de santé consiste à :

- A. Faire coucher le malade
- B. Lui donner trois carreaux de sucre X
- C. Contrôler sa glycémie X
- D. Faire en sorte qu'il ne se mord pas la langue X
- E. Conseiller au malade d'aller rapidement à l'hôpital avec sa voiture.

Les complications suivantes sont dues à des micro-angiopathies

- A. Hypotension orthostatique X
- B. AVC
- C. Incontinence urinaire
- D. Angor
- E. Impuissance sexuelle X

Parmi les complications suivantes du diabète sucré une seule est dégénérative. Laquelle ?

- A. Hypoglycémie
- B. Hyperglycémie
- C. Acidocétose
- D. Pied diabétique X
- E. AVC